



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 16

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Mujer de 42 años que acude a la consulta de genética por un diagnóstico reciente de cáncer de endometrio. En base a los antecedentes familiares que constan en la imagen, ¿cuál de los siguientes síndromes es más probable que presente?

1. Poliposis adenomatosa familiar.
2. Síndrome de Lynch.
3. Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario.
4. Síndrome de Cowden.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La imagen nos muestra un árbol genealógico con una enfermedad con patrón de herencia autosómica dominante de predisposición a cáncer, ya que se manifiesta en dos generaciones consecutivas y un padre afecto transmite la enfermedad a su hija. De entre las opciones, el único síndrome de predisposición al cáncer que se manifiesta con los cánceres descritos (endometrio, ovario, y CCR) es el síndrome de Lynch o cáncer colorrectal hereditario no polipósico. Debes saber el síndrome de Lynch tiene riesgo elevado de CCR (hasta 80% y normalmente antes de los 50) y asocian también mayor riesgo de otros tumores (endometrio 15-60%; estómago 0,7-13%; ovario 3-22%; tracto urinario 0,2-25%; intestino delgado 1-12%; cerebro 1,2-3,7%; tracto biliar 0,02-4%; páncreas 1-3,7%). De las otras opciones debes conocer que siguen todas un patrón autosómico dominante, como es habitual en muchos síndromes de predisposición al cáncer, aunque cursan con otros tipos de tumores; la PAF (APC) se asocia a CCR y otros tumores (papilar de tiroides, páncreas); el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario (BRCA1/2) asocia fundamentalmente tumores de mama y ovario; el síndrome de Cowden (PTEN) asocia hamartomas y tumores malignos de mama, tiroides y endometrio.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Paciente de 65 años que acude a urgencias por disminución brusca de agudeza visual en ojo derecho. La retinografía de dicho ojo se muestra en la imagen. Uno de los siguientes tratamientos está indicado para una enfermedad que es un factor de riesgo para esta situación. Indique cuál:

1. Latanoprost y timolol.
2. Flecainida.
3. Hidroxicloroquina.
4. Complejos vitamínicos y antioxidantes.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad muy alta. Primero hay que saber qué patología tiene el paciente: se observan hemorragias retinianas por toda la retina además de un edema de papila; estos

signos son característicos de una trombosis de vena central de la retina. Después, debemos recordar sus factores de riesgo: edad avanzada, hipertensión arterial, hiperlipidemia, diabetes mellitus, anticonceptivos orales, presión intraocular elevada y hábito tabáquico. Por último, hay que conocer el tratamiento de uno de estos factores de riesgo: la presión intraocular elevada. El glaucoma crónico de ángulo abierto se trata con hipotensores tópicos, como el latanoprost (de la familia de las prostaglandinas) o el timolol (de la familia de los beta-bloqueantes).

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Hombre de 70 años exfumador de un paquete al día y bebedor de 2 copas de vino al día consulta por una molestia faríngea de 1 mes de evolución. Se observa exudado amigdalario por lo que se inicia tratamiento antibiótico. El resultado del test de estreptococo es negativo. La clínica persiste y se añade odinofagia con otalgia refleja y leve cambio en el timbre de la voz. Nota un bulto duro de unos 2 cm a nivel II cervical ipsilateral no doloroso. La orofaringoscopia se refleja en la imagen asociada (imagen aumentada en el recuadro resaltado en rojo). ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y su manejo?

1. Resistencia bacteriana a antibioterapia recibida, precisa cultivo de exudado faríngeo con antibiograma para indicación adecuada.
2. Sospecha de absceso periamigdalino izquierdo, será remitido a urgencias de Otorrinolaringología para drenaje quirúrgico.
3. Sospecha de neoplasia maligna de amígdala palatina, será remitido preferente-urgente a Otorrinolaringología.
4. Sospecha de angina de Plaut-Vincent, remitido a Otorrinolaringología para realización de biopsia de ganglio para estudio de linfoma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico asociado a imagen. Paciente exfumador y bebedor habitual con adenopatía cervical dura, no dolorosa, y lesión ulcerada en la amígdala palatina izquierda, compatible con malignidad. La clínica persiste tras tratamiento antibiótico y el test de estreptococo negativo, lo que descarta infección bacteriana (opción 1). Tampoco hay fiebre, trismus o desviación de la úvula, descartando absceso periamigdalino (opción 2), y la angina de Plaut-Vincent (opción 4) es improbable por no afectar típicamente a este perfil de paciente ni presentar hallazgos compatibles. Se trata de un tumor maligno de amígdala palatina, con factores de riesgo clásicos y una presentación típica. El manejo debe incluir derivación urgente a Otorrinolaringología para biopsia y estudio de extensión.

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Niña de 7 años que acude por otalgia y otorrea purulenta derecha desde hace 3 semanas, tratada

con antibióticos y antiinflamatorios. Tras la resolución de las manifestaciones clínicas, vuelve a aparecer la otorrea por lo que se pauta de nuevo tratamiento antibiótico. A los 5 días se objetiva una tumefacción retroauricular. En la otoscopia se pone de manifiesto una leve retracción de la membrana timpánica, escasa secreción blanquecina en el conducto auditivo externo y una tumefacción retroauricular blanda que ocasiona un mínimo desplazamiento anterior del pabellón auricular. Indique el diagnóstico que sugiere la imagen de resonancia magnética mostrada:

1. Absceso subperióstico extracraneal.
2. Trombosis venosa cerebral.
3. Absceso cerebral retromastoideo.
4. Área de cerebritis retromastoidea.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que ahonda en un tema ampliamente preguntado en el MIR, las complicaciones de la OMA, en este caso una trombosis venosa cerebral, una complicación infrecuente que no se había preguntado hasta ahora. La paciente presenta una evolución típica con otalgia y otorrea purulenta persistente, que progresan a mastoiditis evidenciada por la tumefacción retroauricular y el desplazamiento del pabellón auricular. La resonancia magnética revela hallazgos compatibles con afectación de los senos venosos duros, confirmando el diagnóstico. Las demás opciones son incorrectas: el absceso subperióstico extracraneal no explica los hallazgos intracraneales de la resonancia; el absceso cerebral retromastoideo requeriría clínica de focalidad neurológica más marcada; y el área de cerebritis retromastoidea es más propia de una fase inicial de absceso cerebral, mientras que los hallazgos radiológicos apuntan a una complicación venosa.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Una mujer de 18 años acude a urgencias por dolor abdominal intenso, febrícula, test de embarazo positivo y manchado vaginal de 3 días de evolución junto con líquido libre intraabdominal en la ecografía. Se realiza una laparoscopia en la que se encuentra el siguiente hallazgo tras aspirar sangre de la cavidad abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de los siguientes?

1. Gestación ectópica.
2. Quiste de ovario complicado.
3. Apendicitis aguda.
4. Enfermedad inflamatoria pélvica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico típico de gestación ectópica: mujer con amenorrea de pocas semanas que acude a urgencias con dolor y sangrado escaso. La irritación peritoneal puede producir febrícula, aunque este dato nos puede despistar. Entre las

opciones que nos dan, no obstante, no debemos dudar en marcar la gestación ectópica, ya que la paciente está embarazada. La imagen no es necesaria para el diagnóstico, pero si se sabe interpretar que nos enseñan una trompa de Falopio con una región central abultada llegaremos a la misma conclusión: gestación ectópica. El tratamiento es la salpingectomía.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Hombre de 40 años que presenta cefalea brusca con exploración neurológica normal. Se realiza TC craneal que se muestra en la imagen y una angiografía cerebral en la que no se encuentra patología subyacente. El cuadro clínico más probable es:

1. Hemorragia subaracnoidea traumática occipital.
2. Hemorragia causada por una malformación arteriovenosa angiográficamente oculta.
3. Hemorragia subaracnoidea perimesencefálica con un probable origen venoso o capilar.
4. Hemorragia causada por una discrasia sanguínea.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta compleja, que necesita de la información de la imagen para contestarse correctamente. El paciente presenta una cefalea brusca y la TC muestra una hemorragia subaracnoidea (HSA), luego se trata de una HSA espontánea (respuesta 1 falsa). No nos comentan antecedentes de enfermedades hematológicas previas que favorezcan la aparición de hemorragias (respuesta 4 falsa). Nos aportan el resultado de una angiografía diagnóstica, que no objetiva patología malformaciones vasculares subyacentes al sangrado, pero esto no nos permite elegir entre las opciones 2 y 3. La imagen ayuda a elegir la opción correcta, mostrando un corte axial de la TC craneal centrado en región mesencefálica donde observamos la hemorragia subaracnoidea alrededor del mesencéfalo. Una HSA de origen venoso o capilar es más probable que tenga una angiografía negativa que una verdadera malformación arteriovenosa. Respuesta correcta: 3.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Hombre de 75 años consulta por un cuadro de dificultad para la marcha de 2 años de evolución de forma progresiva. Presenta reflejos vivos en las cuatro extremidades. Se muestra la RM cervical realizada. Con respecto al cuadro clínico del paciente, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El cuadro de paraparesia puede ser asimétrico.
2. La progresión de la enfermedad es lenta pero puede acelerarse por movimientos de flexión o extensión cervical forzados.
3. Se trata de una enfermedad primaria de motoneurona.

4. La incontinencia urinaria aparece con la progresión de la enfermedad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cuadro presentado en la pregunta es una estenosis de canal cervical. Como en toda pregunta con imagen, lo primero es intentar responderla sin la imagen. Nos exponen un paciente con alteración de la marcha de evolución progresiva y reflejos vivos o exaltados en 4 extremidades, por lo tanto tenemos que ir pensando en alguna patología de primera motoneurona bilateral. Nos dicen además que se hace una RMN cervical, por tanto, es más que razonable pensar en un cuadro de estenosis cervical, cuyo signo más típico, y además precoz en el curso de la enfermedad, es el trastorno de la marcha, que puede ser de naturaleza atáxica por afectación del haz espinocerebeloso. Es típica también la aparición de signos de primera motoneurona con reflejos exaltados, signo de Hoffman o clonus. Así mismo, puede asociar dolor cervical o clínica radicular, y afectación esfinteriana por afectación medular con incontinencia urinaria de urgencia con disinerigia vesicoesfinteriana (opción 4 correcta). Dependiendo del nivel afectado el paciente puede desarrollar tetra o paraparesia, y al afectarse la médula espinal, puede afectar tanto a la primera como a la segunda motoneurona (en este caso por compresión radicular); no obstante, este cuadro es asimétrico porque dependerá de la compresión medular producida en el contexto de una espondilosis cervical, que puede presentar lateralización hacia un lado u otro, y, por tanto, en caso de desarrollar una paraparesia esta puede ser claramente asimétrica; la opción 1 es con ello verdadera (además, es una opción en la que pone “puede”; recordad que no se puede desafiar el poder de un “puede”). La progresión es lenta, produciendo una incapacidad en general leve y con un buen pronóstico; no obstante, flexiones o extensiones forzadas, como las producidas en un contexto traumático, pueden condicionar una compresión medular brusca con desarrollo de una mielopatía cervical aguda, desarrollando el paciente normalmente un síndrome centromedular (de Schneider) con el desarrollo de un cuadro agudo de tetra o paraplejía, afectación esfinteriana, desarrollo de un nivel sensitivo, etc. Por ello, la opción 2 es claramente verdadera. La opción incorrecta es la 3: la ELA o enfermedad primaria de las motoneuronas, que afecta a primera y segunda motoneurona pero no afecta a esfínteres (recordad la regla mnemotécnica: “la ELA son las 2 motoneuronas salvo en ojos y en ojetes”).

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Mujer de 14 años derivada a Rehabilitación para el manejo de una deformidad de la columna vertebral. Tuvo la menarquia a los 10 años. En la exploración física se aprecia mínima asimetría de escápulas, el eje occipito-sacro está centrado y en el test de Adams se observa una gibosidad torácica derecha de 10 mm. Se aporta telerradiografía de columna en proyección antero-posterior. ¿Cuál de los siguientes considera el manejo más adecuado a seguir?

1. Observación, con recomendación específica de ejercicios y revisión posterior.
2. Corsé de Milwaukee a tiempo completo.
3. Corsé de Boston a tiempo parcial.
4. Derivación a cirugía para tratamiento quirúrgico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En la escoliosis idiopática del adolescente el tratamiento se basa, principalmente, en el valor del ángulo de Cobb y crecimiento residual. Con un ángulo de 14°, se trata de una escoliosis leve (<20-30°), para la cual está indicada la observación clínico-radiológica periódica y ejercicios específicos, sin necesidad de tratamiento ortésico ni quirúrgico. Hace 4 años de la menarquia, por lo que el Risser será alto (4-5) y no se espera aumento de la deformidad. El corsé estaría indicado en grados medios con riesgo de progresión (respuestas 2 y 3 falsas)

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Hombre de 60 años de edad que tras dolor brusco y chasquido en hombro presenta la siguiente deformidad en el brazo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Rotura de la porción larga del bíceps braquial.
2. Rotura de la porción corta del bíceps braquial.
3. Rotura del tendón distal del bíceps braquial.
4. Rotura del tendón del pectoral mayor.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La imagen muestra una deformidad característica en el brazo con una masa redondeada en la región anterior del brazo, compatible con el signo de “Popeye” o “bola caída”, típico de la rotura de la porción larga del bíceps braquial (opción 1). Se produce típicamente en varones adultos tras esfuerzo o carga de peso, con dolor súbito en la región anterior del hombro (el origen de la porción larga del bíceps), asociado a un chasquido y seguido de la deformidad en Popeye.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Paciente de 41 años, de talla baja, consulta por dolor en ambas caderas, más intenso en la izquierda. Refiere haber tenido dolor en caderas a edades tempranas aunque nunca consultaron por este motivo. Tras estudio radiográfico de caderas, se decide prótesis total de cadera izquierda, siguiendo buena evolución. Durante el postoperatorio el paciente refiere además dolor en hombros. Ante la sospecha diagnóstica se solicita una telerradiografía. Indique qué proceso es más probable que padezca el paciente desde su infancia:

1. Enfermedad de Perthes.
2. Osteonecrosis multifocal.

3. Epifisiolisis bilateral de cadera.
4. Displasia epifisaria múltiple.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Razonable por descarte y lo atípico de la presentación. Las opciones incorrectas no explican la presentación multifocal: la enfermedad de Perthes (opción 1) afecta a la cabeza femoral pero es típicamente unilateral; la osteonecrosis multifocal (opción 2) suele aparecer en adultos con factores de riesgo como corticoterapia o alcoholismo; y la epifisiólisis de cadera (opción 3) ocurre en adolescentes, generalmente con sobrepeso, y no explica la afectación de otras articulaciones. La displasia epifisaria múltiple (opción 4) es compatible por la imagen que muestra hallazgos característicos: cabezas femorales aplanadas y deformadas, alteraciones en hombros y cambios en rodillas, con afectación bilateral y simétrica.

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Hombre de 40 años que consulta por tumefacción dolorosa en cara interna de rodilla. En el estudio radiográfico se obtiene esta imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Osteomielitis.
2. Osificación heterotópica.
3. Encondroma.
4. Osteocondroma.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La imagen radiográfica muestra una lesión ósea exofítica que protruye desde la metáfisis proximal de la tibia, con continuidad cortical y medular con el hueso subyacente. No se trata de la edad típica de diagnóstico ni la clínica (adolescentes asintomáticos), pero la imagen es clara. El dolor probablemente sea secundario a roce muscular. Se trata del tumor óseo benigno más frecuente y solo se interviene cuando presenta dolor recurrente (como es el caso).

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Hombre de 80 años, fumador. Refiere en los últimos días episodios de mareos no relacionados con el ejercicio ni el estrés, de unos 3-4 minutos de duración. Solicita atención urgente en su domicilio tras presentar un síncope, con pérdida completa de conciencia, de unos 15-20 segundos de duración. La presión arterial es 110/40 mmHg. Se obtiene el ECG de la imagen. ¿Cuál es su diagnóstico?

1. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, anterior.
2. Bloqueo auriculoventricular de primer grado.
3. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo II.
4. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante un paciente que consulta en el MIR por síncope, tenemos que sospechar una bradiarritmia. En este caso, es necesario interpretar el ECG para llegar al diagnóstico. Se trata de un ECG difícil, para el que adjuntamos una imagen explicando sus principales hallazgos. Lo más probable es que se trate de un bloqueo aurículo-ventricular (BAV) avanzado, un subtipo de BAV en el que la mayoría de ondas P no están conducidas, pero en el que alguna onda P todavía conduce (esto es, un grado “intermedio” entre el segundo grado “normal” y el BAV completo). En estos BAV avanzados, como la mayoría de ondas P no conducen, pueden desarrollarse ritmos de escape (como en un BAV completo) que coexistan con las ondas P no conducidas (disociadas) pero también con las conducidas. En el ECG explicado se marcan las ondas P (asteriscos), los latidos de escape que tiene el paciente (E), y otros latidos probablemente conducidos (flechas rojas), dado que el QRS se adelanta respecto a donde debería aparecer el ritmo de escape del paciente (intervalo RR más corto), y además siempre hay una onda P delante con un PR que impresiona de estar conducido. Otras ondas P que tienen un QRS detrás no están en cambio conducidas por tener un PR demasiado corto (esas ondas P están realmente disociadas del QRS siguiente, que es un latido de escape): serían las ondas P número 4, 9 y 12 empezando por la izquierda. Ninguna de las opciones correctas indica un BAV avanzado, pero la que más se aproxima sería un BAV completo (el paciente tiene un BAV “casi” completo), que sería la opción a marcar. No obstante, la pregunta debiera haberse anulado dado que ninguna opción es correcta.

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Hombre de 75 años que consulta por palpitaciones de aparición súbita hace 1 hora, sin dolor torácico ni cortejo vegetativo asociado. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, hipertrofia benigna prostática y accidente isquémico transitorio hace 12 años. PA 180/109 mmHg, FC 126 lpm, Sat O2 98%. Auscultación cardíaca tonos rítmicos, sin soplos audibles. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Se realiza ECG que se muestra en la imagen. Indique, de los siguientes, el diagnóstico más probable:

1. Fibrilación auricular.
2. Flutter auricular.
3. Infarto agudo de miocardio.
4. Taquicardia ventricular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que requiere la interpretación del ECG que nos muestran en la imagen para poder contestarla, dado que no nos dan pistas en el enunciado. Se trata de una taquicardia regular de QRS estrecho, y entre las opciones que nos dan la única que se manifiesta así es el flúter auricular. Cuando han preguntado el flúter auricular en el MIR anteriormente,

habitualmente presentaban un paciente con dilatación de cavidades derechas del corazón (siendo lo más frecuente un paciente con hipertensión pulmonar o con EPOC avanzado / cor pulmonale); sin embargo, en este caso no había ninguna pista específica en el enunciado. Interpretando el ECG más detalladamente, se pueden apreciar ondas “F” en dientes de sierra entre los QRS adyacentes, lo que daría el diagnóstico de flúter auricular. Dichas ondas “F” son negativas en cara inferior y positivas en V1, lo que traduce un flúter común (da vueltas alrededor del anillo tricúspide en sentido antihorario). No obstante, no era necesario ser capaz de descubrir las ondas “F” del ECG, dado que, como decíamos, el flúter auricular es la única respuesta que casaría con una taquicardia regular de QRS estrecho; la fibrilación auricular mostraría un ECG irregular, y una taquicardia ventricular tendría el QRS ancho.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Mujer de 69 años, obesa, con historia de apnea obstructiva del sueño, insuficiencia respiratoria hipercápnica, polimialgia reumática e hipotiroidismo de larga evolución. Acude a consulta en su centro de salud con los resultados de una tomografía computarizada solicitada por hallazgo de cardiomegalia en la Rx de tórax. Su frecuencia cardíaca es 68 lpm, y la presión arterial es 145/70 mmHg. Con inspiración profunda, sus cifras tensionales son 139/68 mmHg. Con estos datos clínicos y la imagen de la TC que se muestra, señale qué diagnóstico es más probable:

1. Neumotórax.
2. Taponamiento cardíaco con colapso de cavidades cardíacas.
3. Disección de aorta.
4. Derrame pericárdico crónico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada. En la TAC torácica se aprecia claramente derrame pericárdico (imagen de densidad agua alrededor del corazón). La paciente no tiene datos de taponamiento cardíaco a pesar de la cuantía del derrame (que parece severo en la imagen del TAC), ya que su tensión arterial y presión venosa yugular es normal. Por ello, tendremos que pensar en un derrame pericárdico que se ha ido acumulando lentamente sin provocar síntomas (derrame pericárdico crónico). El taponamiento es un diagnóstico clínico que implica hipotensión y aumento de presión venosa sistémica (especialmente apreciable como aumento de la presión venosa yugular) en el contexto de un derrame pericárdico.

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Paciente de 72 años con antecedentes de cardiopatía isquémica que acude a Urgencias

por astenia, disnea de esfuerzo y malestar general desde hace dos semanas. En analítica se objetiva hemoglobina 7,1 g/dL, leucocitos 9.330/uL (Neutrófilos 77%), plaquetas 15.600/uL, creatinina sérica 7,6 mg/dL (previa 1,1 mg/dL), Na+ 139 mmol/L, K+ 5,2 mmol/L. Orina: Na+ 121 mmol/L, K+ 213 mmol/L, cociente proteína/creatinina 3,5 g/g, eritrocitos +3, leucocitos +3. Se realiza un TC de tórax que se muestra en la imagen. Indique la actitud más correcta en relación con su diagnóstico y tratamiento inicial:

1. Neumonía atípica con fracaso renal agudo secundario a necrosis tubular aguda y el tratamiento es la administración de antibióticos de amplio espectro y hemodiálisis.
2. Fracaso renal agudo parenquimatoso de probable origen glomerular con hemorragia alveolar asociada y el tratamiento es inmunosupresores y plasmaféresis.
3. Síndrome urémico hemolítico atípico y hay que plantear plasmaféresis y administración de eculizumab.
4. Fracaso renal agudo funcional secundario a insuficiencia cardíaca y hay que iniciar tratamiento con diuréticos a altas dosis y diálisis si no responde.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Paciente con un síndrome reno-pulmonar: daño renal en forma de nefrítico (FRA, hematuria y proteinuria) y daño pulmonar en forma de hemorragia alveolar (disnea, anemia significativa y TC con infiltrados bilaterales, si bien no cuentan hemoptisis). Por lo tanto, la opción CORRECTA es la 2.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Hombre de 68 años, exfumador desde hace 3 meses, con criterios clínicos de bronquitis crónica. Consulta por cuadro de pérdida de peso junto con astenia de un mes y medio de duración. Refiere tos seca ocasional y sensación distérmica sin fiebre termometrada. Tras realizarle la radiografía de tórax se solicita TC torácico que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial.
2. Neumonía organizada criptogénica.
3. Atelectasia obstructiva de lóbulos inferiores por neoplasia central.
4. Neumonía intersticial inespecífica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que puede generar mucha confusión. En el caso clínico nos intentan distraer con un hombre exfumador, con

bronquitis crónica y síndrome constitucional, que puede hacernos pensar en primer lugar en una patología neoplásica. Sin embargo, la clave para contestar la pregunta es la imagen. En la imagen observamos una consolidación en ambas bases pulmonares con broncograma aéreo; esta imagen descarta una atelectasia obstructiva por neoplasia central, ya que la imagen que encontraríamos en ese caso sería una atelectasia unilateral, sin broncograma aéreo (recordemos que la atelectasia es un colapso del segmento, lóbulo o pulmón afecto). La NOC es una gran imitadora, puede hacernos confundir con enfermedad neoplásica o neumonía; cursa de forma subaguda con disnea, tos, expectoración, febrícula/ fiebre, pérdida de peso, astenia y malestar general; en la Rx de tórax se encuentran áreas de consolidación bilaterales periféricas, que con frecuencia son migratorias.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Paciente de 63 años consulta por dolor en flanco derecho, ictericia y aumento del perímetro abdominal. Se realiza ecografía Doppler y TC de hígado como se muestra en la imagen. ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción terapéutica?

1. Colocación de una derivación intrahepática percutánea (TIPS).
2. Anticoagulación oral.
3. Trasplante hepático.
4. Angioplastia percutánea.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La imagen ecográfica nos muestra un hígado hipoperfundido. En el corte que corresponde al eco doppler, vemos que la vena porta se encuentra obstruida y no tiene flujo. Todo ello, junto con el caso clínico, nos habla de una trombosis portal aguda con repercusión clínica y desarrollo de ascitis. Ten en cuenta que no es imprescindible conocer anatomía ecográfica para contestar la pregunta. Ante este caso clínico y teniendo la sospecha de un evento vascular, podríamos plantearnos el diagnóstico diferencial con un Budd-Chiari. Sin embargo, el tratamiento de primera línea en ambos casos va a ser la anticoagulación, y solo nos plantearíamos opciones intervencionistas en caso de fracasar esta última.

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Mujer de 90 años que acude a urgencias por hipotensión, vómitos oscuros y dolor abdominal. Se realiza una TC abdominal que se muestra en la imagen. De las siguientes opciones, ¿cuál es la más probable?

1. Se observa gas en el sistema portal siendo indicativo de mal pronóstico.
2. Se trata de una aerobilia y por tanto el diagnóstico más probable es el de colangitis.
3. Se observa aerobilia y pneumatosis gástrica.
4. Se trata de un hallazgo no relevante en relación con una CPRE o cirugía previa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta radiológica en el ámbito de la cirugía general. Llama la atención sin duda el gas en el hígado y tenemos que recordar que hay dos patrones importantes: gas en el sistema porta que se distribuye más periférico, y gas en el sistema biliar que es MUY típico después de una CPRE y de distribución mucho más centrado en el hilio hepático. Pero más allá de esto, esta pregunta se saca por conocimiento fisiopatológico. Estamos viendo una obstrucción gástrica; como toda obstrucción el aumento de presión dentro del tubo digestivo compromete la vascularización de su pared y esto genera isquemia y después traslocación bacteriana. Es el mecanismo fisiopatológico de las obstrucciones intestinales graves, de la apendicitis aguda, de la colecistitis aguda, etc. La neumatosis intestinal es un hallazgo radiológico bastante frecuente que sin contexto clínico no tiene mayor importancia. Sin embargo, en un contexto de un paciente con proceso patológico activo implica gravedad. Más aún cuando este gas de la pared isquémica de la viscera es absorbido por el drenaje venoso de dicho órgano: en el tubo digestivo (menos el esófago medio y proximal y el recto medio y distal), este gas llega por el sistema porta al hígado. Que haya gas en la pared del intestino y también en el hígado en el sistema portal es un signo de gravedad.

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Hombre de 60 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias con un cuadro de 48 horas de fiebre de 38°C y dolor abdominal en fosa iliaca izquierda. A la exploración abdominal destaca cierta defensa a la palpación sin peritonismo generalizado. La analítica sanguínea solo destaca una discreta leucocitosis. La TC abdominopélvica se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Cáncer de colon izquierdo oclusivo.
2. Síndrome de Ogilvie.
3. Diverticulitis aguda.
4. Megacolon tóxico o infeccioso.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que podemos contestar sin mirar la imagen, dado que la clínica que nos presentan es típica de una diverticulitis aguda: presentación aguda de 48 horas de evolución con dolor en fosa iliaca izquierda asociando clínica infecciosa con fiebre y leucocitosis. Además, si nos detenemos en mirar la imagen podemos ver engrosamiento parietal y deformación de los contornos del divertículo, complicado con aumento de densidad de los planos grasos adyacentes. No existen dudas con las otras respuestas, ya que cursarían con una clínica diferente y la imagen de la TC sería diagnóstica. En un cáncer de colon izquierdo la clínica sería más larvada y no sería infecciosa, y en la TC veríamos la lesión. En el síndrome de Ogilvie la clínica es de tipo obstructiva con distensión abdominal, náuseas y vómitos y en la TC veríamos dilatación de asas del colon sin un cambio de calibre en ningún punto. En

un megacolon tóxico o infeccioso lo que veríamos en la TC sería una dilatación colónica masiva con un transversal >6 cm.

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

Hombre de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que acude a urgencias por presentar desde hace una semana hiperglucemia mayor de 500 mg/dL. Refiere que comenzó con dolor en flanco derecho y vómitos autolimitados. Desde entonces, disminución de la ingesta, poliuria y sensación distérmica sin fiebre termometrada. Se realiza ecografía y TC abdominopélvica sin contraste intravenoso que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Pielonefritis enfisematosa obstructiva.
2. Necrosis papilar renal.
3. Pielonefritis xantogranulomatosa.
4. Absceso retroperitoneal perirrenal por apendicitis aguda evolucionada.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En la imagen se aprecia, a nivel ureteral derecho, una litiasis obstructiva. Este es un caso que requiere derivación urinaria urgente, ya sea mediante catéter doble J o nefrostomía percutánea.

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Mujer de 57 años con enfermedad renal crónica que presenta astenia, hipotensión y cianosis en manos tras una sesión de diálisis. En la analítica se detecta anemia normocítica (Hb 7 g/dL, VCM 96 fL) con discreta reticulocitosis, leucocitos y plaquetas normales; aumento de LDH y hemoglobina libre en plasma elevada. El estudio inmunohematológico muestra un anticuerpo con especificidad anti-P. Se realiza frotis sanguíneo (ver imagen). El diagnóstico más probable es:

1. Síndrome hemofagocítico.
2. Hemoglobinuria paroxística a frigore.
3. Hemoglobinuria paroxística nocturna.
4. Crioglobulinemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La hemoglobinuria paroxística a frigore es un tipo raro de anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpo biséfico, que actúa a temperaturas calientes y frías, concretamente contra el sistema P del hematíe. Se asocia a sífilis terciaria y otras infecciones. Dado que la paciente solo tiene anemia hemolítica, descartamos que se trate de un síndrome hemofagocítico y de una hemoglobinuria paroxística nocturna, pues cursarían con pancitopenia. No confundir crioglobulinemia (enfermedad no hematológica que consiste

fundamentalmente en púrpura) con anemia hemolítica por crioaglutininas (anticuerpos fríos).

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Mujer de 58 años acude a urgencias por dolor en la punta de los dedos de la mano. No tiene alergias conocidas, ni hábitos tóxicos. Entre los antecedentes explica tres abortos, una apendicetomía, sensación frecuente de reflujo retroesternal y, desde hace unos 5 años aproximadamente, presenta con la exposición al frío episodios de palidez en los dedos de ambas manos que cada vez se han hecho más intensos. A la vista de la imagen, ¿cuál de las siguientes actitudes se plantea realizar en primer lugar?

1. Solicitar una TC torácica.
2. Valoración de tratamiento quirúrgico por cirugía vascular.
3. Determinación de ANA y anti-centromero.
4. Tratamiento vasodilatador con prostaglandinas IV.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil sobre el manejo y tratamiento de un caso sin un diagnóstico firmemente establecido, pero altamente sospechoso de esclerosis sistémica a tenor de las manifestaciones representadas en la pregunta, fundamentalmente el fenómeno de Raynaud (descrito como de intensidad cada vez mayor), el reflujo (que hace presumir afectación esofágica) y la aparición de lesiones necróticas en las puntas de los dedos, donde también se ven erosiones en mordedura de rata. Aunque es importante diagnosticar a la paciente, ante el establecimiento de un compromiso vascular tan llamativo (que ha llegado a necrosar tejido) lo primero que se debe hacer es evitar su progresión y limitar en lo posible el daño, para lo cual deberemos emplear vasodilatadores (preferentemente derivados de las prostaglandinas) por vía parenteral. Ya habrá tiempo de ampliar el estudio complementario y establecer definitivamente el diagnóstico con la determinación de anticuerpos y la realización de otras pruebas, así como de solicitar la valoración por Cirugía Vascular (que ahora no es prioritaria, puesto que el tejido ya necrosado no se beneficiaría de la revascularización quirúrgica)

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

En relación con un hombre de 74 años, que muestra alteraciones cognitivas y de la movilidad y en el cerebro neuronas con inclusiones citoplasmáticas, como se observa en la imagen histológica, el diagnóstico más probable es:

1. Enfermedad de Alzheimer.
2. Demencia senil.
3. Enfermedad de Parkinson.
4. Encefalitis viral.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La imagen muestra inclusiones citoplasmáticas de alfa-sinucleína (cuerpos de Lewy), características de la enfermedad de Parkinson, pero que también pueden aparecer en la enfermedad con cuerpos de Lewy y en la atrofia multisistema. La pregunta a priori parece difícil, pero si consideramos un paciente con “alteraciones de la movilidad y trastorno cognitivo”, la respuesta 3 es la más probable.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Mujer de 35 años con historia de dolor abdominal recurrente que coincide con la menstruación. Los hallazgos de la intervención quirúrgica requieren una resección intestinal. El estudio anatomopatológico se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Adenocarcinoma intestinal.
2. Metástasis de adenocarcinoma de endometrio.
3. Colitis ulcerosa.
4. Endometriosis.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Caso clínico de endometriosis profunda, ya que presenta afectación intestinal. Es la localización extragenital más frecuente, que en casos severos puede producir estreñimiento e incluso obstrucción intestinal. No se necesita la imagen para contestar la pregunta: mujer en edad fértil con dolor abdominal cíclico nos debe hacer pensar en endometriosis. En la imagen se visualiza una estenosis intestinal por el nódulo de endometriosis, y al microscopio observamos glándulas endometriales infiltrando el estroma intestinal.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Hombre de 36 años con prácticas sexuales de riesgo. Presenta un cuadro de 4 días de evolución de lesiones cutáneas no pruriginosas. No ha tomado medicación previamente y no tiene antecedente de alergias farmacológicas. Se realiza serología para VIH que es negativa. La serología de sífilis *antitreponema pallidum* es positiva y RPR 1:32. Señale la respuesta correcta:

1. Se recomienda el análisis del líquido cefalorraquídeo.
2. La azitromicina oral es un tratamiento alternativo eficaz.
3. Se recomienda una valoración clínica y serológica (RPR) a los 6 y 12 meses después del tratamiento.
4. Si los títulos de RPR permanecen positivos después de 12 meses está indicado administrar el tratamiento de nuevo.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta de dificultad media sobre un tema de moda en los últimos MIREs. Nos preguntan acerca de la evolución y seguimiento de la sífilis. Los criterios para realizar punción lumbar son: 1) signos o síntomas de afectación del sistema nervioso central; 2) sífilis terciaria; 3) sospecha de fracaso terapéutico o si los valores de RPR/VDRL tras el tratamiento permanecen >1/32 (opción 4 falsa); 4) aumento sostenido de 4 veces o más en los títulos de RPR/VDRL dos semanas tras el tratamiento apropiado (opción 1 falsa). En el seguimiento se recomienda valoración clínica y serológica a los 6 y 12 meses del tratamiento (opción 3 cierta). Recuerda que ya ha sido preguntado que la azitromicina no es una buena alternativa terapéutica (opción 2 falsa).

26. Entre los cambios metabólicos que se observan en un paciente con resistencia a insulina existe:

1. Incremento de la expresión hepática de genes gluconeogénicos mediado por FOXO1 (forkhead box other) fosforilado.
2. Descenso en los niveles intracelulares de hexoquinasa 2 dependiente de insulina.
3. Aumento de la glucogenólisis muscular, contribuyendo al incremento de la glucemia.
4. Aumento en los niveles séricos de aminoácidos como leucina e isoleucina.

Respuesta correcta: 0**Comentario:**

Pregunta anulada por existir dos opciones correctas, la 2 y la 4 (respuesta inicialmente considerada como correcta por el Ministerio). La resistencia a la insulina afecta principalmente a tejidos sensibles a esta hormona, como el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo. En el músculo, la insulina estimula la captación de glucosa al activar la vía PI3K-AKT, lo que aumenta la actividad del transportador de glucosa GLUT4 y la expresión de enzimas como la hexoquinasa 2, encargada de fosforilar la glucosa para su uso metabólico. En condiciones de resistencia a la insulina, esta vía se encuentra deteriorada; se reducen los niveles de hexoquinasa 2 dependiente de insulina, limitando la capacidad del músculo de captar y metabolizar glucosa, lo que contribuye a la hiperglucemia. Por otra parte, el incremento de aminoácidos ramificados (como leucina e isoleucina) en suero es un marcador de obesidad y disfunción metabólica, vinculado a la resistencia a la insulina. En cambio, son falsas las opciones 1 (la fosforilación de FOXO1 lo inactiva) y 3 (el músculo no puede liberar glucosa al torrente sanguíneo).

27. La deficiencia de acil-CoA-deshidrogenasa provoca una de las siguientes alteraciones bioquímicas:

1. Disminución de ácidos dicarboxílicos.
2. Aumento de la gluconeogénesis.
3. Disminución de la ureagénesis.
4. Aumento de carnitina libre.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Las deficiencias de acil-CoA deshidrogenasa (MCAD, en

su forma más común) afectan la beta-oxidación de los ácidos grasos, especialmente durante periodos de ayuno. Esta deficiencia lleva a la acumulación de ácidos grasos no metabolizados, que se conjugan con carnitina (acil-carnitina), reduciendo la proporción de carnitina libre en suero, y bloqueando la beta-oxidación al impedir la génesis de acetil-CoA. Al no haber aporte alternativo de energía desde las grasas, se restringe la gluconeogénesis. En periodos de alta demanda energética se activan la glucogenólisis hasta agotar reservas (apareciendo crisis hipoglucémicas), junto con la omega-oxidación de ácidos grasos (que genera aumento de los ácidos dicarboxílicos) y el catabolismo de aminoácidos (que genera amoniogénesis que conduce a acidosis hiperamoniémica). El amonio liberado desde aminoácidos no puede transformarse en urea (respuesta 3 correcta) porque aparece disfunción del ciclo de la urea: el déficit energético y el déficit de acetil-CoA impiden la acción de la carbamoil-fosfato sintetasa, bloqueando el paso inicial del ciclo de la urea.

28. Respecto a la técnica de exploración de la motilidad pupilar y sus reflejos indique la respuesta INCORRECTA:

1. El reflejo de la visión próxima se explora con una linterna que se enfoca sobre las pupilas de forma alternativa.
2. El signo pupilar de Marcus Gunn o defecto pupilar aferente relativo está presente en enfermedades del nervio óptico y enfermedades retinianas no extensas.
3. El reflejo fotomotor consensuado está afectado cuando el daño implica la vía eferente vehiculada por el nervio motor ocular común.
4. La anisocoria que aumenta en condiciones de oscuridad mostrando una pupila más midriática se debe a que hay un trastorno en el sistema simpático.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

“Pregunta de dificultad alta. Ha sido anulada por tener dos opciones falsas. El enunciado versa sobre las respuestas pupilares y su exploración. Tienes que recordar que existe: Reflejo fotomotor directo. - Reflejo fotomotor consensuado. El estímulo luminoso incide sobre uno de los dos ojos, activando la contracción en los dos ojos, por una respuesta que viene del mesencéfalo a través del nervio oculomotor (III par o motor común) de ambos ojos (opción 3 correcta). - Reflejo de proximidad o de acomodación. No requiere que haya visión. Es una sincinesia de tres músculos (miosis, convergencia y acomodación) activada cuando la mirada cambia de un objeto lejano a uno cercano. Se explora pidiendo al paciente que mire un objeto que acercamos progresivamente hasta casi la frente, observando la miosis que se produce. Comparamos dicha miosis con la que obtenemos por reflejo luminoso al pedir al paciente que mire un objeto lejano. La miosis que se produce por el estímulo luminoso deber ser igual o mayor al de la visión próxima. Si un paciente tiene un reflejo fotomotor normal, no tiene ninguna utili-

dad clínica explorar el reflejo de visión próxima, ya que no existe ninguna enfermedad en la que se observe un reflejo fotomotor con ausencia de reflejo de proximidad. El defecto pupilar aferente relativo (o signo de Marcus Gunn, preguntado en otra ocasión en el MIR también por este nombre propio), es consecuencia de un daño en el nervio óptico o por lesiones extensas de la retina (no funciona la vía aferente). Se explora con el test de iluminación alternante de las pupilas. El Ministerio de Sanidad dio por falsa la opción 1, pero la 2 también es falsa. Recuerda: el síndrome de Horner se produce por el daño en el sistema simpático (encargado de transportar el impulso eferente para la dilatación de la pupila), por lo que se observará miosis, más relevante en condiciones de baja luminosidad (opción 4 verdadera). “

29. En relación con el proceso de envejecimiento, respecto a los principales cambios morfológicos de los aparatos y sistemas, indique la respuesta INCORRECTA:

1. En el aparato respiratorio, calcificación de los cartílagos traqueales.
2. En el sistema nervioso, aumento del tamaño de los surcos interhemisféricos y de los ventrículos cerebrales.
3. En el aparato cardiovascular, reducción en el número de células marcapasos.
4. En el sistema nefrourológico, reducción del tejido mesangial.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla en relación al proceso de envejecimiento. Para contestarla solo debemos recordar que en el anciano todas las células funcionales (del tipo que sean: neuronas, hepatocitos, nefronas, miocitos...) van a disminuir en número y serán sustituidas por tejido graso o fibroso. Recordando esta norma podemos descartar directamente la opción 2 y la opción 3 por ser ambas verdaderas. Opción 2: efectivamente si disminuye el número de neuronas y por lo tanto el parénquima cerebral tiene un volumen menor, los surcos se verán más grandes y los ventrículos, en vez de estar comprimidos, se expandirán. Opción 3: como hemos dicho, disminuyen todas las células funcionales del cuerpo, entre ellas las células marcapasos, los miocardiocitos, etc. La opción 1 también es verdadera ya que, con el tiempo, todos los tejidos son susceptibles a calcificarse. Se van depositando restos de calcio en la mayoría de órganos (lo veremos siempre en las pruebas de imagen realizadas a un anciano: tráquea calcificada, botón aórtico calcificado, ligamentos calcificados...). La opción incorrecta es la 4, ya que las nefronas disminuyen, pero el mesangio (que es tejido fibroso, no celular) aumenta.

30. La utilización baja de energía por el músculo liso es fundamental para el gasto de energía corporal (órganos como los intestinos, la vejiga urinaria o la vesícula biliar mantienen una contracción muscular tónica casi indefinidamente). A este respecto, señale la afirmación correcta:

1. La disposición física de los filamentos de miosina y actina es similar a la del músculo esquelético.
2. En esa contracción, es fundamental la lentitud de la unión y separación de los puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina.
3. La fuerza máxima de contracción es con frecuencia menor que la que se produce en el músculo esquelético.
4. La contracción prolongada exige que la excitación de las fibras musculares se mantenga mientras lo haga esa contracción.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El músculo liso se caracteriza por su capacidad de mantener contracciones tónicas con un consumo energético muy bajo. Esto se debe, en gran parte, a que los puentes cruzados entre la actina y la miosina se unen y separan de manera mucho más lenta que en el músculo esquelético, lo que permite mantener la contracción con un menor gasto de ATP. Este mecanismo es clave en la función de órganos como el intestino, la vejiga o la vesícula biliar. Respecto al resto de opciones: en el músculo liso los filamentos de actina y miosina no forman sarcómeros bien definidos, sino una red densa; el músculo liso puede generar una fuerza igual o superior a la del estriado en relación a su tamaño; la contracción puede mantenerse por un mecanismo de “bloqueo” de los puentes cruzados en ausencia de una excitación constante.

31. En relación con el control químico de la respiración en condiciones fisiológicas señale la afirmación INCORRECTA:

1. Los quimiorreceptores carotídeos y aórticos detectan especialmente cambios en la presión parcial de O₂ en la sangre.
2. Los quimiorreceptores carotídeos y aórticos reciben un flujo arterial muy elevado por lo que se consideran expuestos en todo momento a sangre arterial.
3. Los quimiorreceptores centrales detectan fundamentalmente cambios en la concentración de H⁺ (procedente sobre todo de la disociación de CO₂ y H₂O).
4. El efecto estimulador de la ventilación del CO₂ se mantiene sin atenuación en los primeros días.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta asequible sobre el control de la respiración. La afirmación incorrecta es la 4 (por tanto, la que debemos marcar) porque, en condiciones de exposición prolongada a elevaciones de CO₂, los quimiorreceptores centrales experimentan un proceso de adaptación o desensibilización. Esto significa que, aunque inicialmente el aumento de CO₂ (y consecuente aumento de H⁺) estimula la ventilación, con el tiempo la respuesta ventilatoria disminuye, incluso si los niveles de CO₂ se mantienen elevados.

32. En un paciente diagnosticado de una neoplasia maligna de nasofaringe que presenta dolor y edema orbitario, neuropatía de los pares craneales II, IV y VI, y neuropatía de la rama V1 del V par craneal, indique qué estructura es más probable que se encuentre infiltrada:

1. Seno cavernoso.
2. Hipófisis.
3. Agujero yugular.
4. Fosa pterigopalatina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla de semiología: la combinación de los pares craneales III, IV, V1, V2 y VI, asociando o no síndrome de Horner y/o proptosis debe hacer sospechar una afectación del seno cavernoso, en el caso de la pregunta neoplásica. En un paciente sin antecedentes puede ser una inflamación idiopática conocida como síndrome de Tolosa Hunt, que responde a corticoides.

33. Niña de 7 años con una sospecha de anemia de Fanconi. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas NO se ajusta a los rasgos típicos de esta enfermedad?

1. Anomalías pigmentarias.
2. Anomalías renales.
3. Anomalías esqueléticas.
4. Estatura alta.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La anemia de Fanconi es la aplasia medular congénita más frecuente y cursa, entre otras manifestaciones, con estatura baja.

34. La exploración ecográfica de una mujer gestante de 26 semanas muestra hallazgos consistentes con osteogénesis imperfecta tipo II (gen COL1A1/COL1A2). La paciente tuvo un embarazo previo con la misma patología. Ni ella ni su pareja tienen manifestaciones clínicas de osteogénesis imperfecta. ¿Cuál de las siguientes es la explicación más probable para la recurrencia?

1. Herencia autosómica recesiva.
2. Mutación de novo.
3. Penetrancia incompleta.
4. Mosaicismo germinal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Muy difícil. La osteogénesis imperfecta tipo I y II se debe a mutaciones en los genes COL1A1/COL1A2 que codifican el colágeno tipo I. Se transmite habitualmente como rasgo autosómico dominante, pero cuando ocurre en familias sin antecedentes, suele deberse a mutaciones de novo. En

este caso, la recurrencia de la enfermedad en dos gestaciones consecutivas con padres sanos sugiere un mosaicismo germinal (opción 4). Las otras opciones son incorrectas: la herencia autosómica recesiva (opción 1) no es el patrón habitual de la osteogénesis tipo II; una mutación de novo (opción 2) no explicaría la recurrencia; y la penetrancia incompleta (opción 3) implicaría que alguno de los padres portara la mutación, lo que se manifestaría con algún signo clínico aunque fuera leve.

35. Las vacunas contra el neumococo recomendadas para prevenir la enfermedad neumocócica en personas mayores de 65 años y en pacientes inmunocomprometidos pueden estar constituidas por polisacáridos del neumococo purificados (PPV23) o polisacáridos conjugados a proteínas (PCV15 o PCV20). Desde una perspectiva inmunológica, las vacunas conjugadas:

1. No generan memoria inmunológica.
2. Activan una respuesta inmunitaria T-dependiente (o timo-dependiente).
3. No activan el proceso de hipermutación somática.
4. No inducen cambio de isotipo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Todas las vacunas que generan memoria deben suponer una respuesta T dependiente (de otra manera no se generaría memoria). En las vacunas conjugadas, se administran polisacáridos del germen contra el que se quiere realizar la respuesta inmune junto a proteínas inmunógenas (habitualmente toxoides). Los linfocitos B reconocerán los polisacáridos, interiorizarán el polisacárido junto al toxoide, presentarán el toxoide al linfocito T y finalmente se producirán anticuerpos contra el polisacárido.

36. El paso de autoantígenos de la madre al feto a través de la placenta puede asociarse a la aparición de enfermedades autoinmunes en el recién nacido. Señale cuál de las parejas Enfermedad - Autoanticuerpo es INCORRECTA:

1. Pénfigo vulgar — Anticuerpos antidesmogleína 3.
2. Bloqueo cardíaco congénito — Anticuerpos anti-Ro y anti-La.
3. Miastenia gravis — Anticuerpos anti receptor de la acetilcolina.
4. Lupus eritematoso neonatal — Anticuerpos anti-Sm.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad baja en la que hay que recordar que los anticuerpos maternos que pueden experimentar un paso trasplacentario originando un lupus neonatal son anti-Ro (también conocido como SS-A) y anti-La (SS-B). Anti-Sm no tiene esa capacidad, por lo que no se correlaciona con el

desarrollo de manifestaciones en este escenario clínico.

37. Mutaciones en el gen Btk pueden causar una inmunodeficiencia primaria que cursa con la disminución drástica o ausencia de inmunoglobulinas en la sangre periférica (agammaglobulinemia). En relación al estudio de los pacientes con esta agammaglobulinemia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

1. Es una enfermedad autosómica recesiva.
2. El porcentaje de linfocitos que expresan CD19 o CD20 (linfocitos B) en sangre periférica está dentro de los límites normales.
3. El nivel de IgG en suero disminuye paulatinamente desde el nacimiento hasta resultar indetectable.
4. La expresión de la proteína Btk en monocitos es normal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un caso de una enfermedad de Bruton. Se trata de una enfermedad ligada a X (opción 1 falsa). La agammaglobulinemia de Bruton se caracteriza por agammaglobulinemia con disminución de linfocitos B (opción 2 falsa). Inicialmente, estos pacientes presentan las inmunoglobulinas que la madre ha pasado por la placenta; conforme pasa el tiempo, estas van descendiendo hasta desaparecer (sin aparecer las que debería producirá el paciente) (opción 3 correcta). La mutación es somática, por lo que todas las células se verán afectadas (opción 4 falsa).

38. Hombre de 20 años que, tras ingesta de gambas, presenta de forma prácticamente inmediata prurito palmoplantar, sensación de nudo en la garganta y ronquera, mareo, sensación de inestabilidad y debilidad intensa. Entre sus antecedentes destaca cuadro de edema laríngeo por alergia a las lentejas al año de edad. No refiere alergia conocida a otros alimentos, tampoco reacciones adversas a fármacos ni picadura de insectos. Entre los antecedentes familiares tiene un hermano con rinitis alérgica leve intermitente por alergia a pólenes. ¿Cuál debe ser el tratamiento inicial de forma urgente?

1. Hidrocortisona 500 mg IV y desloratadina 5 mg IV.
2. Adrenalina 0,3-0,5 mL IV.
3. Adrenalina 0,3-0,5 mL IM.
4. Metilprednisolona 40 mg IM y desloratadina 5 mg IV.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Presentan un caso de anafilaxia. Tras un potencial alérgico, el paciente presenta inestabilidad, mareo y afectación cutánea con exantema; además, existe sospecha de angioedema o edema laríngeo. Nos preguntan la primera medida a

emplear en una anafilaxia, que debe ser adrenalina por vía intramuscular.

39. Hombre de 40 años sin antecedentes patológicos de interés, residente en una zona de interior de la península ibérica, que presenta cuadro de urticaria aguda por sensibilización a Anisakis simplex tras haber ingerido larvas vivas en unos boquerones en vinagre. El cuadro descrito le ocurrió hace más de 6 meses. Aporta prueba cutánea e IgE específica positiva frente a dicho parásito. En relación a la ingesta de pescados, ¿qué pauta de las que se indican a continuación debe seguir?

1. Puede comer pescados y mariscos sin ningún tipo de precaución dado que han transcurrido más de 6 meses de la ingesta.
2. No puede ingerir ningún tipo de pescado.
3. Puede comer pescado cocinado a 45°C.
4. Puede comer pescado previamente congelado a -20°C durante 72 horas en el domicilio o pescado congelado industrial.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta incluye un concepto ya preguntado (MIR 2022), sobre cómo deben comer los pacientes alérgicos al Anisakis el pescado. La opción correcta es la 4: deben comer el pescado previamente congelado a -20 °C durante 72 horas, o pescado congelado industrial, evitando la ingesta de pescado crudo o poco cocinado como boquerones en vinagre, pescado a la plancha, microondas, horneado a menos de 60 °C, ahumados, salazones y escabeches.

40. La medida adecuada para estimar el riesgo individual de enfermar es:

1. La incidencia acumulada.
2. La densidad de incidencia.
3. La prevalencia puntual.
4. El riesgo relativo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa sobre una medida clásica de frecuencia: la incidencia acumulada. La incidencia acumulada nos da la probabilidad de que un sujeto sano desarrolle una enfermedad en un periodo determinado (riesgo individual de enfermar: respuesta correcta). Se calcula dividiendo el número de casos nuevos a lo largo de un periodo de tiempo entre la población bajo riesgo al inicio de dicho periodo. Por otro lado, la densidad de incidencia nos da información sobre la velocidad de propagación de una enfermedad, y cobra especial relevancia en el contexto de cohortes dinámicas. La prevalencia expresa la proporción de individuos que padece una enfermedad en un momento dado. El riesgo relativo es una medida de fuerza de asociación que cuantifica la relación entre la incidencia acumulada de dos grupos.

41. Al finalizar el periodo de seguimiento en el estudio PREDIMET, 'Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet', el 3.8% de los individuos asignados a dieta mediterránea presentaron algún tipo de evento cardiovascular (infartos de miocardio, ictus o muertes de origen cardiovascular), frente al 44% de eventos ocurridos en el grupo control. ¿Cuál es el número necesario de pacientes a tratar (NNT) con dieta mediterránea para evitar un evento cardiovascular?

1. 26.
2. 60.
3. 80.
4. 167.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy repetida en el examen MIR sobre un concepto que es fundamental dominar: el número necesario de paciente a tratar (NNT). Nos indica cuántos sujetos se deben exponer a un factor protector (en este caso, la dieta mediterránea) para evitar un caso de enfermedad (en este caso, un evento cardiovascular). El NNT se calcula dividiendo 100 entre la reducción absoluta de riesgo (RAR) expresada en porcentaje. En nuestro caso, $RAR = \text{incidencia acumulada en no expuestos (4,4\%)} - \text{incidencia acumulada en expuestos (3,8\%)} = 0,6\%$. Por lo tanto, $NNT = 100/0,6 \approx 167$.

42. En evaluación económica de intervenciones sanitarias, un estudio que compare los costes alternativos de dos intervenciones frente a sus resultados de salud expresados en años ajustados por calidad o años de vida ajustados por discapacidad se denomina:

1. Análisis coste-beneficio.
2. Análisis coste-efectividad.
3. Análisis coste-utilidad.
4. Análisis de minimización de costes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta directa y recurrente en el examen MIR: AÑOS DE VIDA + CALIDAD DE VIDA ÷ COSTE-UTILIDAD (RC 3). Coste-beneficio mide términos económicos, coste-efectividad mide años de vida ganados (sin calidad de vida), y el análisis de minimización de costes cuantifica los costes de dos o más procedimientos cuyas consecuencias son equivalentes.

43. Señala la opción INCORRECTA respecto a la enfermedad meningocócica:

1. El mecanismo de transmisión es por gotas.
2. Se dispone de vacunas efectivas únicamente para la prevención de 4 subtipos de meningococo.

3. La vacuna frente a meningococo tipo B está incluida en el calendario sistemático de inmunizaciones del Sistema Nacional de Salud.
4. Ante un contacto de riesgo con un paciente con meningitis meningocócica, la vacunación del contacto no debe ser la primera estrategia de profilaxis postexposición.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla que implica conocimiento sobre los distintos tipos de vacuna existentes con cobertura frente al meningococo. Actualmente existen comercializadas vacunas frente a meningococo B, así como a los subtipos C, A, W135 e Y, lo que provoca que la opción 2 sea falsa. El resto de opciones indicadas son correctas.

- 44. Se diagnostica de varicela a un niño de 8 años. Su madre está embarazada de 32 semanas y se le solicita una serología en la que se observan anticuerpos de tipo IgG frente a varicela por debajo de los niveles protectores y niega haber padecido la enfermedad en el pasado. ¿Cuál es la actitud recomendada con la gestante sabiendo que han pasado 3 días desde el inicio de la exposición?**

1. Administrar una dosis de la vacuna frente a varicela.
2. Forzar la terminación del embarazo para poder vacunarla.
3. Es tarde para plantear una estrategia de profilaxis postexposición.
4. Administrar gammaglobulinas polivalentes o hiperinmunes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Concepto repetido en el MIR sobre el manejo que se debe realizar ante una embarazada con un posible contacto con varicela, remarcando la relevancia de hacer una correcta profilaxis pasiva por la necesidad de dar algún soporte y no poder emplear la vacuna de la varicela (al ser esta atenuada). Por tiempo transcurrido (3 días) cumple perfectamente la temporalidad para administrar gammaglobulina polivalente o hiperinmune. Opción 4 correcta.

- 45. En un metaanálisis, el riesgo relativo estimado para la asociación causal entre el uso de mascarilla y la incidencia de SARS-CoV-2 fue de 0,47. ¿Cuál es la interpretación correcta de este resultado?**

1. La incidencia de SARS-CoV-2 se reduce un 47% cuando la población usa mascarilla.
2. No usar mascarilla aumenta un 53% el riesgo de infección por SARS-CoV-2.
3. El uso de mascarilla podría evitar 47 de cada 100 casos de SARS-CoV-2 que se dan en personas que no la usan.

4. La incidencia de SARS-CoV-2 en la población que no usa mascarilla se reduciría un 53% si la utilizara.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

De nuevo pregunta en el examen MIR acerca del metaanálisis, en este caso la interpretación de sus resultados. Nos dicen que el RR de uso de mascarilla y la incidencia de SARS-CoV-2 es 0,47 (lo que quiere decir que es una medida protectora, que reduce un 53% el riesgo de contagio: $1 - 0,47 = 0,53$) (RC: 4). La opción 1 nos dice que se reduce un 47%, lo cual no es cierto (se reduce un 53%). La opción 2 nos dice que aumenta el riesgo de infección, pero como el RR es <1 sabemos que se trata de un factor protector. La opción 3 es igual que la 1, pues nos dice que se evitan 47/100, o lo que es lo mismo el 47%. Ya hemos visto que es un 53%, o lo que es lo mismo, evita 53 de cada 100 casos.

- 46. Hombre de 79 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, hiperuricemia y artrosis que acude a urgencias por presentar posible reacción adversa farmacológica. No refiere antecedentes alergológicos de interés. Después de una excursión en barco sin protección solar, presenta un cuadro cutáneo agudo facial, principalmente en párpados superiores e inferiores, consistentes en eritema y edema intenso bilateral. El paciente estaba realizando tratamiento médico de forma habitual con hidroclorotiazida 25 mg, amlodipino 5 mg, atorvastatina 10 mg y apixaban 5 mg. ¿Cuál de los cuatro fármacos descritos es más probable que sea el responsable de una posible reacción de fotosensibilidad?**

1. Hidroclorotiazida.
2. Amlodipino.
3. Atorvastatina.
4. Apixaban.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa en la que se hace clara referencia a una reacción de fotosensibilidad de origen medicamentoso, de respuesta difícil por el grado de concreción. Se trata de una dermatitis fototóxica (debida a las características moleculares del fármaco, por lo que no requiere sensibilización previa) propia de diversas familias de fármacos entre las que se incluyen las tiazidas pero también las tetraciclinas, el voriconazol, la amiodarona o los inhibidores de BRAF, entre otras. Debe distinguirse de las reacciones fotoalérgicas (inmunomediadas, requieren sensibilización previa) que también pueden producir fármacos como los AINEs tópicos, entre otros.

- 47. ¿Con cuál de estos fármacos administrados en monoterapia es necesario realizar un ecocardiograma antes de su inicio?**

1. Trastuzumab.
2. Tamoxifeno.
3. Paclitaxel.
4. Docetaxel.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy difícil. Ante un paciente oncológico que va a iniciar un tratamiento potencialmente cardiotoxico, existe indicación de valoración previa en consulta de Cardiología, que incluirá en general un ecocardiograma para valorar la FEVI antes de iniciar el tratamiento. No obstante, este ecocardiograma no es obligatorio en todos los pacientes, sino solamente en aquellos de alto riesgo (por tener cardiopatía conocida antes del inicio del tratamiento oncológico, especialmente si ya tenían la FEVI deprimida), o si el tratamiento oncológico es de muy alto riesgo. De las opciones que nos proponen, tanto trastuzumab como los taxanos (paclitaxel y docetaxel) son potenciamente cardiotoxicos, pero el riesgo de cardiotoxicidad es muy alto solamente con trastuzumab, que es la opción correcta (con taxanos existe riesgo pero no es alto, por lo que el ecocardiograma previo no es obligatorio). A pesar de la alta dificultad de esta pregunta, podía sacarse fácilmente por técnica de examen: la duda razonable se encuentra entre las opciones 1, 3 y 4; las opciones 3 y 4 (los taxanos) son muy parecidas y sería imposible elegir entre ellas. Por ese motivo, la opción correcta debe ser la 1.

48. La inducción de secuencia rápida en la anestesia general es:

1. Método de inducción anestésica utilizado cuando existe riesgo de regurgitación gástrica y aspiración pulmonar.
2. Método de inducción anestésica realizado exclusivamente con halogenados.
3. Procedimiento anestésico que requiere la ventilación del paciente con presión positiva.
4. Método de inducción anestésica utilizado habitualmente para la realización del procedimiento quirúrgico programado.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta compleja que hace referencia a un concepto muy específico de la especialidad de Anestesia. La inducción de secuencia rápida (RSI) hace referencia a una técnica utilizada para facilitar la intubación endotraqueal y el manejo de la vía aérea en situaciones de emergencia. Este procedimiento es importante para aquellos pacientes que no están en ayunas y tienen mayor riesgo de regurgitación y aspiración pulmonar. El proceso de RSI consta de los siguientes pasos: 1) inducción: administración rápida de un agente anestésico como el etomidato para generar una rápida pérdida de conciencia; 2) parálisis: seguidamente se administra un agente bloqueador neuromuscular como la succinilcolina o el rocuronio para facilitar la intubación; 3) intubación: realización de laringoscopia directa y colocación del tubo endotraqueal. En resumen, la RSI se utiliza principalmente en situaciones

de emergencia para minimizar el riesgo de aspiración, mientras que la anestesia general normal es un procedimiento más largo y gradual que se emplea en contextos quirúrgicos electivos con un enfoque más controlado. De acuerdo a ello, la respuesta correcta es la 1. El resto de opciones son consecuentemente falsas ya que hacen referencia a una anestesia general normal.

49. Señale la actitud correcta ante un paciente en edad infantil que refiere antecedente de traumatismo facial no tratado hace 3 años y que presenta limitación progresiva de la apertura oral y desviación del mentón hacia un lado:

1. Debe descartarse la existencia de una fractura antigua tipo Lefort-1.
2. Debe realizarse un estudio mediante tomografía computarizada para descartar una displasia fibrosa.
3. Debe descartarse el diagnóstico de osteocondroma del cóndilo mandibular.
4. Debe descartarse el diagnóstico de anquilosis témporo-mandibular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta novedosa sobre un tema frecuente en el MIR, la patología de la articulación témporo-mandibular (ATM). Paciente infantil con antecedentes de traumatismo facial y clínica de limitación progresiva de la apertura oral y desviación del mentón de lenta evolución. El diagnóstico más probable es anquilosis por la formación de tejido fibroso que limita la movilidad de la articulación, normalmente debido a una lesión ósea que condiciona hemartros condilar (opción 4 correcta). El diagnóstico se confirma con pruebas de imagen y el tratamiento es generalmente quirúrgico. La fractura tipo Lefort-1 afecta principalmente al tercio medio facial sin clínica mandibular (opción 1 incorrecta); la displasia fibrosa mandibular es una enfermedad benigna en la que el hueso normal de la mandíbula es reemplazado por tejido fibroso anormal con expansión de la mandíbula, produciendo dolor óseo y dificultades funcionales sin antecedente traumático (opción 2 incorrecta); el osteocondroma del cóndilo mandibular provoca crecimiento asimétrico mandibular, pero no necesariamente dificultad para la apertura ni presenta antecedente traumático (opción 3 incorrecta).

50. Respecto al colgajo DIEP, señala la respuesta INCORRECTA:

1. Se trata de un colgajo basado en vasos perforantes que puede ser usado como colgajo libre o como colgajo pediculado.
2. Está irrigado por ramas de la arteria circunfleja femoral lateral.
3. Puede utilizarse para reconstrucción mamaria.
4. Los vasos perforantes musculocutáneos atraviesan el músculo recto del abdomen antes de irrigar la piel del colgajo.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta asequible por la forma en la que está redactada y por lo que preguntan, no por el concepto preguntado. En los últimos 10 años han preguntado varias cosas de los colgajos e injertos. Esta pregunta es similar a otra de 2018 en la que se nos preguntó sobre el colgajo ALT (colgajo anterolateral del muslo), donde nos pedían que contestásemos la incorrecta que era que estaba irrigado por la arteria circunfleja femoral MEDIAL y como dice el enunciado es LATERAL. Nos vemos ante una pregunta de especialidad avanzada, pero por técnica MIR fácilmente deducible porque los vasos epigástricos inferiores no son lo mismo que la arteria circunfleja femoral lateral del colgajo ALT. Es el colgajo por excelencia, junto con el del dorsal ancho, para la reconstrucción mamaria no protésica. Los colgajos sí tienen base musculocutánea (evidentemente los vasos atraviesan antes el músculo). Todo colgajo, por su definición (concepto de MIREs previos) tiene su propia irrigación y puede ser libre o pediculado.

51. ¿Cuál de los siguientes escenarios podría suponer una contraindicación para el uso de un injerto de piel parcial como cobertura de un defecto cutáneo?

1. Cuando el defecto cutáneo abarca una gran superficie corporal.
2. En un paciente con comorbilidades médicas significativas.
3. Cuando hay un tendón sin paratendón en la base de la herida.
4. Cuando hay una infección activa en el lecho de la herida.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta teóricamente impugnable sobre cirugía plástica, pero que finalmente el ministerio no rectificó. Un injerto, ya sea parcial o completo, depende para su supervivencia no de sí mismo, sino del lecho donde se coloque (recordad que un colgajo es una unidad anatómica que depende de sí mismo, al ir con su vaso). Un paratendón es una estructura de tejido conectivo vascularizado que protege algunos tendones (el tendón es completamente avascular) cuando no están rodeados de vaina sinovial. Por lo tanto, con una avulsión, si desaparece el paratendón (que nutriría el injerto), un injerto nunca prendería sobre un tendón avascular. La opción 4 es completamente debatible; un injerto no se debe colocar sobre un tejido infectado nunca, salvo que se haya realizado previamente un desbridamiento del mismo y limpiado de la infección. En este caso la 3 es mucho más incorrecta que la 4 porque la 4 tiene una vía para poder hacerlo, pero sin duda mala decisión del Ministerio el no anular esta pregunta.

52. Un enfermo diabético de reciente diagnóstico acude a revisión oftalmológica. A las pocas horas vuelve con un cuadro bilateral de edema y eritema palpebral, quemosis, hiperemia

conjuntival, lagrimeo y picor. Su actitud debe ser:

1. Solicitar una analítica con glucemia, hemoglobina glicosilada y velocidad de sedimentación globular.
2. Prescribir un colirio antihistamínico o corticoide de baja potencia.
3. Realizar una OCT para descartar la existencia de un edema macular diabético.
4. Realizar una gonioscopia para descartar la presencia de neovasos en el ángulo camerular.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de dificultad media-alta, aunque se puede elegir la opción correcta usando el sentido común. Es decir, la relación causa-efecto: acudo a revisión y a las horas tengo un problema ocular; lo más lógico es pensar que alguna medicina o maniobra utilizada en esa revisión me han provocado el cuadro clínico. En este caso, el paciente es diabético y acude a revisión oftalmológica. Lo más frecuente es que sea para descartar retinopatía diabética (la mayoría deben revisarse al diagnóstico y después una vez al año o cada dos años), ya que no nos dicen que tengan ningún síntoma. Para ello es necesario realizar un fondo de ojo (FO) o tomar una retinografía. Para el FO es necesario dilatar la pupila con midriáticos. Si estos producen un cuadro alérgico local provocarán una conjuntivitis alérgica con edema palpebral, conjuntival (quemosis), eritema en piel e hiperemia conjuntival (ojo rojo). El tratamiento consistirá en un antihistamínico o corticoide tópico, aunque también puede ser oral. Se debe remitir al paciente al Servicio de Alergología para conocer si el paciente tiene una alergia medicamentosa.

53. En relación al tratamiento quirúrgico de las cataratas, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

1. El empeoramiento de la visión cercana está inducido por la catarata y se denomina miopía de índice.
2. La cirugía de cristalino disminuye el riesgo de desprendimiento de retina en los pacientes miopes jóvenes.
3. Las cataratas se operan cuando la agudeza visual está muy disminuida sin tener en cuenta otros síntomas o signos.
4. Los fármacos alfa bloqueantes como la tamsulosina asocian complicaciones intraoperatorias.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta de dificultad media-alta. Se puede descartar la opción 3, ya que cualquier intervención quirúrgica debe tener en cuenta el conjunto del cuadro clínico (signos y síntomas, situación basal del paciente, vida laboral, etc.), en este caso no solo la agudeza visual. Las cataratas pueden dar lugar

a síntomas visuales como visión borrosa, deslumbramientos con luces, y mejoría de la visión cercana (no empeoramiento) por cambio del índice de refracción del cristalino (lo que se denomina miopización por catarata o miopía de índice); por ello, la opción 1 es falsa. Por otro lado, hay que recordar que la cirugía de cataratas, la miopía, los traumatismos oculares y el desprendimiento del vítreo reciente son factores de riesgo para el desprendimiento de retina regmatógeno, por lo que la opción 2 es falsa. Por último, una de las complicaciones intraoperatorias más frecuentes es el síndrome del Iris flácido (IFIS). Los pacientes que toman alfa-bloqueantes (tamsulosina) tienen una menor dilatación pupilar cuando se les instila midriáticos. Además, durante la cirugía de catarata, puede producirse una miosis pupilar progresiva con un iris blando con tendencia al prolapso por las incisiones, lo que complica enormemente la extracción de la catarata. “

54. Hombre de 72 años exfumador, acude a consulta por visión borrosa y dificultad para leer, especialmente en el ojo derecho, situación que ha progresado lentamente en los últimos seis meses. En la exploración del segmento anterior no se encuentran alteraciones clínicamente relevantes. En el ojo derecho se observan múltiples drusas en la región macular (una de tamaño grande) y alteraciones pigmentarias. En la tomografía de coherencia óptica se muestra un adelgazamiento del epitelio pigmentario de la retina y áreas de acumulación de material subretiniano en la mácula del ojo derecho. ¿Cuál es el manejo inicial indicado para este paciente?

1. Iniciar tratamiento con implante intravítreo de dexametasona.
2. Recomendar el uso de suplementos vitamínicos específicos.
3. Indicar de forma preferente cirugía de catarata con implante de lente intraocular.
4. Iniciar tratamiento con inyecciones intravítreas de anti-VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media. En el enunciado se describen las características típicas de un fondo de ojo de DMAE seca o atrófica (drusas con alteraciones pigmentarias). Además, el diagnóstico se confirma con el hallazgo de la OCT (tomografía de coherencia óptica): adelgazamiento del epitelio pigmentario y áreas de acumulación de material (drusas). Recuerda que, hasta el momento, el único tratamiento aprobado para la DMAE es el uso de suplementos vitamínicos antioxidantes para reducir el riesgo de sufrir una DMAE avanzada.

55. Hombre de 26 años que presenta otorrea unilateral derecha de una semana de evolución desde su regreso de vacaciones en la playa donde

una ola le arrolló provocando inmersión. Refiere haber sido tratado en la infancia con colocación de drenajes transtimpánicos bilaterales y ha evitado la entrada de agua en los oídos desde entonces. No presenta dolor, pero sí molestias y leve hipoacusia. Tampoco tiene vértigo, pero sí sensación de taponamiento ótico. En la otoscopia se evidencia una perforación timpánica central de bordes lisos y otorrea que proviene de oído medio. ¿Cuáles son el diagnóstico y tratamiento del paciente?

1. Reactivación de una otitis media crónica simple que será tratada con ciprofloxacino en gotas y remitir a Otorrinolaringología.
2. Otitis media aguda que precisa tratamiento con gentamicina en gotas y revisión otoscópica pasada una semana.
3. Otitis media crónica colesteatomatosa que será tratada con gentamicina en gotas y remitir a Otorrinolaringología.
4. Otitis externa aguda complicada que precisa tratamiento con ciprofloxacino en gotas y revisión otoscópica pasada una semana.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

“El paciente presenta una perforación timpánica central con bordes lisos y otorrea proveniente del oído medio tras una inmersión. Por esta perforación, el agua no estéril puede entrar en la caja timpánica y producir infección. Por lo tanto, estamos ante una reactivación de una otitis media crónica simple (también conocida como perforación timpánica), un cuadro común en pacientes con antecedentes de drenajes transtimpánicos en la infancia (opción 1 correcta). El manejo adecuado incluye tratamiento con gotas óticas de ciprofloxacino. Además, es fundamental remitir al paciente a Otorrinolaringología para una valoración especializada que evalúe la necesidad de cierre timpánico futuro o seguimiento específico. Las demás opciones son incorrectas: la otitis media aguda es improbable porque el paciente no asocia dolor intenso y los bordes de la perforación son lisos (en contraste con una perforación aguda que tendrá bordes irregulares) (opción 2 falsa); la otitis media crónica colesteatomatosa cursa con perforaciones marginales y otorrea fétida (opción 3 falsa); la otitis externa aguda se caracteriza por dolor y afectación del conducto auditivo externo, aquí la afectación es del oído medio (opción 4 falsa).”

56. Hombre de 40 años que acude a urgencias por presentar un cuadro de mareo con giro de objetos acompañado de náuseas, vómitos, palidez y sudoración de varias horas de evolución. Nunca había presentado un cuadro similar. No refiere hipoacusia ni acúfeno ni sensación de taponamiento. La otoscopia es normal. Se observa un nistagmo horizonte-rotatorio hacia el lado derecho grado III que aumenta la velocidad cuando dirige la mirada a la derecha, maniobra

oculofacial positiva izquierda, test de Skew y el test de Romberg positivo a la izquierda. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Infarto cerebral.
2. Neuritis vestibular.
3. Enfermedad de Menière.
4. Vértigo posicional paroxístico benigno.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

El diagnóstico más probable es neuritis vestibular, también conocida como síndrome vestibular agudo (opción 2), una disfunción unilateral del nervio vestibular, generalmente de origen viral o inflamatorio. Las demás opciones son incorrectas: el infarto cerebral (opción 1) se asocia a un nistagmo vertical o multidireccional y pruebas vestibulares centrales positivas, lo que no ocurre aquí; la enfermedad de Ménière (opción 3) cursa con hipoacusia y acúfenos fluctuantes, ausentes en este caso, y con cuadros de vértigo más limitados en el tiempo y recurrentes; y el vértigo posicional paroxístico benigno (opción 4) es episódico, de corta duración y dependiente de cambios de posición, en contraste con el cuadro prolongado de este paciente. La única duda posible sería que no nos dicen el resultado del cover test, posiblemente una errata del Ministerio a quien le faltó poner “negativo”. En este caso y por tendencia MIR, ante un paciente que tiene todos los datos de periférico y falta esa palabra lo más sensato es marcar síndrome vestibular agudo.

57. Mujer de 54 años consulta por hipoacusia unilateral derecha de horas de evolución que se ha presentado de manera brusca. Presentó un cuadro viral de vía aerodigestiva superior hace unos días. Sin antecedentes de interés, no presenta vértigo ni sensación de taponamiento acústico ni acúfeno. No refiere dolor ni presenta parálisis facial. La otoscopia es normal. En la acúmetría, la prueba Rinne es positiva bilateral y la prueba Weber lateraliza al lado izquierdo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y el manejo?

1. Hipoacusia súbita, se solicitará una tomografía computarizada craneal urgente.
2. Hipoacusia de conducción por otitis media serosa, se tratará con lavados nasales y esteroides tópicos nasales.
3. Hipoacusia súbita, precisa audiometría tonal urgente y se tratará con corticoterapia sistémica y/o intratimpánica.
4. Síndrome de Ramsay-Hunt, se tratará con corticoterapia más valaciclovir.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

“Pregunta tipo caso clínico. La paciente presenta hipoacusia unilateral derecha de inicio brusco, sin otros síntomas asociados como vértigo, acúfeno, dolor o parálisis facial. Sospechamos origen neurosensorial por la otoscopia normal

y el Weber lateraliza al lado izquierdo (sano). Además, el antecedente de infección viral reciente sugiere un posible origen inflamatorio. El diagnóstico más probable es hipoacusia súbita (opción 3), definida como una pérdida auditiva neurosensorial de al menos 30 dB en tres frecuencias consecutivas en menos de 3 días. El manejo inicial incluye la realización de una audiometría tonal urgente para confirmar el diagnóstico y la instauración temprana de corticoterapia sistémica y/o intratimpánica, que mejora el pronóstico al reducir la inflamación y el daño coclear. Las demás opciones son incorrectas: la tomografía computarizada craneal (opción 1) no es el estudio de primera línea en hipoacusia súbita, aunque de forma ambulatoria no urgente se debe realizar una RM para descartar un neurinoma; la otitis media serosa (opción 2) cursa con otoscopia alterada e hipoacusia de conducción; el síndrome de Ramsay-Hunt (opción 4) cursa con dolor ótico, vesículas en CAE y parálisis facial, ausentes en este caso.”

58. Mujer que acude a ecografía de rutina de segundo trimestre a las 22 semanas de gestación. Las biometrias corresponden a un feto de 19 semanas. ¿Cuál es el siguiente paso para orientar el caso?

1. Valorar estudio genético teniendo en cuenta el riesgo de anomalía cromosómica en primer trimestre.
2. Valorar si la gestación está correctamente datada según la longitud craneocaudal fetal de la ecografía del primer trimestre.
3. Repetir ecografía para nuevas biometrias en 2 semanas.
4. Estudio para descartar preeclampsia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La ecografía del primer trimestre sirve, a parte de para realizar el cálculo del riesgo de cromosomopatías y preeclampsia, para datar la gestación de acuerdo a la longitud craneocaudal (CRL) del feto. Si en la ecografía de las 20 semanas nos encontramos un feto con biometrias mayores o menores que la amenorrea, debemos mirar si el CRL de la ecografía de las 12 semanas correspondía con la amenorrea de la paciente. Recuerda que el CIR es un diagnóstico de la ecografía del tercer trimestre; discordancias entre el tamaño fetal en la ecografía 20 y la FUR suelen corresponder a una inadecuada datación de la gestación en el 1º trimestre.

59. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es el más adecuado para una mujer de 35 años con migraña con aura?

1. Anticonceptivos orales combinados.
2. Parche anticonceptivo.
3. Anticonceptivo inyectable con estrógeno y progestágeno.
4. Dispositivo intrauterino (DIU) con levonorgestrel.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

La migraña con aura es una contraindicación para el uso de estrógenos, por lo que en estas pacientes estarían contraindicados tanto los anticonceptivos hormonales combinados, como el parche anticonceptivo y el inyectable combinado.

60. Mujer con gestación monocorial biamniótica de 22 semanas que acude a urgencias por dinámica uterina ocasional. En la ecografía se observa feto 1 con peso estimado en el percentil 80 y columna máxima vertical de líquido amniótico de 11 cm, vejiga urinaria distendida y aumentada de tamaño y feto 2 con un peso en el percentil 25 con una columna máxima de líquido amniótico de 0.5 cm y vejiga urinaria no visible. Exploración vaginal anodina. La longitud cervical es de 36 mm. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Transfusión feto-fetal.
2. Discordancia de crecimiento fetal con crecimiento fetal restringido selectivo del feto 2.
3. Rotura prematura de membranas de feto 2.
4. Malformación renal feto 2.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

El síndrome de transfusión feto-fetal puede aparecer en gestaciones monocoriales, y se debe a la presencia de anastomosis arteriovenosas entre la placenta que comparten ambos fetos. Se caracteriza por la presencia de polihidramnios y vejiga distendida en el feto receptor, y oligohidramnios y vejiga deplecionada en el feto donante.

61. Puérpera de parto eutócico sin complicaciones hace 4 días que acude a urgencias por cefalea de 12 horas de evolución y edemas maleolares. A la exploración presenta cifras tensionales de 165/100 mmHg en dos ocasiones y en la analítica se observa una cifra de plaquetas de 254000/uL, AST 172 U/L, ALT 154 U/L y LDH 345 UI/L, creatinina 0.9 mg/dL y cociente prot/creat 235 mg/g. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas forma parte de la primera línea de tratamiento inmediato?

1. Sulfato de magnesio vía endovenosa.
2. Labetalol vía oral.
3. Corticoides a dosis altas.
4. Diuréticos vía endovenosa.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Caso clínico en el que se describe una puérpera con preeclampsia con criterios de gravedad (presenta clínica de cefalea y edemas, así como elevación de transaminasas y TAS >160 mmHg), por lo que lo más urgente es iniciar el sulfato de magnesio vía endovenosa como tratamiento profiláctico de las convulsiones. Los corticoides no son necesarios dado que no se trata de una gestante <35 semanas, y los diuréticos

no son parte del tratamiento. El labetalol podría ser parte del tratamiento, aunque no de primera línea (ya que es preferible el uso de enalapril), y siempre después de iniciar el sulfato de magnesio.

62. ¿Cuál es la vía de diseminación más frecuente y característica del cáncer de ovario en el momento del diagnóstico?

1. Vía linfática.
2. Vía hematógena.
3. Infiltración por contigüidad.
4. Diseminación peritoneal.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta fácil. La vía principal de diseminación del cáncer de ovario es la siembra peritoneal, si bien también puede diseminarse por vía hematógena (metástasis extraabdominales) y linfática (conglomerados adenopáticos).

63. ¿Cuál de las siguientes es una de las características que condiciona de modo crucial e independiente la elección del tratamiento adyuvante del cáncer de endometrio?

1. Tamaño tumoral.
2. Perfil molecular del tumor.
3. Presencia de células tumorales aisladas en los ganglios linfáticos.
4. Presencia de metrorragia.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sobre un tema novedoso, la clasificación molecular del cáncer de endometrio. El tratamiento adyuvante va a depender de los factores de mal pronóstico, entre los que se encuentran la edad >60 años, el estadio ≥IB, histología tipo 2, G3, invasión miometrial, invasión linfovascular positiva y subtipo molecular p53 mutado. El objetivo de la clasificación molecular es, entre otros, definir no solo el pronóstico, sino también la necesidad de tratamiento adyuvante.

64. Niña de 13 años con desaceleración en el crecimiento en el último año. En la exploración detectamos un bocio con tiroides aumentado de tamaño de forma difusa, firme y no doloroso a la palpación. La madre de la niña comenta que en su adolescencia ella había tenido una enfermedad del tiroides de la que se recuperó espontáneamente. De las siguientes pruebas complementarias, ¿qué considera indicado realizar en primer lugar?

1. Biopsia percutánea.
2. Ecografía tiroidea.
3. Gammagrafía tiroidea.
4. TSH, T4 libre, anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y anticuerpos antitiroglobulina.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Nos presentan una paciente en edad infantil con desaceleración del crecimiento, bocio indoloro y antecedentes de enfermedad tiroidea en la familia: sospecha de hipotiroidismo, cuyo diagnóstico es un clásico en el MIR. Para el diagnóstico de hipotiroidismo lo más importante es la realización de TSH y T4 libre, y para el diagnóstico etiológico lo prioritario es un estudio de autoinmunidad tiroidea.

65. Niña de 10 meses, correctamente vacunada para su edad, tiene fiebre alta, fotofobia y tos. Tras 4 días de fiebre se aprecian unas manchas blancas, como un espolvoreado de harina en mucosa malar a nivel del segundo molar. Al día siguiente de detectarse estas manchas, todavía con fiebre y tos, se detecta un exantema eritematoso, maculo-papuloso morbiliforme, con tendencia a la confluencia en algunas zonas, de aparición craneocaudal. La fiebre persiste hasta 3 días más. Al quinto día de iniciar el exantema, el niño se encuentra afebril, pero inicia en la piel una fase de descamación fina, furfurácea. El diagnóstico clínico más probable es:

1. Sarampión.
2. Rubéola.
3. Varicela.
4. Escarlatina.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Ante una lactante de 10 meses bien vacunada que inicia cuadro de fiebre alta, fotofobia y tos, asociando manchas blanquecinas en la mucosa malar (manchas de Koplik) y exantema posterior debemos pensar en un sarampión. Especial atención del detalle de "estar bien vacunada". Recordad que la triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis) se comienza a poner a los 12 meses de vida, por lo que la paciente aún no la habrá recibido. Opción 1 correcta.

66. El síndrome de Guillain-Barré es considerado una polineuropatía postinfecciosa que presenta todas las características siguientes, EXCEPTO una:

1. Existe hiperreflexia tendinosa en las extremidades que manifiestan debilidad.
2. Es predominantemente un trastorno motor, aunque puede haber síntomas sensitivos.
3. En el líquido cefalorraquídeo, las proteínas están elevadas, sin pleocitosis y con glucorraquia normal.
4. El tratamiento con inmunoglobulina intravenosa acelera la recuperación, pero no modifica la evolución a largo plazo.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta muy fácil de Guillain Barré, enfermedad que cur-

sa con hipo o arreflexia, no con hiperreflexia. El resto son ciertas.

67. Un lactante de 6 meses acude a urgencias por presentar vómitos y diarrea en las últimas 12 horas. Su peso es de 6 kg. Hace 24 horas su peso era de 6.5 kg. Presenta frecuencia cardíaca 140 lpm, frecuencia respiratoria 30 rpm, presión arterial 90/40 mmHg. En la gasometría venosa se observa pH 7.25, pCO₂ 33 mmHg, pO₂ 45 mmHg, bicarbonato 17 mmol/L, exceso de bases -7, lactato 2.5 mmol/L. El sodio es 143 mmol/L. ¿Cuál es su situación en el equilibrio ácido base?

1. Acidosis metabólica sin compensar respiratoriamente.
2. Acidosis metabólica parcialmente compensada respiratoriamente.
3. Acidosis respiratoria parcialmente compensada metabólicamente.
4. Alcalosis respiratoria compensada metabólicamente.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Recuerda que pH = HCO₃/CO₂. El paciente presenta acidosis (pH <7,35) metabólica (HCO₃ <22 mEq/l) parcialmente compensada (pCO₂ <35 mmHg pero sin llegar a normalizar el pH). Por lo tanto, la respuesta CORRECTA es la 2.

68. Avisan de paritorio por parto a término. Se explora a recién nacida, sin esfuerzo de llanto, pálida y cianótica. Se seca y estimula y ante la ausencia de inicio de llanto se traslada a cuna térmica. Inicia llanto intenso y eficaz a los 30 segundos de vida, donde ya se podía observar recuperación del tono de forma completa con movimiento activo, frecuencia cardíaca por encima de 100 lpm y estornudo tras aspiración de secreciones faríngeas espesas. Sin embargo, persiste cianosis generalizada hasta 1 minuto y 20 segundos de vida, a partir del cual presenta solamente acrocianosis. A los 4 minutos de vida inicia dificultad respiratoria (esfuerzo respiratorio irregular) consistente en polipnea, tiraje subcostal e intercostal leve-moderado, leve aleteo nasal y quejido espiratorio (con frecuencia cardíaca por encima de 100 lpm, movimiento activo, recuperación completa del color con coloración completamente rosada y reflejos de tos y estornudo), que se resuelve tras colocar presión positiva durante 2 minutos. ¿Qué puntuación de Apgar tiene esta recién nacida?

1. 4.
2. 8/9.
3. 9/9.
4. 9/10.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico que engloba la reanimación neonatal con el fin de conocer y saber dar un adecuado test de Apgar. En relación a este test, la primera puntuación será al minuto de vida (es entonces cuando tenemos que conocer que datos aplican al recién nacido), objetivando que presenta una coloración completa azulada (0 en color) pero el resto de ítems adecuados (reacción a estímulos, frecuencia cardíaca, tono y esfuerzo respiratorio), por lo que 2×4 igual a 8 puntos. Repetimos el mismo ejercicio al 5º minuto de vida y es entonces cuando se objetiva que el color ya es bueno de forma global pero el paciente tiene una leve dificultad respiratoria, por lo que ahí se pierde un punto y aplica dar un Apgar de 9, siendo el global 8/9, primer y quinto minuto respectivamente.

69. Respecto a las medidas a tomar ante un niño diagnosticado de tos ferina, en relación a sus contactos, indique la respuesta INCORRECTA:

1. Tratar con antibióticos a toda la familia, independientemente de la edad, estado de inmunización y sintomatología.
2. Tratar con antibióticos a todo el personal sanitario que ha atendido al niño, independientemente de la edad, estado de inmunización y sintomatología.
3. Vacunar a los adultos convivientes, aunque hayan padecido la enfermedad, ya que la inmunidad no dura toda la vida.
4. Aislar al paciente al menos 5 días después de iniciar el tratamiento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta impugnada sobre la tos ferina y su manejo, en la que debemos marcar la incorrecta. La 4 y la opción 1 son correctas en relación al niño afecto y los convivientes. La opción 3 no es correcta de forma completa ya que esta afirmación debería individualizarse según la edad y esquema de vacunación que haya recibido cada paciente; aun así, la opción que se dio como incorrecta el Ministerio es la 2 (siendo más incorrecta que la 3, cierto es) ya que solo recibirán antibióticos los sanitarios de las unidades de Neonatología, Obstetricia o sus áreas de urgencias, pero tras individualizar incluso sus riesgos de transmisión.

70. Indique la respuesta FALSA respecto a la invaginación intestinal en pediatría:

1. La mayoría de los casos de invaginación en niños se deben a adherencias congénitas.
2. La incidencia estacional alcanza picos en otoño e invierno.
3. Se ha apreciado una correlación con infección respiratoria previa o concurrente por adenovirus (tipo C).
4. Se ha observado un aumento ligero de la invaginación en las tres semanas posteriores

a la vacuna de rotavirus (sobre todo tras la primera dosis).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Tema clásico en el MIR: la invaginación intestinal. En esta ocasión, preguntan sobre la etiología de esta afección, siendo la principal causa la idiopática. La opción 4 hace que la pregunta sea impugnable, ya que esta relación entre invaginación intestinal y vacuna de rotavirus queda muy en duda según las últimas publicaciones. Aun así, la 1 es mucho menos correcta por lo que es la opción a marcar.

71. Todas las siguientes pueden ser manifestaciones tardías de sífilis congénita, habitualmente no evidentes clínicamente en los 2 primeros años de vida. Indique la manifestación que NO es habitual en esta patología:

1. Dientes de Hutchinson.
2. Nariz en silla de montar.
3. Queratitis intersticial.
4. Cardiopatía congénita.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Cuestión sencilla y directa sobre un tema poco preguntado en el examen MIR como es el de las manifestaciones en el niño afecto de sífilis congénita; todas las opciones son frecuentes excepto la 4, cardiopatías congénitas.

72. Mujer de 35 años que hace dos días sufrió un accidente de coche sin apenas consecuencias físicas, acude a su médica de atención primaria por insomnio con pesadillas. Expresa también recuerdos vívidos de detalles del accidente y síntomas de hiperactivación. El diagnóstico más probable es:

1. Reacción aguda de estrés.
2. Reacción adaptativa depresiva.
3. Trastorno de estrés postraumático.
4. Trastorno de ansiedad generalizada.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos comentan un suceso vital traumático con clínica de trastorno por estrés postraumático, pero que por criterio temporal (menos de 1 mes) corresponde a una reacción a estrés agudo.

73. Los mecanismos de defensa que con mayor frecuencia se presentan en el trastorno delirante son los siguientes, EXCEPTO:

1. Proyección.
2. Negación.
3. Formación reactiva.
4. Regresión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil de contenido psicoanalítico acerca de los mecanismos de defensa en el trastorno delirante: negación (para evitar el dolor), proyección (incapacidad para comprobar la realidad que le genera hostilidad y proyecta en otros) y formación reactiva (agresividad latente, desprecio y desaprobación del criterio ajeno; aparentar lo contrario de lo que realmente hemos dicho que siente). Por lo tanto, la respuesta correcta es la regresión.

74. Sobre los factores de mal pronóstico en la esquizofrenia, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Inicio en edad temprana.
2. Presencia de síntomas negativos.
3. Presentación clínica aguda.
4. Antecedentes de agresividad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil acerca de los factores de buen y mal pronóstico de la esquizofrenia. El inicio agudo o abrupto es un factor de buen pronóstico frente a aquellos casos en los que se inicia de forma larvada.

75. Adolescente de 16 años que es traída a la consulta por sus padres debido a cambios drásticos en su comportamiento en los últimos seis meses. Ha mostrado síntomas de depresión, irritabilidad y recientemente ha comenzado a autolesionarse realizándose cortes en los brazos. También se ha aislado socialmente y ha tenido dificultades para mantener su rendimiento académico. ¿Cuál de los siguientes factores es el más significativo para indicar desregulación emocional y riesgo de conducta suicida en esta paciente?

1. Presencia de autolesiones.
2. Aislamiento social.
3. Irritabilidad.
4. Dificultades académicas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta acerca de los factores de riesgo para el suicidio. Si bien es cierto que el aislamiento social y los sentimientos de soledad pueden ser un factor de riesgo, las autolesiones se han relacionado fuertemente con el riesgo suicida. El mayor riesgo de suicidio es haber protagonizado un intento previo y las autolesiones podrían ser un acto que precede a un intento.

76. Mujer de 28 años con diagnóstico de trastorno bipolar tipo I embarazada de 12 semanas. Ha tenido episodios maníacos y depresivos en el pasado. Actualmente, está preocupada por el impacto de su tratamiento en el feto. ¿Cuál

de los siguientes tratamientos es más seguro y recomendado durante el embarazo, y qué tipo de psicoterapia es apropiada como complemento?

1. Ácido valproico y terapia interpersonal.
2. Lamotrigina y terapia cognitivo-conductual.
3. Litio y terapia cognitivo-conductual.
4. Carbamazepina y terapia interpersonal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil. Desde el punto de vista teórico lamotrigina sería el único estabilizador del tono del humor sin riesgo de teratogenicidad. Las doce semanas y el riesgo de malformación de Ebstein es la que nos hace sospechar que nos intentan confundir con el litio.

77. Respecto a la enfermedad de Alzheimer, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El gen de la ApoE (apolipoproteína epsilon) alelo E4 es factor de riesgo.
2. Hay un descenso de la proteína tau en el LCR.
3. El PET tau y el PET amiloide son útiles en el diagnóstico precoz de la enfermedad.
4. En la RM de estos pacientes esperamos encontrar atrofia en el lóbulo temporal medial.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla y de actualidad sobre la enfermedad de Alzheimer. Los biomarcadores en LCR compatibles con Alzheimer son un descenso del beta-amiloide y elevación de la proteína tau. El resto de respuestas son correctas.

78. Un paciente acude a la consulta porque tiene un trastorno de la marcha, tropieza y tiene caídas frecuentes. En la exploración presenta temblor de reposo en el miembro superior derecho, rigidez en rueda dentada al movilizarle las extremidades superiores y marcha alterada desplazando el tronco hacia delante con pasos cortos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones apoyaría el diagnóstico de enfermedad de Parkinson?

1. Falta de respuesta inicial al tratamiento con Levodopa.
2. SPECT con transportador de dopamina que muestre una hipocaptación en la vía nigroestriada.
3. Gammagrafía miocárdica con MIBG normal.
4. Presencia precoz de síntomas de disautonomía.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta típica sobre la enfermedad de Parkinson, en la que nos presentan las características clínicas clásicas de una enfermedad de Parkinson idiopática (bradicinesia, rigidez,

temblor de reposo). El diagnóstico de la enfermedad continúa siendo clínico a día de hoy, pero existen en las pruebas complementarias o en la respuesta al tratamiento del paciente datos a favor o en contra de la sospecha de enfermedad de Parkinson. De las opciones que nos presentan, la opción 2 es la correcta: el SPECT con transportadores de dopamina o DATSCAN muestra hipocaptación de la vía nigroestriada, como marcador de la pérdida de dopamina en la sustancia nigra y ganglios de la base de los pacientes con enfermedad de Parkinson. El resto de opciones son falsas: 1) lo esperable es una respuesta clínica favorable al tratamiento con levodopa en pacientes con Parkinson; 3) la gammagrafía cardíaca con MIBG está alterada en pacientes con Parkinson; 4) la presencia precoz de síntomas de disautonomía es un dato clínico que debe hacer sospechar un parkinsonismo atípico, y no una enfermedad de Parkinson idiopática.

79. Mujer de 35 años consulta por cuadro de diplopía y debilidad proximal progresivas que empeora a lo largo del día. En la exploración neurológica se aprecia voz nasal, ptosis bilateral sin afectación pupilar, limitación para la abducción del ojo derecho y debilidad proximal con reflejos miotáticos conservados. Respecto a esta paciente señale la opción INCORRECTA:

1. El nivel de anticuerpos es independiente de la gravedad de la enfermedad.
2. En ocasiones se asocia a otra enfermedad autoinmune.
3. Es frecuente la agregación familiar.
4. La respuesta a inmunosupresores es mayor en pacientes con anticuerpos antirreceptor de acetilcolina y anticuerpos antiMusk positivos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cuadro es altamente sugestivo de miastenia gravis, enfermedad autoinmune de la unión neuromuscular que se caracteriza por debilidad fluctuante que empeora con el uso y mejora con el reposo. La opción que hay que marcar es la 3, ya que, aunque pueda existir cierta predisposición genética relacionada con ciertos haplotipos del HLA, la mayoría de los casos son esporádicos. El resto de opciones son correctas y sirven para repasar aspectos de esta enfermedad.

80. Con respecto a la parálisis facial, ¿cuál de los siguientes signos y síntomas nos haría pensar en un origen central?

1. La presencia de ageusia asociada a la parálisis facial.
2. La presencia de hipoestesia o dolor en la región del pabellón auricular del mismo lado que la parálisis.
3. Si la debilidad de los músculos faciales solo afecta a la mitad inferior de la hemicara afectada sin afectación de los músculos palpebrales ni de la frente.
4. Si hay disminución de la secreción lacrimal en

el ojo correspondiente al lado de la parálisis facial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre la distinción entre parálisis facial de origen central y periférico. En este caso, la debilidad limitada a la mitad inferior de la cara (opción 3 correcta) es característica de una lesión central, como un accidente cerebrovascular o una lesión de las vías corticobulbares (superiores al núcleo del nervio facial). Las demás opciones son indicativas de una lesión periférica: la ageusia y la disminución de la secreción lacrimal sugieren afectación del nervio facial a nivel proximal (opción 1 y 4 incorrectas). Por otro lado, es muy frecuente que los pacientes refieran hipoestesia hemifacial ipsilateral en los primeros momentos del cuadro por un mecanismo no del todo conocido; el dolor auricular por su parte está asociado al síndrome de Ramsay Hunt, que además cursa con parálisis facial y vesículas en el conducto auditivo externo (opción 2 incorrecta).

81. Hombre de 75 años con antecedentes de fibrilación auricular e hipertensión arterial es traído a urgencias por hemiparesia derecha, dificultad para hablar y fiebre de 38,5°C. La tomografía computarizada (TC) de cráneo revela un infarto cerebral en la región parietal izquierda e ingresa en la unidad de ictus. A las 48 horas del ingreso se informa de presencia de Streptococcus viridans en hemocultivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el enfoque diagnóstico-terapéutico adecuado en este caso?

1. Accidente cerebrovascular isquémico secundario a fibrilación auricular; iniciar anticoagulación y antipiréticos.
2. Meningitis bacteriana con complicación isquémica; realizar punción lumbar e iniciar antibiótico dirigido según antibiograma.
3. Endocarditis infecciosa con embolia séptica; confirmar con ecocardiograma y tratar con antibiótico dirigido según el antibiograma.
4. Neoplasia cerebral con fiebre paraneoplásica; realizar resonancia magnética cerebral y evaluación oncológica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy fácil sobre un cuadro clínico de endocarditis. Fiebre + clínica neurológica embólica + hemocultivos positivos para una bacteria típica de endocarditis.

82. Mujer de 55 años que consulta por una cefalea con sensación de presión bilateral, que no asocia fotofobia, náuseas ni vómitos. La paciente puede realizar sus actividades habituales porque el dolor es de intensidad moderada. El dolor es prácticamente diario en los últimos 6 meses. Desde el punto de vista terapéutico, ¿cuál es la opción más adecuada?

1. Tratamiento analgésico simple con paracetamol diario, los días que tenga dolor.
2. Tratamiento con triptanes en el momento agudo de la cefalea los días que sea más intensa.
3. Tratamiento preventivo de entrada con betabloqueantes tipo propranolol a dosis entre 40-160 mg/d entre 3-6 meses.
4. Tratamiento preventivo de entrada con amitriptilina a dosis bajas entre 25-50 mg/d y mantenerlo entre 3 y 6 meses.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre la cefalea tensional crónica, cuyo tratamiento de elección es la amitriptilina, un antidepresivo tricíclico que se usa en cefaleas a dosis bajas, que puede tener un efecto anticolinérgico y por eso hay que evitar paularlo en ancianos, en los que sería preferible usar mirtazapina.

83. Mujer de 18 años sin antecedentes de interés ni consumo de tóxicos que ingresa en planta por un cuadro de alteración conductual con ansiedad, agresividad e ilusiones visuales. Durante su ingreso presenta una crisis convulsiva junto con discinesias orolinguales y distonía del pie izquierdo. Dos semanas previas había presentado un cuadro de diarrea, náuseas y vómitos autolimitados. Respecto a este síndrome señale la respuesta INCORRECTA:

1. La encefalitis anti NMDAR es la encefalitis autoinmune más frecuente.
2. La RM con hiperesinal hipocampal es patognomónica de la enfermedad.
3. Existe una fuerte asociación con patología tumoral.
4. El pronóstico habitualmente es favorable.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre encefalitis autoinmunes, un tema en auge en Neurología. Presentan un caso clínico característico de encefalitis anti-NMDAR (alteraciones conductuales + crisis epiléptica + trastornos del movimiento). Este tipo de encefalitis pueden desencadenarse tras una infección: es típica tras una infección estreptocócica en pacientes en edad pediátrica o adultos jóvenes. La incorrecta es la opción 2, no existe una RM craneal patognomónica para esta enfermedad; de hecho, es habitual que la RM no muestre anomalías significativas pudiendo ser completamente normal. El resto de opciones son correctas: es la encefalitis autoinmune más frecuente, tiene una asociación característica con el teratoma ovárico, y su pronóstico es habitualmente favorable, con buena respuesta a la inmunoterapia.

84. Hombre de 81 años con antecedentes de HTA, dislipemia y enfermedad de Alzheimer leve. Avisa a su familia porque lo han encontrado en su casa caído en el suelo y no es capaz de movilizar

extremidades derechas. Llega al hospital trasladado por emergencias como código ictus. A la exploración física destaca paresia facial derecha supranuclear, afasia global, hemianopsia derecha y hemiplejía de miembros derechos. La TC craneal se informa como ASPECTS 8 sin datos de sangrado. En angioTC oclusión de segmento M2 de división anterior de ACM izquierda. ¿Cuál de los siguientes es el mejor tratamiento inicial para este paciente?

1. Fibrinólisis con alteplasa.
2. Doble antiagregación y estatinas.
3. Manejo conservador por los antecedentes del paciente.
4. Trombectomía mecánica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un ictus del que no conocemos el tiempo de evolución, pero que tiene un ASPECTS de 8, relativamente bueno (recordemos que es una escala que evalúa de 0 -mala a 10 puntos -bien- el territorio neurovascular de la arteria cerebral media), por lo que, aunque lo ideal sería hacer una prueba de imagen multimodal como la TC de perfusión, lo que nos están queriendo decir es que estamos a tiempo de salvar buena parte de su cerebro mediante una terapia de reperusión. Una enfermedad de Alzheimer es una contraindicación relativa, según el grado de evolución, y en este caso es leve. Queda entonces la duda entre la 1 y la 4. Dado que tiene oclusión de gran vaso, y que actualmente existe evidencia IA en guías de práctica clínica para la trombectomía mecánica en ACI, M1 y M2, la opción más correcta es la 4. La fibrinólisis también sería una opción, por lo que es una pregunta polémica.

85. Sobre el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson, señale la opción correcta:

1. Los núcleos diana principales son el núcleo pálido y el núcleo ventral inferomedial del tálamo.
2. La cirugía lesional es la opción utilizada más frecuentemente hoy en día.
3. La presencia de síntomas o signos que no responden a la levodopa desaconsejan el tratamiento.
4. La estimulación eléctrica de los núcleos genera una activación de los mismos, principio fundamental del tratamiento.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla del tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Parkinson. La cirugía lesional está en desuso, y lo que se utiliza es la estimulación cerebral profunda. El núcleo diana en la cirugía de estimulación profunda en la enfermedad de Parkinson suele ser el núcleo subtalámico (menos frecuentemente el pálido interno). La estimulación eléctrica provoca una inhibición del núcleo

(es paradójico, pero realmente hiperpolariza las neuronas circundantes). La indicación de cirugía es que el paciente tenga una buena respuesta a levodopa (la cirugía consigue la misma respuesta que la medicación, solo que de manera estable y sin fluctuaciones).

86. El APACHE-II (Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation II) es un índice cuantitativo de gravedad que se calcula en el paciente crítico utilizando las siguientes variables, EXCEPTO:

1. Recuento de leucocitos en sangre.
2. Escala de coma de Glasgow.
3. Lactato en sangre.
4. pH en sangre.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta compleja ya que es puramente memorística y hace referencia a una escala de evaluación preanestésica que apenas se usa hoy en día. El score APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) es un sistema de puntuación utilizado para evaluar la gravedad de la enfermedad en pacientes críticos y predecir la mortalidad hospitalaria. Este sistema se basa en una combinación de parámetros fisiológicos, datos de laboratorio y variables relacionadas con la salud crónica del paciente, no con el procedimiento quirúrgico al que se van a someter (igual que ocurre en la clasificación ASA). A mayor puntuación en el score, más riesgo de muerte. Los parámetros que cuantifica este score son los siguientes: edad, temperatura corporal, frecuencia cardíaca, presión arterial media (PAM), frecuencia respiratoria, PaO₂ (presión arterial de oxígeno), FiO₂, pH arterial, bicarbonato arterial, glucosa, BUN (urea o nitrógeno ureico en sangre), bilirrubina, creatinina, sodio, potasio, hematocrito, recuento de leucocitos, producción de orina, glasgow, enfermedades crónicas, y si la cirugía es de emergencia. La respuesta correcta es la 3, ya que el lactato no es un parámetro utilizado en el score APACHE.

87. Mujer de 57 años ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos por hipotensión persistente y fracaso multiorgánico. Tras monitorización hemodinámica avanzada, la paciente presenta frecuencia cardíaca de 105 lpm, resistencias vasculares sistémicas de 400 din.seg.m-5/cm², gasto cardíaco de 8 L/min, presión venosa central de 5 mmHg, variación del volumen sistólico del 9% e índice de agua pulmonar extravascular indexado de 5 mL/kg. ¿A qué tipo de shock orienta dicha monitorización hemodinámica avanzada?

1. Shock distributivo.
2. Shock cardiogénico.
3. Shock hipovolémico.
4. Shock obstructivo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia sobre el diagnóstico diferencial del shock. La dificultad radica en que hacen referencia a valores numéricos concretos de las distintas variables. Nos dicen que esta paciente está ingresada en la UCI por hipotensión y fracaso multiorgánico (es decir, un shock). La paciente presenta una frecuencia cardíaca aumentada (podríamos descartar que se trate de un shock neurogénico, que cursaría con bradicardia). La resistencia vascular periférica está disminuida (oscilan entre 800 y 1200 din · seg · m²/cm⁵). El gasto cardíaco está aumentado (oscila entre 4 y 8 L/min). Solo con esta información ya podríamos diagnosticar a la paciente de un shock distributivo séptico o anafiláctico (respuesta correcta 1), ya que es el único en el que tenemos resistencia vascular disminuida y gasto cardíaco aumentado.

88. Mujer de 63 años, diabética en tratamiento con antidiabéticos orales que consulta por dolor en hombro derecho de 3 meses de evolución sin antecedente traumático. El dolor le limita el movimiento completo del hombro y desde hace una semana le impide el descanso nocturno. En la exploración el médico constata limitación para el movimiento activo de la abducción a más de 100°, de la flexión a 110°, rotación externa a 45° e interna lleva la mano al glúteo con dificultad. No presenta limitación en la movilidad pasiva de la extremidad. La orientación diagnóstica más probable y la actuación inicial es:

1. Tendinosis del manguito rotador. Crioterapia, AINEs tópicos y cabestrillo una semana.
2. Tendinosis del supraespinoso derecho. Crioterapia 3 veces al día e indicar fisioterapia.
3. Tendinosis del supraespinoso derecho. Infiltración, paracetamol cada 8 horas y solicitar resonancia magnética.
4. Tendinosis del supraespinoso derecho. Crioterapia, AINEs orales y ejercicios en su domicilio. Visita de control y si no mejora solicitar prueba de imagen.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La clínica y exploración son características de una tendinosis degenerativa (sin traumatismo) del supraespinoso: limitación de la movilidad activa sin limitación de la movilidad pasiva. La actuación inicial correcta (opción 4) incluye medidas conservadoras: frío, antiinflamatorios y ejercicios. Si no existe mejoría en un periodo prudencial (4-6 meses) se plantearían pruebas de imagen. Las otras opciones son incorrectas: el cabestrillo (opción 1) está contraindicado por favorecer la rigidez; la tendinosis cálcica suele cursar en pacientes más jóvenes, con mayor limitación a movilidad y dolor más acusado en 'crisis' (opción 2); y la infiltración y solicitud directa de RM (opción 3) no son apropiadas como tratamiento inicial.

89. Jugador de baloncesto de 42 años que acude a urgencias por dolor de tres días de evolución en cara anterior de muslo derecho de tipo

lancinante. Inicia el dolor tras mal gesto en flexión de la columna lumbar, presentando primero lumbalgia y después este dolor irradiado. En la exploración presenta un Lasegue invertido positivo, con un reflejo osteotendinoso rotuliano derecho 2/4. No hay déficit motor. La orientación diagnóstica más probable es:

1. Hernia discal L4-L5 migrada posterior que ocasiona una clínica de silla de montar.
2. Hernia discal foraminal L4-L5 derecha que comprime la raíz de L4.
3. Hernia discal foraminal L4-L5 derecha que comprime la raíz de L5.
4. Meralgia parestésica derecha.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En esta pregunta nos exponen el cuadro clínico típico de lumbociatalgia, en el que quieren que digamos la raíz afectada según el territorio de dolor radicular afecto, el déficit motor, el sensitivo y el reflejo afecto. El territorio de dolor es la cara anterior del muslo, esto es, el territorio de L4. No dan déficit motor, lo que descarta signos de alarma. Nos dan un Lasègue invertido positivo, lo cual indica que tiene un dolor radicular, y lo único que clásicamente sí que daban cuando hablaban de la radiculopatía L4, y en este caso no lo hacen, es la afectación del el reflejo rotuliano, que en el MIR se ha asociado típicamente a la afectación de L4. Es, por tanto, un caso no completo, pero con los datos que nos dan, lo más plausible es pensar en una hernia discal lumbar posterolateral en L3-L4 que afecta a la raíz de L4; sin embargo, no aparece esta opción entre las del enunciado. Sí que aparece la opción de hernia discal lumbar foraminal L4-L5 que comprime L4 (por el foramen de L4-L5 sale la raíz de L4); las hernias son más frecuentemente posterolaterales, que en lugar de comprimir a la raíz que sale por el nivel, comprimen a la que pasa por ese nivel para salir por el inmediatamente inferior. No nos dan el caso más frecuente, pero sí nos dan una posible opción correcta. El síndrome de cauda equina es una hernia extruida que comprime todas las raíces de la cola de caballo; causaría anestesia en silla de montar, a nivel del periné (opción 1 falsa). La meralgia parestésica es una neuropatía compresiva por compresión del nervio femorocutáneo que cursa con un cuadro clínico diferente (opción 4 falsa).

90. Paciente de 75 años con estancia prolongada en UCI. En una exploración rutinaria se observa dificultad para la flexión dorsal del pie izquierdo con un tibial anterior a 1/5, una dificultad para la extensión de los dedos a 1/5 y dificultad para la eversión con peroneos 3/5. No presenta otro foco neurológico, ni dolor en la región lumbar ni en la extremidad. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más correcta?

1. Indicar férula antiequino y fisioterapia por sospecha de compresión del nervio ciático poplíteo externo.

2. Solicitar electromiograma urgente y dejarlo en reposo.
3. Realizar punción lumbar por sospecha de complicación por Guillain-Barre.
4. Solicitar resonancia magnética y pautar, si no está recibiendo, corticoides.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil. El paciente presenta una debilidad acotada a la musculatura dependiente del nervio peroneo común (ciático poplíteo externo), con un antecedente (ingreso en UCI) que sugiere una compresión prolongada del nervio (probablemente secundario a déficits de cambios posturales por el encamamiento prolongado). El tratamiento inicial es conservador con férula antiequino y fisioterapia para evitar deformidades rígidas. El resto de pruebas no cambian este manejo inicial y no existen otros signos que indiquen enfermedad a otro nivel.

91. Mujer de 19 años que, practicando patinaje sobre ruedas, sufre un traumatismo indirecto de la rodilla derecha, con luxación de rótula tratada en urgencias. Acude a revisión 2 meses más tarde y refiere que nota dolor y sensación de inestabilidad y subluxación frecuente con la actividad física. De los siguientes elementos, señale el que NO favorece la inestabilidad fémoro-patelar:

1. Anteversión femoral.
2. Torsión tibial interna.
3. Genu valgo.
4. Patela alta.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos hablan de la inestabilidad femoropatelar, que condiciona luxaciones de rótula recidivantes. En general lo favorece todo lo que saque la rótula de su carril (tróclea) y al incremento del “ángulo Q” (Q de “cuadriceps”, es el vector de contracción: si es mayor es más hacia externo, desplazando la rótula hacia fuera). Anteversión, genu valgo y torsión tibial EXTERNA aumentan el ángulo Q desplazando la rótula externamente y promoviendo la inestabilidad (respuesta 2 falsa). La patella alta aumenta la inestabilidad al estar menos excavado el surco troclear a ese nivel en el fémur.

92. Desde el punto de vista fisiopatológico la osteonecrosis de la cabeza femoral se puede desencadenar por todos los mecanismos aquí descritos EXCEPTO:

1. Anomalías en el flujo vascular por factores genéticos.
2. Oclusión intravascular por émbolos (lípidos, nitrógeno, hematíes anémicos).
3. Dehiscencia de la íntima arterial de los vasos.
4. Compresión extravascular a consecuencia de un estímulo graso.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta muy difícil. La etiopatogenia de la necrosis avascular femoral puede producirse por mecanismos que comprometen la vascularización ósea, estando descritos factores mecánicos traumáticos (fracturas, luxación de cadera), anomalías en el flujo vascular (hipercoagulabilidad, hemofilia que condiciona hemorragias), oclusión intravascular (anemia falciforme, émbolos grasos o gaseosos) o compresión extravascular por acúmulo graso en condiciones como el alcoholismo o corticoterapia, donde aumenta la presión intraósea por infiltración grasa. Sin embargo, la dehiscencia de la íntima arterial de los vasos (opción 3) no es un mecanismo descrito en la fisiopatología de la necrosis avascular.

93. Mujer de 68 años con IMC 28 kg/m² que consulta por dolor crónico en rodilla derecha. Refiere que el dolor empeora con la actividad física, especialmente al subir y bajar escaleras, y mejora con el reposo. En la exploración física se observa crepitación en la rodilla derecha y leve deformidad en ambas. Una radiografía de rodilla derecha muestra estrechamiento del espacio articular y formación de osteofitos. ¿Cuál es la opción de tratamiento más adecuada en este caso?

1. Inmovilización de la rodilla con rodillera de descarga rotuliana.
2. Pérdida de peso y ejercicio físico supervisado para fortalecer el cuádriceps.
3. Infiltración intraarticular de corticoides.
4. Tratamiento farmacológico con tramadol.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

“Estrechamiento del espacio articular y formación de osteofitos”: nos están describiendo signos radiológicos de artrosis. El tratamiento de primera línea, especialmente en pacientes con sobrepeso, debe incluir medidas no farmacológicas. La combinación de pérdida de peso, analgésicos de primer escalón y ejercicio físico supervisado (opción 2) es el tratamiento más adecuado.

94. Hombre de 30 años que acude a consulta por dolor lumbar crónico que empeora en la noche y mejora con el ejercicio. Refiere rigidez matutina de más de una hora. La exploración física revela una disminución de la movilidad en la columna lumbar y dolor a la palpación y exploración de las articulaciones sacroilíacas. La resonancia magnética muestra edema en las articulaciones sacroilíacas compatible con sacroileitis. ¿Cuál es el tratamiento inicial más indicado para este paciente?

1. Metotrexato subcutáneo semanal.
2. Corticoides orales.
3. Fisioterapia y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).
4. Terapia biológica con anti-TNF.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La primera línea de tratamiento en este paciente con espondiloartropatía es la combinación de fisioterapia y ejercicio (es fundamental, recuerda que el reposo está contraindicado porque favorecería la anquilosis) y AINEs (primero se prueba uno de ellos concediéndole un margen de 2-4 semanas; de no producirse respuesta satisfactoria se prueba otro AINE que, de fracasar, conduciría a la incorporación de terapias de mayor complejidad).

95. Mujer de 83 años hospitalizada por neumonía adquirida en la comunidad por neumococo. Presenta una artritis aguda de carpo derecho. Sospechamos enfermedad por depósito de pirofosfato pero no se observa condrocalcinosis en la radiografía de carpos ni se ha conseguido obtener líquido sinovial durante la artrocentesis. ¿Qué radiografías añadiremos al cribado con el objetivo de identificar condrocalcinosis?

1. Radiografía anteroposterior de rodillas y de sínfisis de pubis.
2. Radiografía anteroposterior de rodillas y de hombros.
3. Radiografía anteroposterior de sínfisis de pubis y de hombros.
4. Radiografía anteroposterior de rodillas y de codos.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Ante la sospecha de condrocalcinosis, como en otras artritis microcristalinas, el diagnóstico de elección es la visualización de cristales al microscopio. Sin embargo, en algunos casos, como en este, no es posible obtener líquido sinovial. Dado que en la condrocalcinosis los depósitos son cálcicos, pueden identificarse mediante pruebas de imagen, como la radiografía o la ecografía. Las localizaciones típicas donde se observan los depósitos de pirofosfato cálcico, y por tanto las radiografías que se solicitan ante la sospecha de esta enfermedad, incluyen: rodillas (observaremos calcificación en cartilago femoral y meniscos), carpo (ligamento triangular del carpo) y pelvis (calcificación en la sínfisis del pubis). Respuesta correcta: 1.

96. Uno de estos hallazgos anatomopatológicos sugiere el diagnóstico de enfermedad por IgG4:

1. Trombosis arterial.
2. Proliferación de la íntima arterial sin datos de vasculitis.
3. Fibrosis estoriforme.
4. Infiltrado perivascular de polimorfonucleares.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El hallazgo anatomopatológico más característico de la enfermedad por IgG4 es la fibrosis estoriforme (respuesta correcta: 3), en la cual los fibroblastos y las fibras de colá-

geno adoptan un patrón arremolinado distintivo. Las demás opciones no son específicas: la trombosis arterial, aunque puede presentarse en diversas patologías vasculares, no es un hallazgo distintivo de la enfermedad por IgG4 (respuesta 1 incorrecta); la proliferación de la íntima arterial sin vasculitis es un hallazgo inespecífico y no característico de esta enfermedad (respuesta 2 incorrecta); el infiltrado característico de la enfermedad por IgG4 son células plasmáticas IgG4+ y linfocitos, no polimorfonucleares (respuesta 4 incorrecta).

97. ¿Cuál de los siguientes hallazgos NO esperaría encontrar en una mujer de 28 años con una comunicación interauricular evolucionada?

1. Soplo mesosistólico.
2. Aumento de la silueta cardíaca en la radiografía de tórax.
3. Bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma.
4. Hipertrofia del ventrículo izquierdo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que repasa las repercusiones cardíacas de una comunicación interauricular evolucionada. La pregunta se responde recordando que las cardiopatías congénitas de tipo “agujero” (CIA, CIV, DAP) afecta al ventrículo que haya “más allá” de la cavidad que recibe la sangre extra provocada por el shunt. Así, la CIA (que shunta a la aurícula derecha) afecta al ventrículo derecho, mientras que la CIV (que shunta en el ventrículo derecho) y el DAP (que shunta en la arteria pulmonar) afectan al ventrículo izquierdo. Por ello, en una CIA habrá dilatación de ventrículo derecho y bloqueo de rama derecha, pero no habrá afectación del ventrículo izquierdo. En una CIV y un DAP, habrá dilatación de ventrículo izquierdo (tampoco habría hipertrofia).

98. Joven de 16 años con astenia desde hace 1 mes, que durante un partido de fútbol sufre un síncope. A su llegada al hospital inconsciente y hemodinámicamente inestable presenta síntomas y signos de accidente cerebrovascular, de isquemia mesentérica y de isquemia arterial periférica en miembro superior izquierdo y de ambos miembros inferiores. ¿Cuál cree que es el diagnóstico de sospecha?

1. Bloqueo auriculoventricular de 3° grado.
2. Insuficiencia mitral aguda.
3. Mixoma de aurícula izquierda.
4. Rotura de aneurisma de arteria cerebral media.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuadro clínico difícil, pero pregunta de dificultad moderada por las opciones entre las que hay que elegir. De las opciones que nos proponen, la única capaz de provocar un fenómeno embólico masivo (isquemia aguda simultánea de varios territorios independientes) es el mixoma auricular. El

mixoma es el tumor cardíaco más frecuente; en el 75% de los casos se localiza en la aurícula izquierda, habitualmente adherido al tabique interauricular por un pedículo. Clínicamente puede provocar síntomas por obstrucción al protruir por la válvula mitral durante la diástole (síncope, disnea, etc.); además, puede generar fenómenos embólicos y síntomas sistémicos (síndrome constitucional, fiebre, rash, etc.). El diagnóstico se realiza por técnicas de imagen (ecocardiograma, RM) y el tratamiento es quirúrgico.

99. Hombre de 65 años, hipertenso desde hace 12 años, que acude por primera vez a la consulta de su médico de familia para una revisión rutinaria. La exploración física es normal y el electrocardiograma muestra ritmo sinusal a 68 lpm, con bloqueo de la rama izquierda del haz de His y duración del QRS de 150 ms. ¿Cuál de las siguientes situaciones implica este hallazgo?

1. Asincronía ventricular.
2. Miocardiopatía dilatada.
3. Disociación auriculoventricular.
4. Isquemia miocárdica aguda.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los bloqueos de rama generan un problema de asincronía en la contracción de los dos ventrículos; normalmente, los dos ventrículos se activan a la vez (si las dos ramas del haz de His funcionan correctamente) y por tanto se contraen a la vez. Si existe un bloqueo de rama, primero se activará un ventrículo y luego el otro; por lo tanto, primero se contraerá un ventrículo y luego el otro.

100. Un entrenamiento aeróbico intenso y prolongado produce una serie de adaptaciones cardiovasculares que suelen denominarse corazón de deportista. Entre las siguientes adaptaciones fisiológicas, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Bradicardia sinusal por aumento del tono vagal.
2. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado Mobitz I e incluso de tercer grado durante el sueño.
3. Bloqueo completo de rama izquierda del haz de His por hipertrofia ventricular izquierda.
4. Bloqueo de rama derecha del haz de His por dilatación fisiológica ventricular derecha en deportes de resistencia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El corazón de atleta es un término que hace referencia a las adaptaciones fisiológicas del corazón ante el entrenamiento físico intenso o de competición. Se trata de una condición fisiológica (no una enfermedad), y que revertirá tras unos meses si el individuo abandona el entrenamiento. Desde el punto de vista morfológico, en la mayoría de deportes, que combinan fuerza y resistencia (deportes de equipo, atletismo

excluyendo largas distancias, etc.), se produce remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo con hipertrofia simétrica. Los ejercicios de resistencia extrema (maratón, ciclismo en ruta, esquí de travesía...), por el contrario, conllevan un remodelado excéntrico con dilatación biventricular. Desde el punto de vista eléctrico, en los atletas predomina en reposo el tono parasimpático, lo que reduce la frecuencia cardíaca (bradicardia sinusal) y puede enlentecer la conducción de los latidos a través del sistema de conducción. Es fisiológico encontrar en atletas diferentes grados de bloqueo aurículo-ventricular en reposo (especialmente durmiendo, cuando es habitual encontrar rachas de bloqueo completo), y también bloqueo de rama derecha. Es patológico, sin embargo, encontrar bloqueo de rama izquierda; el bloqueo de rama derecha es una condición que puede ser fisiológica (es muy habitual encontrarlo en gente joven y en deportistas), pero el bloqueo de rama izquierda nunca se puede considerar fisiológico. Ante el hallazgo de un bloqueo de rama izquierda en cualquier individuo, se debe solicitar un ecocardiograma para descartar cardiopatía estructural. El 90% de las ocasiones el bloqueo de rama izquierda es idiopático y no requerirá seguimiento ni tratamiento, pero en el 10% de ocasiones restante es la manifestación de una cardiopatía estructural subyacente (por ejemplo, es típico encontrarlo en las miocardiopatías dilatadas).

101. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más frecuente en el reemplazo valvular aórtico transcáteter (TAVI) respecto del reemplazo valvular quirúrgico?

1. Atelectasia pulmonar.
2. Bloqueo auriculoventricular completo.
3. Derrame pericárdico.
4. Hemorragia grave.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta teórica difícil sobre las complicaciones de las dos modalidades de implante de prótesis valvular aórtica: TAVI (implante percutáneo) o SAVR (cirugía abierta). Las TAVI se implantan “hinchando” la prótesis, que viene plegada, sobre el anillo aórtico del paciente; esto implica un riesgo aumentado de bloqueo de rama izquierda y de bloqueo auriculo-ventricular (que requiera implante de marcapasos), dado que el haz de His y la rama izquierda pasan justo por debajo del plano de la válvula aórtica y pueden “comprimirse” al hinchar la válvula; este riesgo es mayor con válvulas autoexpandibles (se hinchan solas) que con válvulas balón-expandibles (las expande el operador inflando un balón a su criterio, de modo que puede ajustar mejor la presión que ejerce). Otras complicaciones más frecuentes con TAVI respecto a SAVR son las complicaciones vasculares (por el acceso arterial femoral) y los leaks perivalvulares (que la válvula no quede totalmente pegada al anillo aórtico del paciente y exista un hueco -leak- entre ellos por el que se “fugue” la sangre, provocando insuficiencia aórtica). La cirugía abierta tiene, respecto a la TAVI, mayor riesgo de sangrados graves, insuficiencia renal aguda y fibrilación auricular peri-procedimiento. El riesgo de ictus es similar entre las dos técnicas.

102. Señale cuál de las siguientes situaciones se considera indicación de cirugía para el tratamiento de endocarditis infecciosa (EI):

1. Aparición de insuficiencia renal aguda.
2. Hallazgo por imagen de émbolos esplénicos o renales en el momento del diagnóstico.
3. Presencia de vegetaciones mayores de 8 mm en válvula tricúspide en la EI derecha.
4. Hemocultivos positivos persistentes durante 7-10 días tras pauta antibiótica adecuada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre las indicaciones quirúrgicas de la endocarditis, tema preguntado en los 3 años anteriores en el MIR. Recuerda que podemos resumir las indicaciones quirúrgicas en 3 grupos: datos de insuficiencia cardíaca, datos de persistencia de infección (opción 4 cierta) y prevención de embolismos. Las dudas razonables son las opciones 2 y 3, pero recuerda que las vegetaciones deben ser mayores de 10 mm.

103. Hombre de 68 años, hipertenso y fumador que acude a urgencias por dolor torácico y disnea desde hace 3 horas. Presenta mal estado general, presión arterial 118/45 mmHg, FC 105 lpm, saturación O₂ 96%. En la auscultación crepitantes basales finos, tonos cardíacos atenuados, que no permiten identificar soplos. D-dímero 16.000 ng/mL. El ECG muestra taquicardia sinusal y signos de hipertrofia ventricular izquierda. Un ecocardiograma urgente revela un ventrículo izquierdo hipertrófico, no dilatado, con disfunción sistólica global ligera, insuficiencia aórtica moderada, no conocida previamente y derrame pericárdico moderado-grave. Con estos datos, ¿qué patología debe descartar?

1. Disección de aorta proximal.
2. Infarto agudo de miocardio complicado con rotura de músculo papilar.
3. Tromboembolismo pulmonar masivo.
4. Pericarditis efusivo-constrictiva.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada. Ante un dolor torácico inespecífico con elevación de d-dímeros debemos pensar en un tromboembolismo de pulmón o en un síndrome aórtico agudo. No nos informan de ninguna calidad del dolor que nos oriente a una etiología concreta, como “transfixivo” en la disección de aorta u “opresivo” en la angina de pecho. En este caso, la saturación de oxígeno es normal (va en contra de un tromboembolismo de pulmón), y en cambio hay datos ecocardiográficos típicos de disección de aorta, como la presencia de insuficiencia aórtica (funcional por dilatación de la raíz aórtica disecada) o derrame pericárdico (por extravasación de sangre de la aorta hacia el espacio pericárdico); en un tromboembolismo de pulmón, en el ecocardiograma

esperaríamos o bien hallazgos normales, o bien dilatación/difunción de ventrículo derecho en casos graves. Nos indican que existe hipertrofia de ventrículo izquierdo para que pensemos que el paciente es hipertenso (factor de riesgo para desollar disección de aorta); el otro dato clínico típico de las disecciones de aorta (asimetría de pulsos o tensión arterial diferencial entre las 4 extremidades) faltaría en este caso.

104. Hombre de 71 años portador de un marcapasos bicameral por bloqueo AV completo. Está en ritmo sinusal a 85 lpm con ritmo ventricular estimulado por el marcapasos. La interrogación del marcapasos muestra un porcentaje de estimulación ventricular del 99%. En el ecocardiograma tiene dilatación y disfunción sistólica de ambos ventrículos. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es del 30% y tiene insuficiencia mitral funcional grave. No tiene lesiones obstructivas en la coronariografía. Está en clase funcional III NYHA a pesar de tratamiento médico óptimo para la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida. ¿Cuál de las siguientes es la primera opción de tratamiento?

1. Cirugía de reparación valvular.
2. Cirugía de sustitución valvular.
3. Terapia de resincronización cardiaca.
4. Mitra-Clip.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil. La estimulación ventricular mediada por un marcapasos convencional, con el electrodo implantado en el ápex del ventrículo derecho, genera un QRS ancho similar a un bloqueo de rama izquierda y produce asincronía en la contracción ventricular; como el marcapasos estimula en el ventrículo derecho, primero se activa dicho ventrículo y luego el izquierdo. Esto puede provocar un deterioro de la FEVI en algunos pacientes. Si la FEVI baja a $\leq 35\%$ y el paciente está sintomático a pesar de tratamiento médico óptimo, estaría indicado realizar un upgrade a un resincronizador (implantar un electrodo adicional en ventrículo izquierdo para poder realizar una estimulación biventricular que evite la asincronía; la indicación es análoga a la del implante de un resincronizador en IC con FEVI deprimida, dado que la estimulación mediada por marcapasos es equivalente a tener un bloqueo de rama); otra alternativa válida sería implantar un electrodo en el área de la rama izquierda (estimulación fisiológica) y estimular con dicho electrodo en lugar del implantado en el ventrículo derecho. Asimismo, si un paciente con FEVI $< 40\%$ tiene indicación de estimulación por marcapasos, debemos implantar un marcapasos-resincronizador o un marcapasos con estimulación fisiológica en lugar de uno convencional, para evitar que la FEVI se deteriore todavía más. En el enunciado destacan que el porcentaje de latidos estimulados por el marcapasos es del 99% (esto es, casi todos los latidos del paciente); para pensar que la estimulación de un marcapasos es lo que está provocando el deterioro de

FEVI apreciado en un paciente concreto, se considera que debe haber por lo menos un 40% de latidos estimulados por el marcapasos. El paciente tiene también insuficiencia mitral grave, pero nos dicen que es FUNCIONAL (esto es, la válvula no está enferma, sino que la insuficiencia se debe a que el ventrículo izquierdo se ha dilatado); si corregimos la asincronía, la FEVI y los volúmenes ventriculares podrían normalizarse, y eso corregiría la insuficiencia mitral sin necesidad de realizar ninguna operación sobre la válvula.

105. Neonato de 10 días de vida que es traído por sus padres a los servicios de urgencias por presentar, desde hace 24 horas, rechazo de las tomas e hipotonía generalizada. Tras pruebas complementarias, se diagnostica de coartación de aorta preductal crítica. El paciente evoluciona en pocas horas hacia el shock cardiogénico. En este contexto, ¿cuál debe ser el primer tratamiento para mejorar la hemodinámica de este paciente?

1. Iniciar perfusión continua con prostaglandinas.
2. Administrar tratamiento con ibuprofeno.
3. Plantear cirugía de carácter emergente.
4. Realizar cateterismo y atrioseptostomía de Rashkind urgente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad alta sobre la coartación de aorta preductal. El tipo de coartación de aorta más frecuente es el postductal, que se manifiesta en la adolescencia o edad adulta como hipertensión arterial al tomar la PA en los brazos, y gradiente de presión (valores menores de PA) al tomar la PA en las piernas. La coartación de aorta preductal es más infrecuente, y suele dar clínica de insuficiencia cardiaca por bajo gasto cardiaco sistémico desde el periodo neonatal. En casos graves se debe garantizar un flujo sanguíneo sistémico suficiente, para lo cual se mantiene abierto el ductus arterioso con prostaglandina E1 tras el nacimiento (aunque la sangre que se dirija al hemicuerpo inferior y al brazo izquierdo esté desaturada al proceder del ductus, por lo menos así se garantiza la perfusión de dicha porción del organismo).

106. Mujer de 46 años que tras 10 años de mastectomía derecha con vaciamiento ganglionar seguida de quimioterapia y radioterapia presenta linfedema de brazo derecho de larga evolución con importante edema y empastamiento, sin signos de celulitis. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas NO está recomendada?

1. Realización de actividad física con elevación del miembro superior derecho.
2. Terapia física con fisioterapia descongestiva.
3. Diuréticos para reducir edema.
4. Liposucción.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuando un tumor de mama requiere una linfadenectomía

axilar/vaciamiento ganglionar, la complicación crónica más importante es el linfedema. Este es diferente al edema, pues es un acúmulo de linfa, un líquido con gran contenido proteico, en el tejido celular subcutáneo; a diferencia del edema típico, que se debe al líquido extravasado del sistema vascular. El linfedema, crónicamente, por el acúmulo proteico, puede producir fibrosis. Por este motivo, hay que favorecer el drenaje linfático con ejercicios específicos y fisioterapia. La liposucción es una opción en linfedemas crónicos para reducir la fibrosis extensa. Los diuréticos, en este caso, no tendrían ningún efecto y podrían incluso empeorar la fibrosis al aumentar la concentración proteica en el espacio extracelular al eliminar agua.

107. En un paciente que tras una embolectomía por isquemia arterial aguda secundaria a un émbolo en la bifurcación aorto-iliaca, presenta hipotensión, hipercalcemia, mioglobulinuria, insuficiencia renal. ¿Cuál de entre los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Trombosis arterial recurrente.
2. Síndrome de reperfusión.
3. Necrosis muscular.
4. Neuropatía isquémica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Difícil por ser un concepto novedoso, nunca antes preguntado en el MIR, ya que se trata de un síndrome de reperfusión (respuesta 2 CORRECTA). Es un fenómeno que ocurre cuando se restaura el flujo sanguíneo a un tejido previamente isquémico, como en casos de compresión prolongada (síndrome compartimental, torniquetes) o tras cirugía/intervencionismo vascular de una oclusión arterial (como en este caso). Esta reperfusión provoca un daño por estrés oxidativo, inflamación y liberación de metabolitos tóxicos acumulados durante la isquemia (como potasio, ácido láctico y mioglobina). La clínica es la que nos presentan en el caso clínico: hipotensión (por tercer espacio y vasoplejia), hiperpotasemia, acidosis metabólica, hipercalcemia (a diferencia del síndrome de lisis tumoral, que produce hipocalcemia por hiperfosforemia), mioglobulinuria y fracaso renal agudo, además de sintomatología muscular local (dolor, inflamación y debilidad muscular en la extremidad afectada).

108. Hombre de 55 años con hipertensión arterial y dislipemia que consulta por disnea de esfuerzo. Presenta en la ecocardiografía válvula aórtica bicúspide con área valvular aórtica de 0,9 cm², gradiente transvalvular de 45 mmHg, velocidad pico de 5,5 m/seg, raíz aórtica de 6 cm y fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 45%. En la analítica, péptido natriurético tipo B el triple de lo normal. ¿Qué opción terapéutica le recomendaría?

1. Seguimiento por médico de atención primaria mientras esté asintomático.

2. Implante de una prótesis valvular aórtica biológica transcáteter (TAVI).
3. Valvuloplastia aórtica.
4. Cirugía de sustitución valvular aórtica y raíz.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla. Ante un aneurisma de aorta ascendente de >55 mm de diámetro, existe indicación de cirugía de remplazo de la aorta ascendente por un tubo protésico. Como el paciente tiene además valvulopatía aórtica severa (área valvular <1 cm²), el tubo implantado será valvulado (reemplazaremos también la válvula aórtica del paciente). Es más, en presencia de indicación de cirugía sobre la válvula aórtica (este paciente tiene indicación de remplazo valvular aórtico dado que tiene una estenosis severa sintomática -disnea-), el diámetro para considerar operar también un aneurisma de aorta ascendente concomitante es solamente >45 mm.

109. En la respuesta inmune innata, las células más numerosas a nivel pulmonar, que conforman la primera línea defensiva, son:

1. Neutrófilos.
2. Macrófagos.
3. Eosinófilos.
4. Mastocitos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil. Los macrófagos son las células innatas más abundantes en tejidos (por ejemplo, en los pulmones) y son esenciales para la eliminación de partículas inhaladas y microorganismos. Los neutrófilos son las células de la inmunidad innata más abundantes en la sangre.

110. Hombre de 60 años que acude a consulta por presentar tos y expectoración habitual mucosa, amarillenta, con más de 4-5 episodios de reagudizaciones al año, algunas veces con hemoptisis. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Asma.
2. Fibrosis pulmonar idiopática.
3. Bronquiectasias.
4. Insuficiencia cardíaca.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil; caso clínico típico de un paciente con bronquiectasias. La clínica típica en estos pacientes es la presencia de tos crónica productiva con broncorrea, expectoración purulenta de más de 150 ml/día (la secreción bronquial de un sujeto sano es de unos 100 ml/día) y mayor riesgo de infecciones respiratorias. En el asma nos contarían un paciente con disnea, opresión torácica y semiología de broncoespasmo (sibilancias); en la FPI nos contarían un paciente con disnea, tos seca, crepitantes y acropaquias; en la insuficien-

cia cardiaca nos contarían un paciente con disnea, ortopnea, edemas en miembros inferiores, crepitantes.

111. ¿Qué hallazgos de los descritos a continuación son MENOS probables en la exploración física de un paciente con fibrosis a nivel del intersticio pulmonar?

1. Sibilancias bilaterales en la auscultación pulmonar.
2. Crepitantes teleinspiratorios bibasales.
3. Disminución del murmullo vesicular con acropaquia.
4. Vibraciones vocales disminuidas con crepitantes tipo velcro, de carácter seco.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre la semiología de un paciente con FPI. La opción menos probable son las sibilancias bilaterales, dado que el paciente con FPI no tiene un problema bronquial, sino intersticial. Las sibilancias son ruidos inspiratorios o espiratorios que aparecen en el árbol bronquial como consecuencia del paso de aire por bronquios con disminución de su luz, por ejemplo en el asma bronquial, en el que existe inflamación y contracción de los músculos que rodean el bronquio.

112. Paciente que en revisión en consulta refiere tos matutina diaria y disnea de moderados esfuerzos (MRC 2) habitual que limita sus actividades cotidianas en tratamiento con doble terapia broncodilatadora desde hace dos años. La espirometría presenta un FEV1 del 35% del teórico en situación basal con una respuesta broncodilatadora que muestra un incremento del FEV1 de 250 mL y un 13%. En el estudio por TC se identifican áreas de enfisema centroacinar y en la analítica 250 eosinófilos/uL. En el último año ha sufrido dos exacerbaciones respiratorias, de las cuales una ha requerido ingreso hospitalario. Indique el tratamiento más adecuado:

1. Broncodilatador Beta-agonista de acción prolongada + broncodilatador antagonista muscarínico de acción prolongada + corticoide sistémico.
2. Añadir roflumilast a la terapia combinada.
3. Broncodilatador Beta-agonista de acción prolongada + broncodilatador antagonista muscarínico de acción prolongada + corticoide inhalado.
4. Broncodilatador Beta-agonista de acción prolongada + corticoide inhalado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que podemos englobar en el tema de EPOC. Nos hablan de un paciente en consulta con disnea MRC2 y bajo

tratamiento con doble terapia (LABA + LAMA). Podemos asumir con esa introducción que se va a tratar de una pregunta sobre EPOC. En toda pregunta sobre tratamiento de EPOC, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo según el estadiaje GOLD ABE. Para clasificarlo debemos saber cuántas agudizaciones con/sin ingreso hospitalario ha tenido en el último año. Al haber tenido 2, y encima una con ingreso, se trata de un grupo E. El siguiente paso sería mirar el valor de eosinófilos, si es mayor de 300 está indicado de inicio la triple terapia, si es por debajo de 300 debemos mantener doble terapia. Pero atención, en esta pregunta nos dan un valor más, la FEV1, la cual nos muestra que el paciente tiene una prueba broncodilatadora positiva (la FEV1 aumenta 200 ml o más, y más del 12%), por lo que podemos asumir que estamos ante un paciente con fenotipo mixto asma-EPOC; aunque tenga eosinófilos menores a 300, está indicada la triple terapia con LABA + LAMA + corticoide inhalado.

113. Paciente con asma mal controlada a pesar de una combinación de glucocorticoides inhalados a dosis altas y un broncodilatador Beta-agonista de acción prolongada. Ha requerido ciclos de corticoides sistémicos sin una respuesta adecuada. Presenta rinosinusitis crónica con poliposis nasal y un recuento de eosinófilos de 400 células/pL en la analítica. Señale la respuesta correcta en cuanto al fenotipo asmático y la mejor opción de tratamiento.

1. Se trata de un asma eosinofílica (T2) y una buena opción de tratamiento sería añadir omalizumab.
2. Se trata de un asma eosinofílica (T2) y una buena opción de tratamiento sería añadir mepolizumab.
3. Se trata de un asma no T2 y la mejor opción de tratamiento sería un antileucotrieno.
4. Se trata de un asma no T2 y la mejor opción de tratamiento sería añadir benralizumab.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta novedosa sobre los fenotipos inflamatorios del asma. La presencia de rinosinusitis crónica con poliposis nasal y un recuento de eosinófilos de 400 células/ μ L es indicativo de un asma de fenotipo T2, caracterizado por inflamación eosinofílica (respuesta 3 y 4 incorrectas). Este fenotipo se asocia frecuentemente con la elevación de interleucinas como la IL-5, que es crucial para la supervivencia y activación de los eosinófilos. Los pacientes con asma severa T2, que no han respondido a terapia inhalada plena y/o ciclos de corticoides, pueden beneficiarse de terapias biológicas dirigidas a los mediadores de la inflamación eosinofílica. En este contexto, mepolizumab es un anticuerpo monoclonal que actúa bloqueando la IL-5, lo que conduce a la reducción de la cantidad de eosinófilos y, consecuentemente, a una disminución de la inflamación y las exacerbaciones asmáticas (respuesta 2 correcta). Aunque omalizumab es útil en el asma alérgica (también T2) al dirigirse a la IgE, en este caso

no se indica que el paciente tenga un componente alérgico predominante, sino una inflamación eosinofílica evidente (opción 1 incorrecta).

114. En el estudio de las enfermedades intersticiales difusas del pulmón, señale en qué entidad el lavado broncoalveolar posee valor diagnósticos:

1. Sarcoidosis.
2. Fibrosis pulmonar idiopática.
3. Neumonitis por hipersensibilidad.
4. Proteinosis alveolar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la única EPID en la que el BAL es patognomónico es en la proteinosis alveolar, en la que el BAL tiene un aspecto lechoso y está formado por macrófagos cargados de lípidos y material PAS positivo. Por ello, entre las opciones que se presentan el BAL tiene mayor valor diagnóstico en la proteinosis alveolar. Se podría dudar con la sarcoidosis, en donde un BAL con linfocitosis y un cociente CD4/CD8 aumentado se considera muy sugestivo; sin embargo, no es patognomónico.

115. Hombre de 65 años, exfumador, en el que de forma incidental se identifica un nódulo pulmonar solitario (NPS) en radiografía simple de tórax. Diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un FEV1 del 30%. En el estudio por TC se describe un NPS en lóbulo superior derecho de 9 mm de diámetro con cola pleural y calcificaciones excéntricas. Se realiza tomografía por emisión de positrones con captación patológica indicativa de malignidad. ¿Cuál de las siguientes actitudes terapéuticas es la más adecuada?

1. Es imprescindible la realización de una biopsia por cirugía torácica ante la elevada posibilidad de malignidad.
2. Al tratarse de un NPS de pequeño tamaño, la actitud más adecuada es la de seguimiento radiológico estrecho con TC al mes y a los 3, 6 y 12 meses.
3. Ante la alta probabilidad de malignidad se recomienda realizar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar si el consumo máximo de oxígeno es <10 mL/kg/min remitir a cirugía torácica para resección.
4. Se debe realizar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar si el consumo máximo de oxígeno es <10 mL/kg/min el manejo terapéutico más seguro es por medio de radioterapia estereotáctica fraccionada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que aborda el concepto de operabilidad en cáncer de pulmón. La operabilidad hace referencia a la capacidad

del paciente para soportar la resección quirúrgica del cáncer, lo cual incluye considerar el límite funcional pulmonar mínimo que debemos preservar para evitar abocar al paciente al fracaso respiratorio post-resección. Para evaluar este aspecto, se debe considerar inicialmente la FEV1 posbroncodilatador del paciente. Si es normal ($>80\%$), en principio se considera apto incluso para tolerar una neumonectomía completa. En cambio, si la FEV1 de partida es $<80\%$, debe realizarse una estimación de la FEV1 posquirúrgica prevista (mediante gammagrafía de perfusión cuantificada). Si ésta es $>40\%$, puede asumirse la operabilidad; sin embargo, si es menor, deben considerarse otros parámetros adicionales como la DLCO o el consumo máximo de O_2 . Si éste es <15 mL/kg/min, debe considerarse al paciente inoperable, y por tanto su manejo terapéutico pasa por buscar alternativas a la cirugía resectiva pulmonar. En este caso nos presentan un nódulo de alto riesgo que ya tiene un PET-TC sugestivo de malignidad (por lo que debe manejarse asumiendo que es un cáncer). La opción 1 es falsa, no es imprescindible una biopsia mediante cirugía torácica, pues se podría obtener por otros medios (p. ej.: punción transtorácica guiada por TC). La opción 2 (seguimiento radiológico) no es adecuada con un PET-TC sugestivo de malignidad. Las opciones 3 (falsa) y 4 (verdadera) se responden a la luz de la inoperabilidad que hemos establecido en este paciente dados su baja FEV1 y consumo máximo de O_2 : al ser inoperable procede el tratamiento con radioterapia estereotáctica (combinada o no con QT, de forma análoga a como se hace con los tumores localmente avanzados irresecables).

116. En una mujer de 72 años con litiasis biliar asintomática se indicaría colecistectomía laparoscópica en caso de:

1. Microlitiasis por alto riesgo de pancreatitis aguda.
2. Litiasis biliar de más de 2,5 cm de diámetro.
3. Vesícula con paredes calcificadas en porcelana.
4. Presencia de cálculos de bilirrubina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La vesícula en porcelana es una condición que incrementa el riesgo de cáncer de vesícula biliar, por lo que la colecistectomía está indicada (respuesta 3 correcta). La microlitiasis o los cálculos de bilirrubina, salvo en pacientes sintomáticos o con complicaciones secundarias (colangitis, pancreatitis), no tienen, per se, indicación quirúrgica (1 y 4 falsas). El tamaño de los cálculos, en pacientes asintomáticos, tampoco se considera una indicación sistemática de colecistectomía (respuesta 2 falsa).

117. ¿En cuál de las siguientes técnicas quirúrgicas para la reparación de una hernia inguinal NO se emplea una malla protésica?

1. Shouldice.
2. Lichtenstein.
3. Reparación laparoscópica TEP (totalmente extraperitoneal).

4. Reparación laparoscópica TAPP (transabdominal preperitoneal).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

“Pregunta compleja de especialista que hace referencia a un concepto antiguo. Actualmente no existe ningún motivo para operar un defecto herniario sin malla (sinónimo de prótesis), salvo las hernias umbilicales menores de 1 cm (concepto de especialidad). Las técnicas de reparación de hernias en la región inguinal han evolucionado a lo largo de la historia; inicialmente se operaban sin malla y, posteriormente, tras ver que la tasa de recidiva era inasumible, se pone malla en todas. La reparación herniaria tiene el objetivo de reconstruir la anatomía de la ingle y darle fuerza a la fascia transversalis. La reparación se puede hacer por delante de la fascia transversalis (casi todas las técnicas abiertas) o por detrás. Técnicas de reparación por vía anterior abierta. Sin malla (no usadas en la actualidad): Shouldice, Bassini, McVay. Con malla: Liechtenstein, Rutkow-Robbins. Técnicas de reparación por vía posterior (todas son con malla). Cirugía abierta con malla: Nyhus. Cirugía laparoscópica: TEP, TAPP.”

- 118. Mujer de 42 años que consulta por dolor rectal descrito como una sensación de peso u ocupación continua que se agrava con la defecación. En la exploración física el ano es normal y en el tacto rectal se palpa el músculo puborrectal hipertónico y doloroso a la tracción. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?**

1. Úlcera solitaria de recto.
2. Proctalgia fugaz.
3. Proctalgia inespecífica.
4. Síndrome del elevador del ano.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de especialista de cirugía colorrectal, muy específica y difícil de contestar por conocimiento, pero asumible por lo que preguntan. La clave de esta pregunta no es otra que asociar que el músculo puborrectal es uno de los 3 vientres musculares, junto con el pubococcígeo y el ileococcígeo del músculo elevador del ano (concepto anatómico de asignaturas básicas). La proctalgia inespecífica no es un diagnóstico, y si existiese una úlcera en el recto en el síndrome de úlcera solitaria, se palparía en el tacto rectal. La proctalgia fugax es una condición muy compleja de tratar y muy rara, que cursa con un dolor anal de intensidad 10/10, generalmente de noche, que se autolimita en minutos, que ocurre espaciado en el tiempo y sin un desencadenante claro. Se asocia con estrés/ansiedad, que alteran el sistema nervioso sacro y se manifiestan así. Generalmente necesita tratamiento con terapias conservadoras que reduzcan el estrés, como mindfulness, y si no, en segundo escalón, infiltraciones con bloqueantes nerviosos.

- 119. Un hombre con diagnóstico de melanoma avanzado y en tratamiento con nivolumab (fármaco anti-PD-1) desarrolla elevación de las transaminasas siete veces los valores normales, junto con elevación de la bilirrubina total (2,3 mg/dL). Se han descartado cuadros infecciosos y no ha mejorado tras suspender el fármaco. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

1. Es una hepatitis inmunomediada por nivolumab y es indistinguible de una hepatitis autoinmune.
2. La reintroducción del fármaco una vez resuelta conlleva la reaparición del cuadro en la mayoría de los casos.
3. Los corticoides a dosis de 1 mg/kg de prednisona o equivalente son el tratamiento de elección en esta situación.
4. La aparición de esta entidad es tardía, generalmente meses después de iniciado el tratamiento.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una hepatitis aguda, en la que habiéndose descartado las causas infecciosas y teniendo en cuenta el antecedente de haber tomado un anti-PD1 (nivolumab), debemos sospechar una hepatitis inmunomediada. En las complicaciones inmunomediadas de los inhibidores de checkpoint debe, en primer lugar, suspenderse el fármaco causante. En aquellos casos con afectación orgánica relevante, como en el caso que nos presentan, el tratamiento de elección son los corticoides a dosis de 1 mg/kg/día (opción 3 correcta). En casos más graves o corticodependientes pueden asociarse otros inmunosupresores. Es importante resaltar que la reintroducción de la inmunoterapia deberá hacerse de manera individualizada; en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando los casos no son graves, se puede reintroducir el fármaco sin conllevar la necesidad de reaparición del cuadro. Por último, las complicaciones inmunomediadas pueden ocurrir en cualquier momento desde el inicio del tratamiento; lo más frecuente es que esta toxicidad aparezca tras los primeros días/semanas de haber iniciado el tratamiento, pero existen casos que aparecen meses después de haber iniciado el tratamiento e incluso después de haberlo retirado. La opción 1 es falsa porque, si bien muchas veces es difícil distinguir una hepatitis inmunomediada de una autoinmune, existen características histológicas típicas de la hepatitis autoinmune (inflamación periportal y lobulillas, rosetas hepatocitarias...); además, el infiltrado inflamatorio es diferente en ambas: en la inmunomediada se compone de linfocitos TCD8+ mientras que en la hepatitis autoinmune el infiltrado portal predominante es de linfocitos TCD4+ y linfocitos B.

- 120. Un paciente con enfermedad de Crohn con antecedente de extirpación de un melanoma precisa iniciar un tratamiento avanzado por corticodependencia. ¿Cuál de los siguientes fármacos se debería evitar al estar descrito un aumento del riesgo de dicha neoplasia?**

1. Azatioprina.
2. Infliximab.
3. Vedolizumab.
4. Ustekinumab.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Los anti-TNF α son anticuerpos tipo IgG1, cuyo mecanismo de acción consiste en el bloqueo del TNF, una potente citocina proinflamatoria. Hoy en día siguen siendo los más utilizados en EII. Son infliximab (administración i.v.), adalimumab (administración s.c.) y golimumab (administración s.c.). Todos ellos están indicados tanto en CU como en EC, con la excepción del golimumab, que está aprobado únicamente para la CU. El perfil de seguridad a corto y medio plazo de todos ellos es bueno, y las complicaciones infecciosas son las más frecuentes. Respecto al riesgo de neoplasias, han demostrado seguridad, si bien hay estudios retrospectivos que asocian mayor riesgo de melanoma y de linfoma, sobre todo de linfoma T hepatoesplénico y cuando son combinados con tiopurínicos en jóvenes con serologías negativas para Epstein Barr. Vedolizumab y ustekinumab parecen ser más seguros, mientras que los inhibidores de la tirosin kinasa han demostrado más riesgo de neoplasias en pacientes con artritis reumatoide, por lo que parece que pueden aumentar el riesgo de neoplasias en pacientes con EII. Las tiopurinas se relacionan con tumores de tipo piel no melanoma, linfoma y tumores genitorinarios.

121. Respecto al divertículo faringoesofágico o divertículo de Zenker, es cierto que:

1. Es un divertículo por tracción y consta de todas las capas de la pared esofágica.
2. Es menos frecuente que los divertículos del tercio medio del esófago en la actualidad.
3. No se trata con miotomía del cricofaríngeo si el tamaño es igual o menor a 2 cm.
4. Cuando se interviene mediante abordaje abierto para practicar una diverticulotomía o una diverticulopexia, la incisión se realiza en el lado izquierdo del cuello.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

“En esta pregunta hay dos consideraciones a tener en cuenta. La primera, acerca del divertículo esofágico de Zenker: es el divertículo más frecuente, es un divertículo falso porque solo cuenta con mucosa y submucosa; el mecanismo que subyace al divertículo es un trastorno esofágico motor que aumenta la presión a nivel cervical en el triángulo de Killian (triángulo formado por fibras musculares faríngeas entre el tirofaríngeo y el cricofaríngeo) y protruye la mucosa y submucosa, pero no la muscular. El tratamiento consiste en relajar los músculos de la zona de alrededor cortándolos (miotomía). Si el divertículo es <2 cm la miotomía puede ser quirúrgica abierta o endoscópica, siendo la endoscópica la técnica más usada. Si es >2 cm el tratamiento es quirúrgico y también consistirá en relajar el músculo: miotomía y cortar

el divertículo (diverticulotomía) o desfuncionalizar pegando el divertículo a la pared esofágica (diverticulopexia). La segunda, acerca del tratamiento quirúrgico del esófago cervical. Siempre que se quiera acceder por cirugía al esófago cervical se hace por el lado izquierdo, por varios motivos: en el cuello el esófago se desvía hacia la izquierda, lo que lo hace más accesible; además, la disposición anatómica del nervio laríngeo recurrente izquierdo es paralela al esófago y se localiza mejor que el derecho, que tiene un ascenso más oblicuo y superficial.”

122. Mujer de 67 años con antecedentes de infección por VHC que acude a urgencias por hematemesis. A la exploración observamos ascitis y ligera ictericia. ¿Cuál es la actitud diagnóstica y terapéutica más adecuada?

1. Estabilizar hemodinámicamente, hacer una endoscopia y colocar un TIPS si tiene hemorragia por varices.
2. Realizar una paracentesis, seguido de una endoscopia y ligadura de varices.
3. Estabilizar al paciente, iniciar un fármaco vasoactivo, realizar una endoscopia y practicar una ligadura si hay hemorragia por varices.
4. Esperar al resultado de la endoscopia para actuar en consecuencia.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta sobre el algoritmo de tratamiento en el caso de una hemorragia digestiva alta (HDA) en una paciente cirrótica. La respuesta correcta es la 3, porque lo primero que debemos hacer ante una HDA es estabilizar al paciente (ABCD) posteriormente añadir los fármacos (vasoactivo e IBP), y ya después hacer la endoscopia para realizar una terapéutica (en el caso de que sea una HDA por varices el tratamiento sería ligadura con bandas).

123. Mujer de 38 años que presenta nódulo tiroideo indoloro y creciente en el lóbulo derecho de 6 meses de evolución. Ha experimentado recientemente disfagia y cambios de la voz. Se diagnostica de carcinoma medular de tiroides en estadio III con extensión extratiroidea y compromiso de ganglios linfáticos cervicales. De entre los siguientes, ¿cuál es el tratamiento más adecuado?

1. Tiroidectomía subtotal.
2. Hemitiroidectomía derecha.
3. Tiroidectomía total con extirpación de ganglios linfáticos cervicales.
4. Quimioterapia exclusiva.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta académicamente de dificultad media, que se puede sacar razonando desde los conocimientos básicos de la

patología tiroidea. El manejo de un cáncer medular con estadio III requiere la tiroidectomía total junto con linfadenectomía locorregional. Se opta por cirugías preservadoras de función dado que la cirugía radical, altamente desfigurativa, no mejora el pronóstico salvo en casos muy concretos con enfermedad bien delimitada; la adición de quimioterapia no mejora el pronóstico en estos casos, estando indicada en el estadio IV. Si no sabemos esto, podemos afrontar esta pregunta desde el conocimiento básico: el manejo de neoplasias tiroideas requiere siempre tiroidectomía total (opciones 1 y 2 incorrectas) y exéresis de ganglios si están afectos; la única duda podía ser con la opción 4 si nos planteásemos que el tumor pudiera ser irresecable, pero dado que tiene importante sintomatología locorregional (disfonía y disfagia), quimioterapia exclusiva no sería la solución a esos problemas; haría falta como mínimo una colocación de endoprótesis para la disfagia.

124. Mujer de 58 años que consulta por presentar desde hace varios meses dolor abdominal epigástrico intermitente, náuseas y pérdida de peso involuntaria de 8 kg. Refiere episodios ocasionales de vómitos biliosos, sin haber notado sangre en los vómitos ni en las heces. Ha estado tomando antiácidos sin mucho alivio. En la exploración física se aprecia abdomen blando, con dolor a la palpación profunda en el epigastrio, sin masas palpables ni signos de peritonitis. Los análisis muestran anemia microcítica e hipocrómica y ferropenia. En la gastroscopia lesión ulcerada en la segunda porción del duodeno, que se biopsia. El informe histológico confirma la presencia de adenocarcinoma duodenal. Una TC abdominal muestra la lesión limitada al duodeno, sin evidencia de diseminación a ganglios linfáticos o metástasis a distancia. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de esta paciente?

1. Observación y seguimiento periódico con endoscopia digestiva alta debido a la localización del tumor.
2. Quimioterapia neoadyuvante seguida de una nueva evaluación para posible resección quirúrgica.
3. Duodenopancreatectomía cefálica (procedimiento de Whipple) como tratamiento de elección.
4. Radioterapia dirigida al duodeno para controlar la enfermedad local antes de considerar la cirugía.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Es un enunciado largo para acabar preguntando acerca de algo muy concreto: cuál es el tratamiento de un adenocarcinoma duodenal en estadio localizado (operable) en un paciente joven. La mejor opción, tratándose de una lesión en segunda porción duodenal en una paciente joven sin otras

comorbilidades, es la cirugía con intención curativa, que en este caso, por su localización, sería una duodenopancreatectomía cefálica. La neoadyuvancia con quimio/radioterapia se podría plantear en lesiones inicialmente no resecables.

125. Mujer de 60 años que tras un esfuerzo refiere la aparición de una tumoración en la zona inguino-crural derecha no reductible y muy dolorosa. Acude a urgencias con un cuadro de vómitos, dolor y distensión abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Hernia inguinal directa.
2. Hernia inguinal indirecta.
3. Hernia obturatriz.
4. Hernia crural.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy polémica porque entremezcla los conceptos de frecuencia frente a riesgo. Las hernias más frecuentes en la región inguinocrural son las inguinales respecto a las crurales, que son solo el 3%. Dentro de las inguinales, las más frecuentes son las indirectas; y las más frecuentes son las del lado derecho, porque no tienen el sigma para tapar la región inguinocrural por dentro. Las hernias inguinales son 10 veces más frecuentes en los hombres respecto a mujeres, y las crurales son 4 veces más frecuentes en las mujeres. Esto no quiere decir que en las mujeres las crurales sean las más frecuentes globalmente. Sin duda, las hernias que más riesgo tiene de complicarse son las crurales. En esta pregunta, el Ministerio dio como correcta la opción 4: ante una mujer mayor con hernia complicada en la urgencia, cuidado porque puede ser una crural, que son las que más riesgo tienen de estrangularse; tras el diagnóstico en urgencias, todas van directamente a quirófano. Están haciendo hincapié en esa asociación repetida en MIRes previos, pero mal formulada al preguntar por frecuencia en vez de por riesgo.

126. Hombre de 77 años que acude a urgencias por prurito, ictericia y síndrome tóxico de un mes de evolución. Refiere ingesta de amoxicilina-clavulánico desde hace 10 días por un resfriado. A su llegada se realiza una ecografía que se informa de dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con vesícula biliar distendida. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y la actitud a seguir?

1. Colecistitis aguda e indicación de colecistectomía urgente.
2. Coledocolitiasis distal y solicitud de colangiorresonancia magnética.
3. Toxicidad por fármacos y suspensión de la medicación.
4. Tumoración maligna obstructiva de colédoco distal y solicitar TC abdominal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

“La dilatación de la vía biliar intra y extrahepática siempre obliga a descartar un proceso obstructivo a nivel de la vía biliar distal. En un paciente con ictericia progresiva y síndrome constitucional de curso subagudo o crónico, la primera hipótesis diagnóstica es la neoplasia, más específicamente el adenocarcinoma de cabeza de páncreas o el colangiocarcinoma distal (respuesta 4 correcta). El signo de Courvoisier-Terrier, o vesícula palpable, signo que probablemente encontraríamos en la exploración física de este paciente, constituye otro dato a favor de un origen maligno del proceso obstructivo. La coledocolitiasis distal no suele provocar síndrome tóxico ni ser un proceso subagudo (respuesta 2 incorrecta). La ausencia de semiología infecciosa en un paciente sin dilatación de las paredes vesiculares nos permite descartar la colecistitis aguda (respuesta 1 incorrecta). La hepatitis tóxica por amoxicilina-clavulánico es rara y no suele provocar dilatación de la vía biliar y menos aún de la vesícula (respuesta 3 incorrecta).”

127. La forma más eficaz de evaluación preoperatoria de la función del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior en un paciente con sospecha de reflujo gastroesofágico es:

1. La monitorización ambulatoria del pH y la impedancia.
2. Manometría esofágica.
3. Esofago-duodenoscopia.
4. Esofagograma con bario.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La prueba que mide de forma dinámica la función esofágica a lo largo de su longitud es la manometría esofágica de alta resolución, una sonda nasogástrica con diferentes sensores de presión que monitorizan en tiempo real la persistencia esofágica, así como la contracción y relajación del esfínter esofágico superior e inferior. Es una prueba muy conveniente a realizar antes de una cirugía antirreflujo para descartar trastornos motores esofágicos subyacentes que pongan en riesgo el éxito de la cirugía.

128. Mujer de 34 años con diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) refractaria al tratamiento médico remitida para evaluación quirúrgica. A pesar del tratamiento con corticosteroides y otros inmunosupresores, sus recuentos plaquetarios han permanecido bajos, con episodios recurrentes de sangrado leve. Se decide realizar una esplenectomía laparoscópica como siguiente paso terapéutico. En relación con la planificación y manejo de la esplenectomía laparoscópica, ¿cuál de las siguientes estrategias es la más adecuada?

1. La ligadura temprana de la arteria esplénica es crucial para reducir el riesgo de sangrado intraoperatorio y debe realizarse antes de movilizar el bazo en todos los casos.

2. La preservación del polo inferior del bazo es recomendable en pacientes con PTI para mantener una función inmunológica parcial.
3. El abordaje lateral izquierdo es la única opción en esplenectomías laparoscópicas y debe emplearse independientemente del tamaño del bazo.
4. La vacunación preoperatoria contra neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae es esencial para reducir el riesgo de infección post-esplenectomía y debe completarse al menos dos semanas antes de la cirugía, siempre que sea posible.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recordad que los pacientes esplenectomizados deben ser vacunados frente a gérmenes encapsulados, preferiblemente antes de la intervención quirúrgica. Esta es una de esas preguntas que se contestan más por técnica de examen que por conocimientos teóricos; si os fijáis, parece orientada a preguntar por el procedimiento quirúrgico de la esplenectomía, pero dos de las opciones sobre la técnica pueden descartarse al ser demasiado categóricas. Recordad también que la esplenectomía en este contexto debe ser total, ya que si queda algo de tejido esplénico residual este seguirá destruyendo plaquetas.

129. ¿Cuál de las siguientes medidas aconsejadas para reducir la infección de la herida quirúrgica es INCORRECTA?

1. En caso de ser necesario eliminar el vello, está indicado rasurarlo con cortadora eléctrica o con cuchilla.
2. Es recomendable mantener la temperatura corporal del paciente $>35.5^{\circ}\text{C}$.
3. Es recomendable mantener la glucemia en cifras $<180\text{ mg/dL}$.
4. El intervalo de inicio de la infusión del antibiótico hasta la realización de la incisión debe ser menor de 60 minutos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta asequible de un concepto muy candente en los últimos 5 años sobre la prevención de la infección de sitio quirúrgico. Es uno de los 6 bundles que tenemos que recordar. Recordad que el vello es mejor no retirarlo, pero si hay que cortarlo nunca se debe hacer con cuchilla por las microlesiones en la piel, que aumentan el riesgo de infección quirúrgica.

130. En un paciente diagnosticado de fracaso renal agudo, el tratamiento con hemodiálisis está indicado en todas las siguientes situaciones clínicas, EXCEPTO en una:

1. Acidosis metabólica que no responde a tratamiento con bicarbonato.

2. Sobrecarga de volumen con edema agudo de pulmón.
3. Hiperpotasemia refractaria a tratamiento médico.
4. Proteinuria de 1 gramo en la orina de 24 horas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre indicaciones de diálisis aguda. Recuerda que hay 2 grandes grupos de indicaciones: la clínica urémica grave (encefalopatía urémica, pericarditis urémica, colitis urémica, etc.) y las “hipercosas graves” refractarias a manejo conservador (acidosis metabólica refractaria a bicarbonato, hiperpotasemia grave refractaria a tratamiento, hipervolemia grave sin respuesta diurética, hipercalcemia grave refractaria a tratamiento farmacológico). La proteinuria no es una indicación de diálisis (opción 4 falsa, por tanto CORRECTA).

131. Mujer de 54 años diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 hace tres años, en tratamiento con metformina y lisinopril con buen control metabólico. Es enviada a consulta de Nefrología por creatinina sérica de 1.7 mg/dL, filtrado glomerular estimado de 49 mL/min/1.73 m² y cociente albumina/creatinina en orina de 250 mg/g. En los siguientes meses se confirma estabilidad de la función renal, las cifras de presión arterial se mantienen alrededor de 125/70 mmHg, en la ecografía se observan riñones de tamaño y morfología normal, y en el estudio de fondo de ojo se objetiva una retinopatía diabética grado 2. ¿Cuál de las siguientes es la actitud a seguir?

1. No hacer modificaciones en el tratamiento dada la estabilidad y buen control de su enfermedad.
2. Añadir un antagonista del receptor de la angiotensina II para lograr un mejor control de la presión arterial y disminuir la albuminuria.
3. Indicar la realización de una biopsia renal para confirmar la existencia de una enfermedad renal diabética.
4. Iniciar tratamiento con un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 que promueve la excreción urinaria de glucosa y tiene un efecto nefroprotector.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Concepto importante y recurrente desde hace algunos años. Paciente con nefropatía diabética en estadio de nefropatía clínica (FGe <60 ml/min), que ya está tratada con IECA (lisinopril), que presenta además albuminuria moderada (casi de alto grado, cociente Alb/Cr de 250) y retinopatía diabética. Esta paciente se beneficia de inicio de iSGLT-2 por sus demostrados beneficios pronósticos a nivel renal (enlentecimiento de progresión de nefropatía en diabéticos y no diabéticos), independientemente del control metabólico (respuesta 4 CORRECTA).

132. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) se caracteriza por:

1. Hiponatremia con osmolalidad sérica baja y osmolalidad urinaria elevada.
2. Hiponatremia hipovolémica con concentración urinaria de sodio y osmolalidad en orina elevadas.
3. Su tratamiento se basa en la restricción hídrica y la administración de fármacos agonistas del receptor de vasopresina.
4. En la mayoría de los casos se asocia con la administración de fármacos, especialmente antibióticos inmunosupresores.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil sobre el SIADH, una patología muy habitual en el MIR. Para empezar, la pregunta comienza con “se caracteriza” y eso históricamente suele hacer referencia a criterios diagnósticos. La presentación habitual (y parte sine qua non de los criterios diagnósticos) del SIADH es con hiponatremia hipoosmolar con VEC normal (opción 2 incorrecta), con sodio y osmolaridad urinaria inadecuadamente altos (opción 1 correcta). La causa más frecuente, y primera a descartar, es el carcinoma microcítico pulmonar, pudiendo deberse también a otras patologías intratorácicas o intracraneales, o a fármacos, siendo especialmente típicos los antidepresivos y antipsicóticos (opción 4 incorrecta). El tratamiento se basa en la restricción hídrica, la ingesta de sal, y el uso de diuréticos, siendo de elección indistintamente la urea o la furosemida (opción 3 incorrecta).

133. Hombre de 37 años que se deriva a consulta de Nefrología para estudio de hematuria microscópica persistente. La exploración es normal salvo por presión arterial 160/100 mmHg. Hemograma sin alteraciones, urea 25 mg/dL, creatinina 0.8 mg/dL, Na 139 mEq/L, K 4.5 mEq/L, perfil hepático y lipídico normales, no hipoalbuminemia ni hipoproteinemia; estudio de autoinmunidad normal, complemento, inmunoglobulinas y proteinograma normales; serología vírica negativa; proteinuria de 0.75 g/24h; sedimento urinario con 30 eritrocitos por campo, 90% dismórficos, no leucocituria. Se realiza biopsia renal que muestra depósitos mesangiales de IgA, IgG y C3 con hiper celularidad mesangial (M1) y glomeruloesclerosis segmentaria (S1) pero sin proliferación endocapilar (E0) ni fibrosis túbulo-intersticial (T0) ni presencia de semilunas. En este momento, ¿cuál de entre los siguientes es el tratamiento más recomendado?

1. Monoterapia con corticoides a 0.5 mg/kg/día con pauta descendente en 3 meses.
2. Control de la presión arterial y la proteinuria

(añadir un antagonista de los receptores de angiotensina II).

3. Rituximab como primera opción y, si no hay respuesta, administrar ciclofosfamida.
4. Corticoides a altas dosis junto con ciclofosfamida como tratamiento de inducción.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un paciente con síndrome nefrítico (HTA, hematuria y proteinuria) con complemento normal, cuya biopsia corresponde a una GN mesangial IgA (depósitos mesangiales de IgA, entre otros, con proliferación mesangial). Recuerda que muchos casos de GN mesangial IgA no precisan terapia, si bien es importante la vigilancia de la aparición de HTA y un tratamiento apropiado de la misma, ya que es un factor predictor y predecesor del desarrollo de un síndrome nefrítico con insuficiencia renal posterior (respuesta 2 CORRECTA). El tratamiento esteroideo e inmunosupresor se reserva para casos con presentación agresiva o progresión a pesar de la citada terapia, que condicione deterioro del filtrado glomerular, habiéndose utilizado diferentes pautas (esteroides, rituximab y ciclofosfamida) con variables tasas de éxito. Como novedad, no necesaria para acertar la pregunta, nos hablan de la escala histológica "MEST", que hace referencia a la ausencia (0 puntos) o presencia (1 punto) de proliferación mesangial (M), endocapilar (E), glomerulosclerosis segmentaria (S) y tubulointersticial (T). Dicha escala ayuda a matizar la necesidad de inicio de inmunosupresores (intensa proliferación endocapilar, semi-lunas) o no (recuerda que la esclerosis glomerular y tubulointersticial orientan a daño crónico en cualquier patología renal, con pocas expectativas de mejoría bajo terapia).

134. Hombre de 65 años que presenta un episodio de infección respiratoria y es tratado con amoxicilina/clavulínico. Una semana después comienza con fiebre y aparición de rash cutáneo por lo que acude a Urgencias. En la analítica se objetiva deterioro de función renal con creatinina sérica 3.2 mg/dL (previa 1.2 mg/dL), eosinofilia y presencia de proteinuria y microhematuria en el sistemático de orina. Indique cuál de estas actitudes es la más correcta:

1. Es necesario realizar una biopsia cutánea para establecer el diagnóstico.
2. Hay que aumentar la dosis de antibiótico pues probablemente se trate de una nefropatía tubulointersticial aguda de etiología infecciosa.
3. Se debe suspender el antibiótico y plantear tratamiento con esteroides si la función renal no mejora en 2-3 días.
4. Hay que iniciar tratamiento con bolus de esteroides a dosis altas y realizar una biopsia renal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nuevamente nos preguntan en el MIR un caso con clíni-

ca típica de una nefritis intersticial inmunoalérgica (NIIA): daño renal agudo de origen tubular (proteinuria tubular, típicamente leucocituria, ocasionalmente microhematuria sin cilindros) junto con sintomatología alérgica (fiebre, rash, eosinofilia) tras el inicio de fármacos (siendo los antibióticos unos de los más habituales). A nivel terapéutico, la medida más importante es la suspensión del fármaco, reservando la terapia con esteroides en casos de ausencia de mejoría clínica (respuesta 3 CORRECTA). En casos de claro diagnóstico como el que nos presentan, la biopsia renal no es necesaria, ya que se asume el diagnóstico clínico, estando reservada en aquellos escenarios en los que existan dudas diagnósticas (sedimento poco/nada expresivo, ausencia de eosinofilia/eosinofilia, etc.).

135. Hombre de 72 años, remitido a consulta tras un hallazgo en una TC solicitada para el estudio de molestias digestivas inespecíficas. Se objetiva una lesión sólida, exofítica, heterogénea, con realce intenso tras la administración de contraste, de 4.9 cm de diámetro, dependiente del polo inferior renal derecho; en el riñón izquierdo litiasis pélvica de 3 cm que condiciona hidronefrosis y atrofia cortical. Antecedentes personales de hipertensión, sobrepeso (mide 1.6 m y pesa 95 kg) y fumador habitual. En la analítica destaca creatinina sérica de 1.5 mg/dL. Señale de entre las siguientes opciones de tratamiento la que considera más adecuada:

1. Nefrectomía bilateral, con suprarrenalectomía derecha y linfadenectomía retroperitoneal.
2. Nefrectomía parcial derecha.
3. Biopsia percutánea. Quimioterapia neoadyuvante y nefrectomía radical derecha.
4. Nefrectomía radical derecha. Inmunoterapia adyuvante.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En este caso se presenta un paciente remitido a Urología ante el hallazgo incidental en un TC de una lesión renal sospechosa sin datos de extensión a distancia. Dado que el tumor es exofítico y mide 4,5 cm, podría plantearse una nefrectomía parcial derecha como tratamiento de elección.

136. Hombre de 53 años acude a urgencias por anuria de 48 horas de evolución. Presenta dolor abdominal difuso de varios días de evolución que no se modifica con la posición ni con la ingesta. No ha presentado fiebre, pero sí náuseas con dos vómitos escasos biliosos sin productos patológicos, además de estreñimiento. En la analítica sanguínea presenta ligera leucocitosis con desviación izquierda, creatinina 7 mg/dL con FG < 15 mL/min, sodio 132 mmol/L y potasio 5.7 mmol/L, bilirrubina 1 mg/dL, amilasa 100 U/L, AST 30 U/L, ALT 45 U/L, fosfatasa alcalina 60 U/L, y GGT 70 U/L. En el sedimento de orina únicamente se evidencian 5-10 hematíes/campo y

leve piuria. En la ecografía abdominal dilatación pielocalicial y ureteral moderada-severa bilateral con leve disminución del parénquima en el riñón izquierdo y múltiples imágenes hiperecoicas con sombra acústica posterior en todos los grupos caliciales, así como en el uréter proximal izquierdo. ¿Cuál es la actitud más correcta a seguir?

1. Analgesia IV y sueroterapia intensiva para forzar diuresis.
2. Diuréticos intravenosos.
3. Derivación de la vía urinaria de forma bilateral.
4. Solicitar TC ante la sospecha de abdomen agudo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se describe un cuadro clínico de dolor abdominal, náuseas, vómitos..., todos ellos síntomas compatibles con cólico reonoureteral. Además, presenta fracaso renal agudo con creatinina de 7. Confirmamos el diagnóstico de cólico reonoureteral complicado con los hallazgos ecográficos: dilatación pieloureteral y ureteral bilateral secundaria a la presencia de litiasis. Por este motivo, el paciente requiere derivación urinaria urgente.

137. Hombre de 28 años que consulta por haberse despertado por dolor en la región genital y tumefacción en el pene. No recuerda con detalle lo sucedido en las últimas 12 horas. En las últimas 48 h ha consumido alto volumen de alcohol, varias drogas (mefedrona, cocaína, anfetamina), junto con sildenafil y se ha autoinyectado en el pene 20 µg de alprostadil. A la exploración destaca, pene flácido, glande no visible en su totalidad por edema y hematoma expansivo de partes blandas. Presenta restos hemáticos en el meato uretral. ¿Cuál de las siguientes opciones NO formaría parte de su plan terapéutico?

1. Gasometría obtenida mediante punción del cuerpo cavernoso.
2. Revisión quirúrgica urgente.
3. Evitar el sondaje vesical.
4. Ecografía de pene.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos describen a un paciente valorado en urgencias con tumefacción y edema peneano en un contexto de consumo de alcohol y fármacos para obtener y mantener la erección. Esto nos indica que podría tratarse de una fractura de pene. Para su diagnóstico es imprescindible la revisión quirúrgica lo antes posible. La ecografía nos puede aportar información sobre la localización de la fractura a nivel de cuerpos cavernosos y/o esponjoso. En caso de afectación de este último se prefiere no proceder al sondaje uretral. La gasometría es útil en el diagnóstico y manejo del priapismo, pero no en la fractura de pene.

138. Hombre de 51 años que consulta preocupado por la aparición de leve goteo postmiccional. Tiene dislipemia, hipertensión arterial y alopecia androgénica incipiente. Sigue tratamiento con simvastatina, enalapril, minoxidil y dutasterida. Padre y hermano fallecidos por cáncer de próstata. En los reconocimientos de salud laboral realizados en 2021 y 2023 se observa PSA de 0.3 y de 3.8 ng/mL respectivamente (valores de referencia <4 ng/mL). Una RMN prostática multiparamétrica muestra una próstata de 55 mL y en secuencia T2 un nódulo hipointenso moderado y homogéneo de 1.7 cm, con restricción de la difusión y realce precoz en perfusión en el límite entre el estroma fibromuscular anterior y la zona transicional del lóbulo izquierdo prostático. Repetimos una nueva determinación de PSA 3.5 ng/mL. A la vista de estos hallazgos, ¿qué recomendación propondría al paciente como la más adecuada?

1. Biopsia prostática transrectal sistemática.
2. Iniciar un tratamiento antibiótico empírico durante 10 días y realizar una biopsia prostática sistemática al finalizar.
3. Tranquilizar al paciente, ofrecer tratamiento sintomático alfa-bloqueante y seguimiento.
4. Biopsia prostática transperineal sistemática y dirigida mediante fusión de imágenes RMN.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En este caso nos plantean a un varón con importantes antecedentes de cáncer de próstata en su familia (padre y hermano). Además, ha presentado un notable ascenso del PSA en 2 años. Se realiza RM prostática observando lesión sospechosa, pues presenta restricción de la difusión y realce precoz. Este paciente sería el perfecto candidato para realizar biopsia prostática perineal de fusión.

139. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre los subtipos moleculares de cáncer de mama?

1. El cáncer de mama triple negativo es el subtipo más frecuente.
2. El cáncer de mama HER2+ es el subtipo menos agresivo.
3. El cáncer de mama luminal A es el subtipo más raro.
4. El cáncer de mama triple negativo es el subtipo más agresivo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica acerca de la clasificación inmunohistoquímica en el cáncer de mama: es esencial conocer la clasificación inmunohistoquímica del cáncer de mama con implicaciones pronósticas y terapéuticas clave. De las opciones planteadas, la afirmación correcta es la número 4: "El cáncer de mama triple negativo es el subtipo más agresivo". Este

subtipo, caracterizado por la ausencia de expresión de receptores hormonales (estrógeno y progesterona) y HER2, suele asociarse con una mayor proliferación celular, peor pronóstico y ausencia de terapias dirigidas específicas, lo que lo convierte en el más agresivo. Por otro lado debemos saber que el subtipo más frecuente es el luminal A, con un mejor pronóstico debido a su sensibilidad hormonal.

140. Mujer de 60 años con diagnóstico reciente de cáncer de mama metastásico con alta carga tumoral. Acude a Urgencias 48 horas después de haber recibido el primer ciclo de tratamiento, con cuadro de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, astenia intensa y letargia. En la analítica sanguínea presenta alteración de la función renal. ¿Cuál de las siguientes alteraciones analíticas esperaría encontrar también?

1. Hipouricemia.
2. Hiperpotasemia.
3. Hipofosfatemia.
4. Hipercalcemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta repetida, una vez más, en el MIR. Nos presentan un caso de síndrome de lisis tumoral tras inicio de quimioterapia en paciente con alta carga tumoral. Recuerda que la clínica se produce por la liberación de sustancias intracelulares, con aparición de hiperpotasemia (respuesta 2 CORRECTA), hiperfosforemia (catión eminentemente intracelular), hipocalcemia (por consumo por la hiperfosforemia) e hiperuricemia (por metabolización de las purinas procedentes del ADN de las células lisadas). La llegada masiva de ácido úrico a nivel renal produce obstrucción y daño tubular, con aparición de FRA parenquimatoso. El tratamiento de prevención se basa en hidratación previa y empleo de alopurinol, reservando en el empleo de rasburicasa para los casos graves o refractarios a las citadas medidas.

141. ¿A cuál de las siguientes proteínas presentes en la superficie celular se une el fármaco pembrolizumab?

1. PD-1.
2. PD-L1.
3. CTLA-4.
4. HER2.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta teórica. Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal anti-PD1, al igual que nivolumab. Atezolizumab, en cambio, es un anticuerpo anti-PDL1.

142. ¿Cuál de estos pacientes en tratamiento con quimioterapia cumple criterios de neutropenia febril?

1. Mujer de 38 años intervenida de cáncer de mama en curso de quimioterapia adyuvante que acude a urgencias por temperatura de 38.5 °C, odinofagia, rinorrea y buen estado general. Neutrófilos 400/mm³.
2. Mujer de 68 años intervenida de cáncer de colon estadio IV en curso de quimioterapia de primera línea que acude a urgencias por temperatura de 37.8 °C, diarrea y mucositis grado 2. Hemodinámicamente estable. Neutrófilos 300/mm³.
3. Hombre de 50 años intervenido de adenocarcinoma gástrico en curso de quimioterapia adyuvante que acude a urgencias por escalofríos y temperatura de 37.5 °C sin otra sintomatología acompañante. Neutrófilos 600/mm³.
4. Hombre de 65 años afecto de adenocarcinoma gástrico metastásico en curso de quimioterapia de segunda línea con ECOG 1 que acude a urgencias por temperatura de 38.6 °C y diarrea grado 1. Neutrófilos 700/mm³.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La neutropenia febril se define como una única toma de temperatura oral >38,3 °C o una temperatura >38 °C durante 1 hora, en un paciente con neutropenia. Se considera neutropenia un número absoluto de neutrófilos por debajo de 500/mm³ (ó <1000/mm³ que se espera que disminuya a <500/mm³ en las siguientes 48 horas). Por lo tanto, la única paciente que cumple esta definición es la opción 1.

143. En un paciente con cáncer colorrectal metastásico irresecable RAS nativo y con pérdida de expresión de proteínas reparadoras del ADN (MSI-H). ¿Cuál debe ser el tratamiento de elección de primera línea?

1. Quimioterapia + Anti-EGFR.
2. Inmunoterapia.
3. Quimioterapia.
4. Quimioterapia + Anti-VEGFR.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta novedosa pero esperadísima. El CCR con inestabilidad de microsatélites, cuando es metastásico, es subsidiario de tratamiento con anti PD1 (pembrolizumab o nivolumab) en monoterapia. Estos tumores codifican proteínas aberrantes altamente inmunogénicas, que son reconocidas por los linfocitos T CD8+ y provocan una intensa respuesta contra el tumor. Esto, que es lo que hace que tengan un buen pronóstico cuando no son metastásicos, los convierte en excelentes dianas para los inhibidores de checkpoint.

144. Hombre de 48 años, exfumador hasta el 2020, con antecedente de nefrectomía parcial izquierda en el 2020 por carcinoma de células renales, tipo

célula clara, grado 2/4, pT1b, que acude por autopalparse una adenopatía laterocervical alta hace 4 meses. En la ecografía de cuello se identifican 2 lesiones nodulares submaxilares y en el TC de cuello se informa de una lesión nodular de partes blandas derecha que corresponde probablemente a una adenopatía sospechosa. Se indica biopsia de la lesión donde se observa una proliferación neoplásica constituida por células con marcada atipia citológica que se disponen con un patrón de crecimiento difuso. El estudio inmunohistoquímico es positivo para CD20, y negativo para CD3, CD30, CD15 y CKAE1-AE3. En estos casos se completa el estudio con CD10, Bcl6 y MUM1 para indicar el fenotipo de la neoplasia. ¿Cuál es el diagnóstico anatómico-patológico?

1. Linfoma Hodgkin variante clásica.
2. Linfoma B difuso de célula grande.
3. Linfoma T periférico.
4. Metástasis de carcinoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta larga y que en principio parece complicada, pero quizás lo más complejo sea leerla hasta el final y extraer la información verdaderamente útil (CD20+). Nos hablan de una infiltración “difusa” por células CD20+, por tanto, un linfoma B. De todas las opciones que ofrecen, solo expresa CD20 el linfoma B de células grandes. El linfoma de Hodgkin también está formado por linfocitos B, pero estos expresan marcadores de línea T (CD15 y CD30).

145. Hombre de 17 años con hemofilia A grave e inhibidor de alto título frente al FVIII que presenta sangrado agudo a nivel articular. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más indicado para controlar la hemorragia?

1. Desmopresina.
2. Emicizumab.
3. Ácido tranexámico.
4. Factor VII activado recombinante.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para el tratamiento de un sangrado activo de un hemofílico con inhibidor no podemos utilizar concentrados de FVIII ya que serán neutralizados por el propio inhibidor. En este contexto debemos usar un agente bypass, como el FVII recombinante activado o el concentrado de complejo protrombínico activado. Emicizumab es una novedad que esperábamos en el MIR y que tiene aprobación en pacientes con hemofilia A grave (con y sin inhibidor), pero como profilaxis de los sangrados, NO como tratamiento.

146. Hombre de 76 años que es intervenido por recambio protésico de cadera derecha tras traumatismo. Entre los antecedentes personales

destaca hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y recambio protésico de rodilla izquierda hace 3 meses por artrosis evolucionada. Al cuarto día del postoperatorio se detecta trombopenia de 52.000/mm³ con cifras de hemoglobina y leucocitos normales. El estudio de coagulación y la bioquímica es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Purpura trombótica trombocitopénica.
2. Coagulación intravascular diseminada.
3. Trombopenia inducida por heparina.
4. Síndrome hemolítico urémico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La dificultad de esta pregunta radica en deducir que, dado que el paciente ha sido intervenido de una cirugía traumática que supone inmovilización, habrá recibido anticoagulación profiláctica, probablemente con HBPM. En este contexto, lo más probable es que se trate de una trombopenia inducida por heparina. El resto de opciones no son compatibles con el caso clínico, que se trata de una trombopenia aislada.

147. Los siguientes tipos de linfoma pueden ser originados por virus. ¿Cuál de ellos es producido por el virus herpes humano tipo 8 (KSHV/HHV8)?

1. Leucemia-linfoma T del adulto.
2. Linfoma primario de cavidades.
3. Linfoma de Burkitt.
4. Granulomatosis linfomatoide.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta puramente memorística pero fácil. El único de los tumores relacionados con el virus herpes humano 8 que está entre las opciones es el linfoma de cavidades. El otro tumor relacionado con este virus y que ha sido múltiples veces preguntado es el sarcoma de Kaposi. Con respecto al resto de las opciones: la leucemia-linfoma T del adulto se relaciona con el HTLV, y el linfoma de Burkitt con el VEB.

148. Mujer de 50 años diagnosticada de síndrome mielodisplásico con monosomía del cromosoma 7 (45 XX -7) es sometida a un trasplante hematopoyético alogénico con sangre de cordón umbilical de un hombre compatible procedente de un banco de otro país. A los tres meses del trasplante con recuperación completa de las cifras hematológicas periféricas se realiza una punción de médula ósea, que no presenta alteraciones morfológicas y un estudio cromosómico con un cariotipo 47 XXY. ¿Cuál es la explicación de estos hallazgos?

1. El donante tiene un síndrome de Klinefelter no diagnosticado.

2. En la médula ósea coexisten células del donante y del receptor (quimerismo mixto).
3. Tras el trasplante ha existido un fenómeno de fusión celular entre las células del donante y receptor que ha originado el nuevo cariotipo.
4. En el cariotipo realizado precozmente tras un trasplante hematopoyético es habitual encontrar alteraciones cromosómicas transitorias de este tipo que carecen de significación clínica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El procedimiento del trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) supone la sustitución completa de la hematopoyesis del receptor por la de un donante. Esto implica que si el donante posee alguna alteración cromosómica en sus células hematopoyéticas, esta será transmitida al receptor. Como a los donantes de médula ósea no se les hace cariotipo de forma reglada, aquellas alteraciones genéticas silentes pueden pasar desapercibidas hasta después del trasplante.

149. Mujer de 90 años sin alergias medicamentosas conocidas, con hipertensión arterial y gonalgia nocturna por gonartrosis derecha de intensidad leve-moderada de tres meses de evolución. Refiere que no toma ninguna medicación y se confirma que realiza las medidas higiénicas del sueño correctamente. Consulta a su médico de atención primaria por insomnio de conciliación y mantenimiento que le interfiere con sus actividades diarias. ¿Qué fármaco es más adecuado iniciar en este caso?

1. Paracetamol.
2. Diazepam.
3. Mirtazapina.
4. Trazodona.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla, siempre y cuando nos demos cuenta de la trampa. Nos exponen una anciana de 90 años con gonalgia NOCTURNA que consulta por INSOMNIO de conciliación y de mantenimiento. En este punto es donde entra la trampa: ¿qué quieren que tratemos exactamente, el dolor de rodillas o el insomnio? Nos indican que la paciente no duerme bien porque durante la noche le duelen las rodillas. Nos insisten además en que la paciente realiza adecuadamente todas las medidas higiénicas del sueño. La conclusión a la que quieren que lleguemos es que esta anciana no duerme bien porque tiene gonalgia, y por lo tanto lo que tenemos que tratar es el dolor. Un error muy habitual en el manejo de las personas mayores es la polimedicación: sería muy sencillo pautar a la paciente cualquier fármaco para dormir, con los efectos adversos que ello conlleva en el anciano (somnia diurna, empeoramiento de la cognición...). Lo correcto es pautar analgesia (la paciente no tomaba ningún fármaco) para tratar de forma dirigida el síntoma (dolor) que impide a nuestra paciente dormir.

150. En los pacientes mayores con síndrome de inmovilidad, una de las siguientes manifestaciones clínicas o consecuencias NO es atribuible al mismo:

1. Déficit intelectual.
2. Aumento de la frecuencia cardíaca.
3. Reducción de la sensibilidad a la insulina.
4. Balance nitrogenado positivo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada no por el contenido, sino porque hay dos respuestas falsas. Podemos empezar descartando las opciones 2 y 3 ya que ambas son verdaderas: la opción 2 es verdadera ya que en el síndrome de la inmovilidad sí que aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando estamos sin movernos mucho tiempo, nuestro corazón se acostumbra a bombear a una frecuencia basal para cubrir las necesidades del organismo (que son pocas ya que no nos movemos). No obstante, a cualquier mínimo esfuerzo que hagamos (como, por ejemplo, cambiar de postura en la cama) el corazón responde con una taquicardia inadecuada ya que no está acostumbrado a tener que bombear para un “cuerpo que se mueve” (en cualquier persona que no sea inmóvil, no se produce taquicardia solo por un cambio postural). La opción 3 también es verdadera ya que la ausencia de movimiento hace que los tejidos necesiten menos glucosa para funcionar (y, por lo tanto, menos insulina); además, la inmovilización suele favorecer el aumento de peso y la obesidad, lo cual lleva a una disminución de la sensibilidad periférica a la insulina (cuando esto alcanza niveles patológicos, ya hablaríamos de diabetes mellitus tipo 2). El problema viene con las respuestas 1 y 4, ya que ambas son falsas. La opción 1 es claramente falsa ya que no hay que confundir nunca el déficit intelectual con el deterioro cognitivo. Un déficit intelectual se define como una discapacidad que conlleva limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, y que se origina antes de los 18 años. El deterioro cognitivo, en cambio, se define como un síndrome clínico en el que existe una alteración parcial o total en uno o más dominios superiores de la cognición (memoria, atención, función ejecutiva, capacidad visoespacial y lenguaje) con respecto a lo esperado en una persona del mismo grupo etario y nivel educativo. Por lo tanto, no tiene nada que ver el “déficit intelectual” con el “deterioro cognitivo”. La inmovilidad sí que favorece el desarrollo del deterioro cognitivo, pero nunca nada relacionado con el déficit intelectual. La opción 4 también es falsa ya que en el anciano hay un balance nitrogenado negativo: en los ancianos tiende a haber mayor catabolismo que anabolismo y, por consiguiente, nos encontramos un balance nitrogenado negativo. Como vemos, tanto la respuesta 1 como la 4 son totalmente falsas. Inicialmente el ministerio dio como respuesta correcta la opción 1, pero después cambió y dio como correcta la opción 4.

151. Hombre de 85 años diagnosticado de enfermedad de Alzheimer en tratamiento con donepezilo.

Desde hace una semana y coincidiendo con una infección urinaria por germen sensible a amoxicilina/clavulánico, presenta un trastorno grave de conducta; por todo ello, recibe tratamiento con dicho antibiótico y con risperidona 1 mg cada 12 horas. Hoy la familia lo trae a su consulta porque a pesar de mejorar la infección de orina, está muy enlentecido, necesitando ayuda para comer y vestirse, no es capaz de deambular sin ayuda, duerme de día y presenta insomnio de madrugada. Ante esta situación clínica, señale la respuesta correcta:

1. Probablemente se trata de un efecto secundario de la risperidona, por lo que se debe retirar.
2. Se debe tratar el insomnio de madrugada añadiendo benzodiacepinas.
3. Hay que esperar a que se resuelva totalmente la infección urinaria para cambiar la medicación actual.
4. Ha empeorado la demencia y se debe añadir memantina al tratamiento de base con donepezilo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta trampa acerca del delirium. Caso clínico en el que tenemos que establecer el diagnóstico diferencial entre efectos extrapiramidales de impregnación por risperidona y sintomatología de un síndrome confusional hipoagudo, cuyo tratamiento será el de la causa y como tratamiento sintomático un antipsicótico que podría ser la risperidona.

152. Los criterios STOPP/START tienen el objetivo de optimizar la medicación y minimizar las reacciones adversas a los medicamentos durante la revisión de la medicación en adultos mayores. En cuanto a los criterios START (versión 3, última versión), ¿cuál deberíamos valorar indicar?

1. Estrógenos tópicos vaginales en la vaginitis atrofica sintomática.
2. Vacuna antitetánica ante una herida abierta.
3. Parche de lidocaína tópica para el dolor articular generalizado.
4. Corticoesteroides inhalados en el EPOC estadio GOLD 1-2.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil de un tema muy específico y no preguntado desde hace tiempo en el MIR. Nos preguntan directamente sobre criterios STOPP/START más recientes. La respuesta correcta es la 1. Se recomiendan los estrógenos tópicos vaginales para tratamiento de la vaginitis atrofica sintomática, que es un proceso causado por la disminución de los niveles de estrógenos característico de la postmenopausia. Cursa con adelgazamiento y sequedad de las paredes vaginales

produciendo descenso de la lubricación, prurito, irritación... Las vacunas recomendadas en estos criterios START son únicamente la gripe estacional, el COVID, la antineumocócica y el herpes zóster. La lidocaína tópica solo se indica en dolor neuropático localizado, como la neuralgia post-herpética. Los corticoides inhalados solo se recomiendan en asma moderado-severo o EPOC Gold 3 y 4 con FEV1 <50% y exacerbaciones frecuentes que precisen corticoides sistémicos.

153. En la actualidad se definen varios estadios o etapas de la diabetes tipo 1 autoinmune. Señale cuál es la definición correcta:

1. El estadio o etapa 3 se caracteriza por la autoinmunidad y tolerancia alterada de la glucosa (ya sea basal o tras test de sobrecarga con glucosa oral).
2. El estadio o etapa 1 se caracteriza por presencia clínica de autoinmunidad contra las células de los islotes sin aparición de alteraciones de la glucosa.
3. El estadio o etapa 2 se caracteriza por hiperglucemia con cifras que definen diabetes.
4. La luna de miel aparece en el estadio 2, con la hiperglucemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un concepto novedoso en el MIR. Clásicamente se ha diagnosticado la diabetes tipo 1 en el momento del debut clínico con hiperglucemia, pero actualmente se definen tres (a veces cuatro) fases evolutivas. La fase o estadio 1 consiste en la autoinmunidad contra los islotes, sin alteraciones en la síntesis de insulina ni por tanto alteraciones glucémicas asociadas. En la fase 2 hay alteración glucémica leve, con alteración de la glucemia en ayunas o intolerancia hidrocarbonada, reflejando una pérdida de capacidad de síntesis insulínica. En la fase 3 aparece la hiperglucemia manifiesta, cumpliendo criterios de diabetes, siendo posible una "fase de luna de miel" durante las primeras semanas, y siendo posible la desaparición de los marcadores autoinmunes en el largo plazo, al desaparecer sus células diana, en lo que algunos autores denominan fase 4. El anticuerpo monoclonal teplizumab ha demostrado reducir la tasa de progresión de la fase 2 a la 3 (evitando así la "diabetes clásica"), por lo que a día de hoy se recomienda el screening de autoinmunidad pancreática en familiares de diabetes tipo 1, para poder plantear dicho tratamiento.

154. Mujer que acude a consulta de endocrino por secreción láctea por el pezón y una cifra de prolactina en sangre de 45 pg/L (normal <20 pg/L). ¿Cuál es la actitud diagnóstica más apropiada?

1. La primera medida a realizar es una resonancia cerebral porque lo más probable es que sea un macroadenoma secretor de prolactina.
2. Se debe interrogar sobre la toma de fármacos

- antagonistas del receptor de dopamina o un posible embarazo.
3. Las pruebas de laboratorio para su correcta caracterización consisten en la medición aislada de prolactina.
 4. Se debe descartar un hipertiroidismo primario.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos plantean una pregunta fácil sobre manejo básico de hiperprolactinemia. La prolactina es una hormona de estrés, por lo que se recomienda la medición repetida antes de establecer el diagnóstico (opción 3 incorrecta). Establecido el diagnóstico, lo primero es una rigurosa anamnesis de fármacos y comorbilidades, pues las causas más frecuentes son de tipo farmacológico o funcional (opción 2 correcta). La TRH estimula la síntesis de prolactina, por lo que los hipotiroidismos primarios y los hipertiroidismos terciarios por TRHoma pueden provocar hiperprolactinemia (opción 4 incorrecta). La búsqueda de lesiones por neuroimagen se plantea tras descartar causas médicas, no como primera opción (opción 1 incorrecta).

155. La estrategia de cribado de diabetes gestacional en un solo paso consiste en:

1. Test de sobrecarga oral de glucosa con 50 g de glucosa.
2. Test de sobrecarga oral de glucosa con 75 g de glucosa.
3. Test de sobrecarga oral de glucosa con 90 g de glucosa.
4. Test de sobrecarga oral de glucosa con 100 g de glucosa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

“Pregunta difícil. Existen 2 estrategias para el diagnóstico de diabetes gestacional (DG): 1) Estrategia en un paso: consiste en la realización de SOG de 75 gramos, cuyos puntos de corte serían 93-180-153 mg/dL (basal, 1 hora y 2 horas tras ingesta). El diagnóstico de DG se realizaría con la alteración de uno de los tres puntos de corte. En el momento actual, el Grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE) no consideran el uso de la estrategia diagnóstica en un paso, debido a que en nuestro medio existiría un sobrediagnóstico de la misma. Sin embargo, otras guías internacionales (NICE, FIGO, ADA) apoyan el uso de esta estrategia. 2) Estrategia en dos pasos: empleada en la mayoría de las ocasiones, que consiste en realizar la prueba de O’Sullivan de despistaje: determinación de glucemia en plasma venoso, una hora después de la ingesta de 50 g de glucosa. Se acepta como resultado positivo una cifra de glucemia ≥ 140 mg/dL. Se seguiría en dicho caso de la SOG de 100 g de confirmación, que consistiría en la determinación de glucemia en plasma venoso en ayunas (basal), y tras la ingesta de 100 g de glucosa (a la hora, dos horas y tres horas). Se considerará diagnóstico de DG el hallazgo alterado de 2 o más valores: basal ≥ 105 mg/dL, 1 hora ≥ 190 mg/dL, 2 horas ≥ 165 mg/dL, 3 horas ≥ 145 mg/dL.”

156. Está de guardia en urgencias y valora a un hombre de 45 años que consulta por vómitos de 2-3 días de evolución con disconfort abdominal y astenia intensa desde hace 1 mes. La presión arterial en triaje es 85/40 mmHg. Cuando lo explora objetiva hiperpigmentación parcheada en la cavidad oral y en la analítica destaca sodio de 134 mEq/L. ¿Cuál es su primera opción diagnóstica de las expuestas a continuación?

1. Hemocromatosis.
2. Síndrome de Peutz Jeghers.
3. Enfermedad de Addison.
4. Síndrome Stevens-Johnson.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un caso arquetípico de insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. De forma crónica cursa con astenia, disconfort abdominal o epigastralgia, e hiperpigmentación cutánea y de mucosa oral (muy específica); es habitual que consulten en urgencias por vómitos incontrolables y epigastralgia de escasos días de evolución, a veces con fiebre (muchas veces en el contexto de un cuadro viriásico inespecífico, que precipita la entrada en crisis adisoniana). La sospecha clínica se verá apoyada por la triada clásica de hipoglucemia + hipotensión + hiponatremia, y el diagnóstico se basa en el test de ACTH.

157. ¿Qué fármaco de los mencionados a continuación ha de tenerse en cuenta cuando se evalúa a un paciente con hiperparatiroidismo?

1. Hidroclorotiazida.
2. Losartan.
3. Amlodipino.
4. Doxazosina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa y fácil sobre hipercalcemia. Los diuréticos tiazídicos, como la hidroclorotiazida, aumentan la reabsorción de calcio en el túbulo distal renal, lo que puede llevar a hipercalcemia y, en algunos casos, desenmascarar un hiperparatiroidismo primario o agravarlo si ya está presente. Los otros fármacos (losartán, amlodipino y doxazosina) no tienen un impacto significativo en el metabolismo del calcio ni en la función paratiroidea.

158. ¿Cuál de las siguientes causas de hipertiroidismo puede cursar con TSH normal o elevada?

1. Tirotoxicosis facticia.
2. Struma ovarii.
3. Adenoma hipofisario productor de TSH.
4. Hipertiroidismo por beta-HCG durante la gestación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre hipertiroidismo. El adenoma hipofisario productor de TSH (o TSHoma) es una causa muy rara de hipertiroidismo central, en la que el tiroides se estimula por una secreción inadecuadamente elevada de TSH. La TSH estará por tanto inadecuadamente elevada (puede ser alta o “bioquímicamente normal”), no suprimida, lo que lo diferencia de todas las causas de hipertiroidismo primario, donde la TSH está suprimida.

159. Hombre de 58 años, fumador de 30 cigarrillos diarios desde los 19 años, con antecedentes de hipertensión arterial mal controlada, diabetes mellitus tipo 2 y obesidad grado I. En estudio por disnea de 5 meses de evolución, asociando pérdida de peso, astenia e hiporexia. Como parte del estudio se realiza TC toracoabdominal describiéndose la presencia de un nódulo pulmonar inespecífico de 1,1 cm en lóbulo superior derecho sin datos de malignidad y un nódulo en la glándula suprarrenal derecha de 1,9 cm. ¿Qué pruebas complementarias habría que solicitar para el estudio del incidentaloma suprarrenal?

1. Test de supresión con 8 mg de dexametasona (DXM) nocturno, metanefrinas libres plasmáticas y resonancia magnética centrada en suprarrenales.
2. Metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas, test de supresión con 1 mg DXM nocturno, ratio renina/aldosterona y PET-TC con 18FDG.
3. Metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas, test de supresión con 1 mg DXM nocturno, ratio aldosterona/renina y TC centrada en adrenales.
4. Cortisol libre urinario, metanefrinas fraccionadas en muestra aislada de orina, ratio aldosterona/renina y resonancia magnética centrada en suprarrenales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Manejo del incidentaloma, contestable con ideas básicas, pero con un distractor (el nódulo pulmonar) que puede llevarnos a error. El manejo inicial de un incidentaloma pasa por descartar tumor adrenal funcionante subclínico mediante estudios funcionales básicos de función glucocorticoide (se prefiere el test de Nugent al CLU), mineralocorticoide (cociente aldosterona/renina) y de catecolaminas, y el estudio de imagen del tumor. La medición de catecolaminas se hace con las metanefrinas (mejor especificidad que las catecolaminas) en orina de 24 horas (por lo que descartamos las opciones 1 y 4). Las opciones 2 y 3 plantean el mismo estudio funcional, pero difieren en la prueba de imagen. La mejor prueba de imagen para el incidentaloma adrenal es el TAC centrado en las glándulas suprarrenales, siendo superior la RM para la valoración de feocromocitoma y para la delimitación de invasión de planos y vascular en algunos casos. Podemos dudar con el PET-TAC, pues nos podría servir para la búsqueda de otras causas del cuadro constitucional

del paciente, pero recuerda que la pregunta se ciñe explícitamente al “estudio del incidentaloma”.

160. Mujer de 25 años, sin enfermedades previas conocidas, que consulta por lesión en labio inferior. No es la primera vez que le sucede desde la adolescencia, siempre en la misma zona, inicia dolor y aparece una lesión vesiculosa que se autolimita en una semana aproximadamente. Respecto al abordaje de la enfermedad de esta paciente, es INCORRECTO que:

1. Si presenta más de tres episodios anuales está indicado realizar profilaxis con un antiviral como valaciclovir 500 mg cada 12 horas o 1 g al día, durante seis meses.
2. Si es una única lesión y es un cuadro leve puede no realizarse ningún tratamiento o bien realizar tratamiento tópico con fomentos de sulfato de zinc o de cobre.
3. Si existe riesgo de afectación oftálmica estaría indicado tratar con un antiviral como valaciclovir a razón de 1 g cada 8 horas durante 7 días vía oral.
4. Es necesario recomendarle una adecuada protección solar pues la exposición solar puede motivar recurrencias.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Es una pregunta sobre un herpes labial recidivante. En los pacientes con recurrencias muy frecuentes (6 o más al año) se puede utilizar el tratamiento supresor (durante 6 a 12 meses), que disminuye mucho el número de episodios. Por lo tanto, la opción 1 es falsa.

161. Hombre de 50 años que presenta una erupción generalizada, especialmente en el tronco. Refiere malestar general desde hace pocos días. Hoy acude porque ha tenido fiebre la noche anterior y se ha visto una mancha negra en la zona abdominal. A la exploración física, la mancha negra corresponde a una pequeña escara. El paciente es cazador y acudió recientemente a una batida. Sobre el abordaje del caso es cierto que:

1. Es una enfermedad de declaración obligatoria.
2. El tratamiento de elección es la amoxicilina, un gramo cada 8 horas durante 7 días.
3. Debe derivarse a un centro hospitalario.
4. En la mayoría de los casos, la fiebre precede al exantema y la escara.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una fiebre botonosa mediterránea. Nos cuentan los antecedentes epidemiológicos típicos (cazador) y con la clínica típica (fiebre, rash, escara negra). Es una enfermedad de declaración obligatoria (opción 1 cierta) y el tratamiento

de elección, como en la mayoría de las zoonosis, es la doxiciclina, no siendo efectivos los betalactámicos (opción 2 falsa).

162. Respecto al tratamiento de la foliculitis, es correcto que:

1. El tratamiento de elección, incluso en formas localizadas, es la cloxacilina vía oral.
2. En caso de alergia a la penicilina, la opción más adecuada sería el ciprofloxacino oral.
3. Debe realizarse tratamiento oral en pacientes con valvulopatía reumática por el riesgo de endocarditis.
4. Es una infección fundamentalmente estreptocócica por *Streptococcus pyogenes*.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta controvertida y mal formulada que finalmente se anuló. Las foliculitis son infecciones habitualmente estafilocócicas (opción 4 incorrecta) que afectan a la parte superficial del folículo piloso y se presentan como pústulas centrofoliculares que pueden ser pruriginosas. Habitualmente se trata de infecciones leves y localizadas, por lo que pueden tratarse con antisépticos o antibióticos tópicos (como la mupirocina, el ácido fusídico o la clindamicina; opción 1 incorrecta). En caso de precisar tratamiento oral en alérgicos a la penicilina, el ciprofloxacino tampoco sería la mejor alternativa con mayor cobertura para *S. aureus* (opción 2 incorrecta). Aunque inicialmente el Ministerio dio por buena la opción 3 (y es cierto que en ciertas valvulopatías debe realizarse profilaxis de endocarditis ante algunos cuadros infecciosos), se trata de una afirmación demasiado categórica que debería individualizarse y probablemente no sea necesaria en los casos leves de foliculitis (la mayoría).

163. Hombre de 62 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y en tratamiento con infliximab por artritis reumatoide, se presenta en urgencias con fiebre, tos seca, mialgias y disnea leve de 5 días de evolución. A la exploración física, la saturación de oxígeno es del 90% con aire ambiente. Se realiza una radiografía de tórax que muestra opacidades en vidrio deslustrado bilaterales. La PCR en frotis nasofaríngeo para SARS-CoV-2 resulta positiva. ¿Cuál de las siguientes opciones es la conducta más apropiada?

1. Administrar plasma de convaleciente y anticoagulación profiláctica.
2. Iniciar tratamiento con antibióticos de amplio espectro y corticoides a dosis altas.
3. Monitorización ambulatoria con seguimiento telefónico y tratamiento sintomático.
4. Ingreso hospitalario para tratamiento con remdesivir y dexametasona.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre el tratamiento de un paciente que cumple criterios de gravedad por neumonía por COVID. Es un paciente inmunodeprimido con saturación de oxígeno del 90%, por lo que debe ingresar. En este caso, está indicado el tratamiento con corticoides y remdesivir (opción 4 cierta). Recuerda que el tratamiento antibiótico está solo indicado en caso de sospecha o confirmación de sobreinfección bacteriana.

164. Hombre de 56 años, nacido en Paraguay, acude a consulta, remitido por su médico de familia, por disnea progresiva y palpitaciones. Tiene un ECG en el que se observan extrasístoles ventriculares y bloqueo completo de rama derecha. Aporta una serología por ELISA IgG positiva frente a *Trypanosoma cruzi*. ¿Cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA?

1. Se debe realizar una prueba serológica con inmunofluorescencia para detectar IgG frente a *T. cruzi*.
2. La prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) tiene un valor diagnóstico limitado en esta fase de la enfermedad.
3. Debe iniciar tratamiento con benznidazol para modificar la evolución de la enfermedad.
4. Si se confirma el diagnóstico, debe estudiar a los familiares cercanos para identificar otros casos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos preguntan acerca de diferentes conceptos de la enfermedad de Chagas. Debido a la inespecificidad de las pruebas serológicas, el diagnóstico se debe de confirmar con dos pruebas serológicas frente a dos antígenos distintos (opción 1 cierta). La PCR, aunque puede ser útil en algunas situaciones, tiene un valor limitado en la infección crónica (opción 2 cierta). La terapia antitripanosómica está justificada para todos los pacientes con infección aguda o congénita. También se recomienda tratamiento a los adultos <50 años que no tengan afectación cardíaca o digestiva establecida. Esto es debido a que el tratamiento pierde eficacia con la edad y la cronicidad de la infección, siendo inefectivo cuando ya están establecidas las complicaciones de la infección crónica. (opción 3 falsa). Como se ha preguntado en otras ocasiones, se debe estudiar a aquellos familiares expuestos (opción 4 cierta).

165. Una mujer de 45 años con antecedentes de pleuritis hace 3 años y episodios ocasionales de poliartritis en los últimos 8 meses, fue diagnosticada de LES hace un mes tras un ingreso por fatiga y dolor torácico opresivo de esfuerzo, donde se objetivó una Hb de 5,8 g/dL y VCM de 109 fL por una anemia hemolítica autoinmune. El resto de la analítica mostró una linfopenia de 900/mm³, plaquetas en rango

de normalidad, función hepática, creatinina y ionograma normales, tiempo de protrombina 85%, TTPa se muestra prolongado (ratio de 1,8). Existe hipocomplementemia C3 y C4, ANA 1/640, con Anti-DNA positivo. Fue dada de alta con corticoides, hidroxiclороquina y belimumab semanal subcutáneo. A las tres semanas del alta refiere sensación disneica de 48 horas de evolución sin otros síntomas acompañantes, la Hb de urgencias es de 10,2 g/dL. ¿Cuál de las siguientes determinaciones de laboratorio deberíamos realizar en primer lugar?

1. Dímero D.
2. Proteínas en orina.
3. NT-proBNP.
4. Test de Coombs.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que intenta distraer nuestra atención describiendo un caso de lupus eritematoso (una enfermedad siempre compleja) con anemia hemolítica y (dato clave) TTPa alargado (lo que sugiere fuertemente la presencia de anticoagulante lúpico). A pesar de haber iniciado un tratamiento correcto a las pocas semanas regresa a Urgencias por disnea y se comprueba que no hay anemización aguda. Aunque el diagnóstico diferencial de la disnea en este escenario no deja de ser amplio, en la pregunta sólo nos piden elegir entre varias determinaciones de laboratorio cuál nos parece que debería realizarse en primer lugar. Entre ellas nos ofrecen: dímeros D (opción correcta, alta sospecha de síndrome antifosfolípido secundario asociado y por tanto, alto riesgo trombótico de partida, lo que eleva la sospecha inicial de tromboembolismo pulmonar), proteínas en orina (podría servir para detectar afectación glomerular pero no explicaría la disnea), el NT-proBNP (no hay sospecha de congestión cardiaca) y el test de Coombs (poco útil para explicar la disnea actual toda vez que las cifras de Hb han mejorado sustancialmente comparándolas con la determinación previa).

166. **Mujer de 72 años, procedente del medio rural que acude al servicio de urgencias por un cuadro de dolor abdominal, vómitos y diarrea líquida, que posteriormente se hace sanguinolenta, de 6 días de duración. No refiere fiebre ni tratamiento antibiótico previo. Se toman muestras para hemocultivo y estudio microbiológico de las heces y se inicia tratamiento con fluidoterapia intensiva. 48 horas después se observa disminución del nivel de conciencia y la presencia de anemia (hematocrito de 25%, hemoglobina de 7,9 g/dL), trombocitopenia (plaquetas de 60.000/mL), creatinina de 3,2 mg/dL, hematuria y hemoglobinuria. En el estudio de sangre periférica se aprecian abundantes esquistocitos circulantes (más del 10%). Se señala la respuesta INCORRECTA:**

1. Debe tratar de identificar infección por E. coli, serotipo O157:H7 y detección por PCR de toxina Shiga (Stx1 y/o Stx2) y genes relacionados.
2. Debe iniciar tratamiento antibiótico.
3. El cuadro clínico y analítico descarta la posibilidad de infección por Clostridium difficile.
4. La plasmaféresis no es útil en esta paciente.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente con cuadro de fracaso renal agudo (Cr 3,6 mg/dl), trombopenia y anemia con datos de hemólisis (hemoglobinuria), de origen microangiopático (esquistocitos en el frotis). Dado que se ha desencadenado tras un cuadro diarreico, estamos ante un síndrome hemolítico urémico típico (SHU típico). El SHU típico está causado habitualmente por cepas enterohemorrágicas de E. coli productor de toxina Shiga (la más frecuente el serotipo O157:H7) (respuesta 1 verdadera), no siendo Clostridioides difficile un causante del mismo (respuesta 3 verdadera). Aunque es más frecuente en niños, los adultos también lo pueden presentar. El tratamiento es exclusivamente de soporte (respuesta 4 verdadera), siendo de especial importancia EVITAR el inicio de antibioterapia, ya que con la muerte bacteriana aumentaríamos la liberación de toxina Shiga y, con ello, la gravedad del cuadro (respuesta 2 falsa, por tanto CORRECTA).

167. **Mujer de 54 años de edad que acude a su consulta para estudio y evaluación del riesgo vascular. Entre sus antecedentes más relevantes, destacan un infarto agudo de miocardio a los 51 y a los 53 años de edad, hipertensión arterial controlada y un perfil lipídico con tratamiento hipolipemiente de alta intensidad de: colesterol total 120 mg/dL, cHDL 60 mg/dL, cLDL 50 mg/dL, TG 128 mg/dL. HbA1c de 5.2% y glucemia plasmática en ayunas normal. Nunca ha fumado. Índice de masa corporal de 23 Kg/m². De las siguientes pruebas o determinaciones que se exponen a continuación, ¿qué es más útil para determinar el riesgo y la etiología de eventos recurrentes en esta paciente?**

1. Determinación de ApoB.
2. Determinación de ApoA.
3. Determinación de Lp(a) o lipoproteína A.
4. Determinación de proteína C-reactiva.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La pregunta enlaza directamente con el concepto de riesgo vascular residual, que hace referencia al riesgo de eventos cardiovasculares que persiste a pesar del control óptimo de los factores de riesgo convencionales, como la dislipemia, la hipertensión y la diabetes. En esta paciente, el riesgo vascular clásico está muy bien controlado (perfil lipídico controlado con un tratamiento hipolipemiente de alta intensidad, no tiene diabetes ni obesidad, y no es fumadora), y sin embargo

ha sufrido dos infartos precoces (51 y 53 años), lo que sugiere que su riesgo cardiovascular no está completamente explicado por los factores tradicionales. Aquí es donde entra la Lp(a), un factor de riesgo genético y no modificable que puede contribuir a este riesgo vascular residual. Medir la Lp(a) en estos casos permite identificar a pacientes que, a pesar de un buen control lipídico, siguen en alto riesgo debido a su predisposición genética. Aunque actualmente no existen tratamientos específicos aprobados para reducir la Lp(a), su detección puede guiar decisiones clínicas, como considerar intensificar la prevención secundaria con inhibidores de PCSK9, que han mostrado cierto efecto reductor sobre la Lp(a), u otras terapias emergentes.

168. Mujer de 28 años sin enfermedades previas, recién llegada de los Estados Unidos de América, donde ha estado practicando espeleología en el valle del Ohio durante un par de semanas, presenta clínica de infección respiratoria consistente en tos, fiebre, sensación disnea y artralgias, lesiones cutáneas nodulares y dolorosas, eritematosas y calientes en la zona pretibial. ¿En qué enfermedad hay que pensar?

1. Aspergilosis pulmonar.
2. Esporotricosis.
3. Criptococosis pulmonar.
4. Histoplasmosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico de histoplasmosis. Se trata de una mujer sin antecedentes relevantes con historia epidemiológica compatible: espeleología, viaje a Estados Unidos y clínica respiratoria.

169. Hombre de 53 años, sin antecedentes patológicos, acude al hospital por fiebre de 10 días de evolución, con intensa cefalea retroorbitaria y una importante sensación de fatiga. No refiere dolor musculoesquelético, lesiones cutáneas ni ningún otro síntoma acompañante. A lo largo de 15 días de ingreso se objetiva fiebre persistente y la aparición de discreta ictericia conjuntival. La exploración respiratoria, cardíaca, abdominal y neurológica es normal. La analítica muestra VSG 97 mm/h, PCR 24.5 mg/dL, GOT 156 U/L, GPT 148 U/L, FA 410 U/L, GGT 794 U/L, bilirrubina total 55 mg/dL a expensas de la bilirrubina directa, hemoglobina 11.5 g/dL, recuento leucocitario normal, plaquetas 648.000/mm³, función renal e ionograma normales, tiempo de protrombina normal pero TTPA ratio 18. Los anticuerpos antinucleares (ANA) son positivos a títulos 1/160. Una ecografía abdominal no muestra ninguna alteración destacable. Desde el punto de vista clínico y a la vista de los datos analíticos, ¿cuál de las siguientes enfermedades es la que se ajusta mejor con nuestro paciente?

1. COVID-19.
2. Fiebre Q aguda.
3. Leptospirosis grave (enfermedad de Weil).
4. Colangitis esclerosante primaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil en la que nos presentan una fiebre de duración subaguda con cefalea y datos de hepatitis (elevación de transaminasas, ictericia, coagulopatía). Con estos datos podríamos tener dudas razonables entre la fiebre Q y la leptospirosis. La leptospirosis grave (síndrome de Weil) incluye en su triada, además de la ictericia y coagulopatía, la afectación renal que está “siempre” presente (al menos, tendrían que hablar de alteraciones en el sedimento o fracaso renal). Por otra parte, no hay antecedentes epidemiológicos que nos indiquen la posibilidad de leptospirosis (pocero, espeleólogo, aguas estancadas...). Por todo ello, la respuesta correcta es la fiebre Q.

170. Hombre de 38 años con dependencia alcohólica grave. Ha tenido varios ingresos por pancreatitis aguda en el contexto de ingesta de alcohol e hipertrigliceridemia grave. Acude a consulta 12 meses después del último episodio de pancreatitis. No presenta clínica que sugiera insuficiencia pancreática exocrina. Niega reiteradamente ingesta de alcohol. Sigue tratamiento con estatinas y fibratos que asegura tomárselos. Aporta un análisis básico reciente de su empresa con los siguientes datos: colesterol 300 mg/dL, cHDL 42 mg/dL, TG 1102 mg/dL, cLDL no calculable por Friedewald. Colesterol no-HDL 258 mg/dL, ApoB 90 mg/dL, Lp(a) 38 nmol/L (normal <125 nmol/L). En dicho análisis hay un dato, además de la hipertrigliceridemia, que sugiere que el paciente continúa ingiriendo alcohol. Señálelo.

1. ApoB.
2. cHDL.
3. Lp(a).
4. Colesterol total.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil, que requiere a la vez conocimiento y ponderación de los datos clínicos. El consumo de alcohol, incluso en cantidades moderadas, aumenta los niveles de HDL al inducir la actividad de la enzima lecitina-colesterol aciltransferasa (LCAT) y reducir la actividad de la proteína de transferencia de ésteres de colesterol (CETP). En pacientes con consumo crónico de alcohol, este efecto puede ser aún más pronunciado. Nuestro paciente tiene un HDL de 42, dentro del rango de lo normal para su edad, pero inapropiadamente alto en el contexto de una hipertrigliceridemia, donde es típico que haya niveles bajos de HDL (el HDL tiende a estar bajo debido al intercambio de triglicéridos por ésteres de colesterol mediado por CETP, lo que reduce la estabilidad de las partículas de HDL). Por ello, dicho HDL

en esta hipertrigliceridemia salvaje apoya la hipótesis de que el paciente sigue ingiriendo alcohol.

171. Respecto a las infecciones de las heridas quirúrgicas, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Diabetes mellitus, malnutrición, obesidad e inmunosupresión son factores de riesgo del paciente para desarrollar infecciones de las heridas quirúrgicas.
2. El control intensivo perioperatorio de la glucemia es una buena práctica de prevención de las infecciones de herida quirúrgica.
3. La mayoría de las recomendaciones sobre profilaxis antibiótica en cirugía cardíaca aconsejan mantener los antibióticos al menos 48 horas tras el procedimiento quirúrgico.
4. La antibioterapia local se emplea como método de profilaxis antimicrobiana y tratamiento antibiótico, sobre todo en la sustitución de prótesis articulares infectadas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los bundles quirúrgicos de infección cero de la OMS incluyen normoglucemia (110-180 mg/dL), profilaxis antibiótica prequirúrgica (30-60 min antes de la cirugía), normotermia, recorte del vello con recortadora, higiene quirúrgica y lavado con clorhexidina alcohólica al 2%. En cirugía cardíaca, la profilaxis antibiótica puede mantenerse hasta 24-48 horas, aunque nunca más de 48 horas y además por definición se considera terapéutica. Además, algunas guías sugieren un control glucémico más estricto (<140 mg/dL) en este ámbito cardíaco. En cirugía ortopédica, las guías americanas recomiendan la irrigación con antibióticos locales en cirugía traumatológica, especialmente en prótesis

172. Hombre de 37 años con infección VIH ha dejado de tomar el tratamiento por razones personales hace 3 meses; estaba tomando una combinación de dos inhibidores de transcriptasa inversa y un inhibidor de la integrasa. En la evaluación llevada a cabo en este momento tiene 120 linfocitos CD4/mm³ y una carga viral de VIH-1 de 80.000 copias/mL. Estamos pendientes del estudio de resistencias. ¿Qué debemos recomendarle en este momento?

1. Reiniciar el tratamiento con lo mismo con lo que estaba previamente.
2. Esperar a tener el resultado del estudio de resistencias para orientar el tipo de tratamiento en función de las mutaciones identificadas.
3. Prescribir a partir de ahora un régimen basado en inhibidores de proteasa por su mayor barrera genética a las resistencias.
4. Iniciar doble terapia con inhibidores de integrasa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy difícil. Nos presentan un paciente que ha abandonado el tratamiento, aunque no nos especifican los motivos. En principio, si nos dijeran que el paciente tiene mala tolerancia o efectos adversos de los fármacos (como motivo del abandono terapéutico), habría que cambiar la pauta. Si nos comentaran (como en la pregunta de años anteriores) que tuviera historia de mal cumplimiento terapéutico, habría que sospechar posibilidad de selección de resistencias y, por tanto, la nueva pauta debería de incluir un fármaco con alta barrera genética (inhibidor de la proteasa, bictegravir o dolutegravir). La duda razonable de esta pregunta es elegir entre la opción 1 y la 3. Dado que, en principio, no hay datos que nos indiquen la posibilidad de resistencias o efectos adversos, en la práctica clínica se opta por reiniciar la pauta previa. Recordad que, dentro de los inhibidores de la integrasa, presentan alta barrera genética tanto el bictegravir como el dolutegravir.

173. Hombre de 55 años con antecedentes de cáncer de pulmón (estadio IV). Su madre murió a los 65 años por un episodio de broncoaspiración. Consulta por debilidad muscular en los muslos y disfagia. Exploración física: fuerza en psoas 4+/5, cuádriceps 3/5, deltoides 5/5. Presenta ptosis palpebral bilateral y no tiene diplopía. Los valores de CPK eran 900 UI/L (normal <150 UI/L) y los de aldolasa, 7 UI/L (normal <6 UI/L). Se practicó una biopsia en el músculo vasto lateral externo del muslo derecho, en la cual se objetivó variabilidad en el tamaño de fibras, aumento del tejido conectivo, imágenes de pseudodivisión celular y vacuolas ribeteadas; no se observó infiltrado inflamatorio. ¿Qué es lo más probable que le suceda al paciente?

1. Distrofia oculofaríngea.
2. Miopatía mitocondrial.
3. Miastenia gravis.
4. Miositis con cuerpos de inclusión.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy difícil cuya opción correcta es la 1: distrofia oculofaríngea (DOF). El principal diagnóstico diferencial se plantea con la miositis por cuerpos de inclusión (MCI) (opción 4). Nos presentan el caso de un varón de mediana edad con un cuadro de miopatía caracterizado por debilidad muscular proximal en miembros inferiores y niveles elevados de CPK. Además, presenta ptosis palpebral y disfagia. Si bien la disfagia puede aparecer en la MCI, la ptosis no es característica de esta entidad, mientras que sí lo es en la DOF. Otro dato relevante es el antecedente familiar: su madre falleció por broncoaspiración (nos orienta a disfagia), lo que refuerza el diagnóstico de DOF, dado que esta enfermedad es hereditaria, generalmente autosómica dominante. En la biopsia NO se observa infiltrado inflamatorio, hallazgo esperable en las miopatías inflamatorias como la MCI.

Sí aparecen vacuolas ribeteadas, que indican acumulación anómala de proteínas y disfunción en los mecanismos de degradación celular. Aunque estas vacuolas aparecen en la MCI, no son exclusivas de esta enfermedad, ya que también pueden encontrarse en otras enfermedades neuromusculares hereditarias como la DOF o amiotopías distales. Considerando todos los hallazgos, por tanto, el cuadro es más sugestivo de DOF (respuesta 1 correcta). Las otras dos opciones plantean menos dudas: La miopatía mitocondrial puede presentarse con ptosis, pero suele asociar otros síntomas como intolerancia al ejercicio y fibras rojo-rasgadas en la biopsia. La miastenia gravis, aunque puede causar ptosis y debilidad, no cursa con niveles tan elevados de CPK ni los hallazgos de la biopsia son compatibles.

174. Mujer de 81 años consulta por cuadro de 1 mes de duración de astenia, febrícula, pérdida de unos 4 kg de peso, cefalea hemisférica izquierda y dolor en la zona de los hombros y de las caderas, que le dificulta los movimientos después de estar en reposo. Se palpa una zona engrosada y dolorosa en el territorio de la arteria temporal izquierda. Respecto al proceso diagnóstico de esta paciente, señale la opción INCORRECTA:

1. La vasculitis sistémica que se sospecha con mayor probabilidad es una vasculitis de gran vaso.
2. En el análisis, la normalidad de la velocidad de sedimentación globular apoya el diagnóstico de esta vasculitis.
3. Es frecuente observar afectación de la pared arterial de la aorta y sus ramas principales mediante pruebas de imagen.
4. Una biopsia de la arteria temporal que muestre un infiltrado inflamatorio en la pared arterial confirmaría el diagnóstico de arteritis de células gigantes.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un caso clínico típico de arteritis de células gigantes (ACG): mujer de edad avanzada con cefalea, polimialgia reumática y síndrome constitucional (astenia, febrícula y pérdida de peso). La ACG es una vasculitis de vaso grande (respuesta 1 correcta) que puede presentar afectación craneal, extracraneal o mixta. La afectación craneal se manifiesta con cefalea de nueva aparición o diferente a la habitual, así como síntomas isquémicos, como claudicación mandibular o neuritis óptica isquémica anterior. La afectación extracraneal se asocia a síntomas constitucionales, que pueden indicar compromiso de la aorta y sus principales ramas, como las arterias axilares. Esta afectación es frecuente, presente en al menos el 50% de los pacientes (concepto preguntado previamente en el MIR). Puede detectarse mediante estudios de imagen como PET-TAC, ecografía o angio-RM. Los hallazgos en la biopsia de arteria temporal del característico infiltrado inflamatorio con células gigantes multinucleadas confirma el diagnóstico (respuesta 4 correcta), aunque no es necesaria realizarla siempre. La ACG se

caracteriza por una elevación marcada de reactantes de fase aguda, especialmente VSG y PCR. Su ausencia hace muy improbable el diagnóstico (respuesta 2 incorrecta).

175. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es la más característica de la miopatía de la dermatomiositis?

1. Dificultad para andar.
2. Dificultad para subir escaleras.
3. Dificultad para abrocharse los botones.
4. Dolor muscular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. En la dermatomiositis, la afectación muscular es característicamente simétrica y proximal, por lo que los pacientes que la padecen tienen dificultad para subir escaleras o levantarse de la silla y para levantar los brazos, peinarse, etc. Opción 2 correcta.

176. Mujer de 38 años que consulta por la presencia de dolor ocular, ojo rojo bilateral, hipersensibilidad a la luz y disminución de la agudeza visual. La historia clínica se completa con antecedentes de aftas bucales dolorosas y recidivantes y un diagnóstico previo de eritema nodoso hace 2 años. En la exploración oftalmológica se observa panuveítis bilateral con signos de vasculitis retiniana bilateral. Señale la respuesta correcta sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que sospecha en esta paciente:

1. El hallazgo de HLA B*51 confirma el diagnóstico de sospecha.
2. Las úlceras bucales dejan cicatriz en la mayoría de los casos.
3. Debe instaurar tratamiento precoz e intensivo con glucocorticoides sistémicos e inmunosupresión con azatioprina.
4. La adición al tratamiento de anticuerpos monoclonales anti TNF alfa o ciclosporina no mejora el control de la uveítis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un caso clínico de una paciente joven con historia de aftas orales dolorosas recidivantes y eritema nodoso que presenta en este momento una panuveítis, es decir, una uveítis con afectación de las tres cámaras oculares (anterior, intermedia y posterior), por lo que debemos sospechar una enfermedad de Behçet. La uveítis es una de las manifestaciones más graves de la enfermedad. Aunque puede presentarse de diversas formas, su patrón de afectación más frecuente es una panuveítis bilateral. La afectación posterior con hallazgos de vasculitis retiniana es la que confiere un peor pronóstico y requiere de un tratamiento precoz e intensivo que consiste en el uso de corticoides sistémicos a dosis altas asociados a un inmunosupresor como azatioprina (opción 3 correcta). Otros fármacos que también se utilizan

para el tratamiento de la uveítis son la ciclosporina, los anticuerpos monoclonales inhibidores de TNF alfa o el interferón alfa (opción 4 incorrecta). Aunque el HLAB51 se asocia a la enfermedad de Behçet, su positividad no confirma el diagnóstico y, del mismo modo, su negatividad tampoco lo descarta (opción 1 incorrecta). Por último, las aftas orales de la enfermedad de Behçet son típicamente dolorosas y suele curar sin dejar cicatriz (opción 2 incorrecta), mientras que las genitales también son dolorosas pero sí dejan cicatriz.

177. Mujer de 80 años que ingresa en el hospital para estudio de anemia tras ser llevada por sus hijos a urgencias por rectorragia y decaimiento físico. Clínicamente se encuentra estable. Está diagnosticada de un deterioro cognitivo, con ideación y juicio frecuentemente incoherentes y alteraciones conductuales para lo que toma risperidona. Se sospecha neoplasia maligna de colon y se plantea realizar una colonoscopia. Usted verifica que la paciente es incapaz de entender adecuadamente lo que se le explica sobre tal prueba, su naturaleza, objetivos, posibles complicaciones o sus consecuencias diagnósticas y eventualmente terapéuticas. En tal caso, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

1. El médico queda eximido de plantear un proceso de consentimiento informado a la paciente, y se considera suficiente su criterio como médico para que se realice la colonoscopia.
2. El médico debe solicitar la comparecencia del juez, para que autorice la prueba, ante la incapacidad intelectual de la enferma para decidir convenientemente por sí misma.
3. Por no tener la paciente capacidad para decidir, deben hacerlo por ella sus familiares, debiendo quedar constancia escrita en el impreso de consentimiento informado.
4. Es jurídicamente aceptable un acuerdo entre el médico y los familiares de la enferma basado en un consentimiento informado verbal para que se practique la colonoscopia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el consentimiento informado. Nos plantean la realización de una colonoscopia en una paciente incapaz. Debemos buscar el consentimiento por representación, lo más habitual será de sus familiares más cercanos y este deberá ser por escrito al tratarse de una prueba invasiva. Recordemos que el consentimiento informado se debe hacer por escrito en aquellos procedimientos diagnósticos o terapéuticos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente (en general, los que son invasivos). La opción 1 es incorrecta pues solo podemos actuar sin consentimiento en procesos urgentes que precisen intervención rápida para salvar la vida del paciente (no es el caso). La respuesta 2

tampoco es correcta, ya que no necesitamos escalar al juez; el consentimiento pueden darlo los familiares más cercanos o el representante legal en caso de pacientes incapacitados legalmente. La 4 tampoco es correcta al tratarse de un procedimiento invasivo que, por tanto, precisa consentimiento escrito.

178. Atiende a una paciente ingresada desde hace tres semanas en la unidad de cuidados intensivos por un cuadro de shock séptico respiratorio. Su evolución durante el ingreso no ha sido favorable y todavía continúa dependiente de ventilación mecánica invasiva. En los últimos días, tras recibir la información de que probablemente precise ventilación mecánica a medio-largo plazo, durante los periodos en que la paciente ha estado despierta, ha manifestado de forma clara su deseo de no continuar utilizando el ventilador. La paciente afirma comprender las consecuencias de esta decisión. Este caso habla de:

1. Rechazo al tratamiento.
2. Limitación del esfuerzo terapéutico o adecuación de medidas de tratamiento.
3. Suicidio asistido.
4. Eutanasia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla. Nos plantean el caso de una mujer con juicio conservado (expresa de forma clara) que se niega a recibir un tratamiento (ventilación) haciendo uso de su derecho de autonomía. Esta es la definición del rechazo a tratamiento que debemos respetar como profesionales sanitarios, siempre y cuando el paciente esté en plenas facultades. Las demás repuestas son claramente incorrectas. La eutanasia y el suicidio asistido implican provocar de forma intencionada la muerte del paciente (bien a través de un acto médico directo o proporcionando al paciente los medios para hacerlo). La adecuación/limitación del esfuerzo terapéutico consiste en el ajuste, no iniciación o retirada de tratamientos o procedimientos que se consideran fútiles para el paciente. Es una indicación médica (no petición del paciente como es el rechazo), aunque debe ser consensuada con paciente y familia.

179. Respecto al tratamiento del dolor en cuidados paliativos, indique, de las siguientes afirmaciones, cuál es correcta:

1. En la actualidad existen comercializados diferentes fármacos opioides para el tratamiento del dolor moderado o grave en personas que reciben cuidados paliativos, superando en perfil de efectos adversos y en efectividad a la morfina y relegándola a un papel testimonial.
2. La adicción es un problema creciente en pacientes que precisan morfina en su fase final de vida y es más frecuente cuando se emplean fármacos con efecto de larga duración (metadona o morfina de liberación prolongada).

3. El fentanilo oral transmucoso tiene un perfil de acción que lo hace útil en el dolor crónico no irruptivo y de carácter crónico.
4. La metadona es un fármaco analgésico con escasa excreción renal por lo que es útil en personas con aclaramiento renal disminuido.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de complejidad moderada sobre el uso de opioides. La respuesta correcta es la 4. Los opioides en ERC sufren alteraciones en su farmacocinética a muchos niveles pero, sobre todo, en el proceso de eliminación. La mayoría se eliminan a nivel renal, por lo que el descenso del filtrado puede llevar a acumulación y toxicidad. Dentro de los opioides son de especial utilidad en ERC la metadona (metabolismo hepático y excreción principalmente biliar -heces- con 20% de excreción renal), la buprenorfina (metabolismo hepático y eliminación 2/3 inalterados en heces y 1/3 a través de la orina) y el fentanilo (excreción principalmente hepática con aproximadamente un 10% que se elimina inalterado en orina). No obstante, es importante recordar que tanto estos como el resto de opioides siempre deben utilizarse con precaución, a la menor dosis posible que tenga el efecto deseado y valorando la posibilidad de ajuste de dosis (depende del fármaco). Por lo demás, la respuesta 1 es falsa ya que la morfina sigue teniendo un papel crucial en el tratamiento y es el fármaco ideal para titular dosis con sus numerosas presentaciones, dosis y formulaciones. La 2 es falsa ya que los fenómenos de adicción son más frecuentes con fármacos de acción ultrarrápida como el fentanilo transmucoso, dada la rápida respuesta analgésica que producen. La 3 es falsa ya que el fentanilo oral transmucoso (basado en citrato de fentanilo) está indicado en el dolor irruptivo oncológico: exacerbación del dolor transitoria espontánea sobre un dolor basal relativamente controlado y estable (con opioide basal). Es un dolor de súbita aparición, gran intensidad (EVA >7) y corta duración (usualmente <20-30 minutos). Es por ello que el citrato de fentanilo, por su farmacocinética, es de elección en estos casos: su acción comienza entre 5 y 15 minutos dependiendo de la forma de administración y su duración es de 2 a 3 horas, por lo que cubre muy bien el pico de dolor sin prolongar demasiado los efectos secundarios.

180. En relación con la atención en urgencias al paciente menor de edad y de acuerdo con la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuando el profesional sanitario advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre un menor, en un contexto en el que no exista una amenaza evidente sobre su salud o seguridad, tendrá obligación de comunicarlo de forma inmediata:

1. A los servicios sociales competentes.
2. Al juzgado de guardia mediante parte de lesiones.
3. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
4. Al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de su demarcación.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que recoge lo actualizado que suele estar la prueba MIR, exponiendo un caso de posible negligencia del cuidado/maltrato infantil, pero dejando claro que la vida del menor no corre peligro; en este supuesto, a quien prima avisar es a Servicios Sociales; serán las compañeras/compañeros de trabajo social los que iniciarán por ellos mismos el resto de recursos de los que disponen para que el caso sea valorado de forma correcta. Opción 1 a marcar.

181. En relación con la marca producida por el paso de la corriente eléctrica a través de la piel (también conocida como lesión electroespecífica o marca de Jelinek), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

1. La mayor parte de las lesiones producidas por la corriente eléctrica en medio doméstico y laboral proceden de fuentes de alto voltaje.
2. Las lesiones dérmicas dependen del efecto de un aumento de la temperatura generado sobre la dermis.
3. La corriente de bajo voltaje produce lesiones profundas, mientras que la de alto voltaje da lugar a lesiones superficiales adyacentes al punto de contacto con la corriente eléctrica.
4. La marca eléctrica es diagnóstica del lugar en el que se ha producido el contacto y, por tanto, el punto de entrada de la corriente en el cuerpo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil por ser un concepto nuevo de cirugía plástica/medicina legal. La lesión electroespecífica de Jelinek es diferente a lesión térmica a nivel histopatológico. Cuando la corriente eléctrica atraviesa un cuerpo, de modo impredecible, altera sobre todo los tejidos con electrolitos produciendo daño celular, y a nivel de la piel puede aparecer en la entrada de la corriente eléctrica o en la salida a modo de piel apergamada y blanco amarillento por aumento de temperatura produciendo una necrosis coagulativa atípica. Recordad que las corrientes de alto voltaje son de ámbitos industriales y las de bajo voltaje las domésticas. Cuanto más voltaje mayor daño profundo respecto a menos voltaje.

182. Hombre de 85 años con enfermedad de Alzheimer de 6 años de evolución, actualmente en estadio GDS-FAST 7c. Está institucionalizado en centro sociosanitario desde hace 1 año. En los últimos 6 meses tiene frecuentes episodios de broncoaspiración por los que ha acudido a Urgencias y han sido tratados con antibioterapia de amplio espectro con mejoría clínica. Acude nuevamente a urgencias por disnea en relación con nuevo episodio de broncoaspiración y negativa a la ingesta. ¿Cuál debe ser la actitud a seguir?

1. Evitar ingreso. Indicar sonda nasogástrica (SNG) con el fin de prevenir nuevas

- broncoaspiraciones y facilitar ingesta. Antibioterapia empírica con amoxicilina-clavulánico por SNG.
2. Ingresar para colocación de gastrostomía (PEG) con el fin de evitar nuevas broncoaspiraciones y facilitar ingesta. Antibioterapia empírica con piperacilina-tazobactam IV.
 3. Evitar ingreso. No está indicada la colocación de sonda para nutrición enteral. Considerar adecuación del esfuerzo terapéutico evitando antibioterapia y dando cuidados de confort.
 4. Ingresar para antibioterapia empírica con piperacilina-tazobactam, pero evitar la colocación de sonda para nutrición enteral. La curación del proceso infeccioso mejora casi siempre la ingesta.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

“Pregunta sencilla que podemos responder aplicando el sentido común y la ética básica. Plantea un caso muy frecuente en la práctica clínica habitual. Se trata de un paciente anciano con diagnóstico de demencia GDS 7 (escala con grados del 1 al 7), que traduce un déficit cognitivo muy grave con pérdida del habla y la capacidad motora. El estadio GDS 7 se considera una demencia en fase terminal en la que el confort del paciente es la máxima prioridad. En el curso evolutivo de la demencia la mayoría de los enfermos desarrollan diferentes problemas que afectan a su estado nutricional (alteraciones del olfato, del gusto y de las funciones ejecutivas, déficit de atención, alteraciones del comportamiento, disfagia orofaríngea, rechazo a la ingesta, etc.). Las dificultades con la alimentación representan la progresión natural de la enfermedad y cuando son persistentes caracterizan su fase final. El tratamiento nutricional suele generar un importante impacto emocional en las familias, que frecuentemente demandan información y apoyo. Debemos recordar que la nutrición artificial (enteral o parenteral) NO ESTÁ INDICADA en pacientes con demencia avanzada, ya que no mejora el pronóstico vital, la situación nutricional ni la calidad de vida. Por tanto, las respuestas 1 y 2 son falsas. Por otro lado, en caso de neumonía broncoaspirativa podemos pensar en iniciar tratamiento antibiótico aunque no demos nutrición artificial. Sin embargo, en pacientes con situación neurológica tan avanzada y con innumerables episodios infecciosos previos, debemos más bien plantearnos la adecuación del esfuerzo terapéutico. La AET supone la NO iniciación de tratamientos médicos (como antibióticos) que se consideran fútiles al alargar la vida del paciente sin aportar recuperación funcional con calidad de vida aceptable. Esto es así ya que la curación del proceso infeccioso no va a suponer una mejoría en la ingesta del paciente, cuya base es la demencia (pregunta 4 falsa). La adecuación siempre debe ser un proceso consultado con familiares, intentado llegar a un acuerdo que respete las preferencias del paciente y priorice su cuidado.”

- 183. La telemonitorización domiciliar ha demostrado beneficios en pacientes con**

insuficiencia cardíaca. Una mujer de 82 años con insuficiencia cardíaca y diabetes tratada con insulina está en programa de telemonitorización y remite cada semana una serie de parámetros a su médico de familia. La semana pasada presentaba presión arterial 140/85 mmHg. Glucemia capilar basal 120 mg/dL. Glucemia postprandial 2 horas tras la comida 160 mg/dL. Peso 83 kg. Frecuencia cardíaca 72 lpm. Al recibir los parámetros de esta semana que se exponen a continuación, su médico decide citar a la paciente en consulta. ¿Cuál de los siguientes parámetros ha motivado dicha decisión?

1. Presión arterial 135/82 mmHg.
2. Peso 85 kg.
3. Glucemia capilar basal 130 mg/dL.
4. Glucemia capilar postprandial 190 mg/dL.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La telemonitorización consiste en la vigilancia de los pacientes en su domicilio, en general mediante llamadas telefónicas, realizadas habitualmente por personal de Enfermería especializado (para preguntar por síntomas, ajustar dosis de medicación, etc.), y mediante el empleo de dispositivos capaces de transmitir información médica de los pacientes a sus médicos por internet (por ejemplo, básculas que envían el peso diario, esfigmomanómetros que envían la PA o dispositivos capaces de realizar ECGs como relojes inteligentes). En el campo de la insuficiencia cardíaca, la telemonitorización ha demostrado reducir las visitas a urgencias y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, especialmente gracias al diagnóstico precoz del desarrollo de congestión pulmonar o sistémica y su tratamiento mediante la introducción o ajuste de dosis de diuréticos. Para detectar precozmente el desarrollo de congestión, además de los síntomas que cuente el paciente, el parámetro más importante es el peso diario. Un aumento rápido en el peso diario suele indicar acúmulo de líquidos (esto es, congestión), lo que se traducirá en un aumento de dosis de diurético o, como en el caso de la pregunta, en la programación de una consulta preferente para ver al paciente en persona.

- 184. En un paciente con diabetes y obesidad en prevención secundaria cardiovascular, tratado con metformina e iSGLT2, que presenta mal control glucémico, ¿cuál es el fármaco de elección para mejorar dicho control?**

1. Insulina.
2. Análogos del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (aGLP-1).
3. Sulfonilurea.
4. Repaglinida.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El manejo farmacológico de diabetes tipo 2 es un clásico de

las últimas convocatorias MIR. Esta pregunta es por tanto previsible, y además fácil. En la diabetes tipo 2 las guías ADA 2024 recomiendan el inicio con metformina salvo contraindicación o intolerancia, y añadir fármacos con beneficio cardiovascular o renal demostrado con independencia de su necesidad para control glucémico. Este paciente ya estaba con metformina y con un iSGLT2, fármaco de primera elección en insuficiencia cardíaca. Al presentar mal control glucémico procede intensificar tratamiento antidiabético, y al presentar enfermedad cardiovascular el siguiente fármaco debe ser un arGLP1, pues también han demostrado beneficio cardiovascular. La insulina y los fármacos secretagogos de insulina no son cardioprotectores, e incluso pueden aumentar la tasa de descompensaciones de insuficiencia cardíaca.

185. Mujer de 61 años con adenocarcinoma rectal avanzado. Presenta dolor neuropático con irradiación perineal y molestias urinarias en relación con masa presacra. Mejora con tratamiento con opioides (morfina 60 mg cada 12h) pero no tolera más aumento de dosis ni fármacos adyuvantes. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

1. Bloqueo del plexo celiaco.
2. Bloqueo del ganglio impar.
3. Bloqueo de nervios espláncnicos.
4. Bloqueo del nervio pudendo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy compleja sobre el tratamiento analgésico de cuarto escalón (intervencionismo). Dentro de las técnicas intervencionistas para control del dolor existen diferentes tipos: bloqueos (infiltraciones) no neurolíticos (diferentes fármacos que actúan de forma temporal: corticoides, anestésicos locales...) o neurolíticos (destruyen estructuras: alcohol o fenol), radiofrecuencia, neuroestimulación, infusión espinal... Los bloqueos se pueden realizar en casos de dolor isquémico o de mediación simpática, incluido el dolor neuropático, síndrome de dolor regional complejo y dolor abdominal, pélvico o perineal crónico. Las infiltraciones o bloqueos van a ir dirigidas a diferentes estructuras anatómicas según la región a tratar. En esta pregunta nos plantean un paciente con adenocarcinoma rectal avanzado y describen dolor neuropático con irradiación perineal y molestias urinarias en relación con masa presacra. Las respuestas 1 y 3 son falsas. Anatómicamente, en este caso no sería útil bloquear ni plexo celiaco ni nervios espláncnicos. El plexo celiaco se encuentra a nivel retroperitoneal a la altura de T12-L1 y los nervios espláncnicos son un conjunto de nervios que se originan en los ganglios simpáticos situados a los lados de la médula espinal y transportan fibras simpáticas hacia el plexo celiaco y otros ganglios prevertebrales. El bloqueo de ambos es útil para casos de dolor visceral procedente de abdomen superior mal controlado, sobre todo en pacientes con cáncer de páncreas. El nervio pudendo nos puede generar duda por encontrarse en la región pélvica, si bien inerva un territorio más limitado. Es un nervio mixto (sensorial y motor) que se origina de las ramas ventrales de las raíces sacras S2-S4. Es

clave en la inervación de la región perineal ya que sus ramas inervan el esfínter anal externo, piel perineal, músculos del perineo, así como pene y clitoris. Su bloqueo se realiza sobre todo en pacientes con neuralgia del pudendo, que se caracteriza por dolor crónico en la región perineal debidos a inflamación, compresión o atrapamiento del nervio pudendo (secundario a parto, cirugía pélvica, ciclismo intenso, anomalías esqueléticas sacroilíacas o cambios relacionados con la edad, entre otros). Generalmente produce dolor que empeora al estar sentado y mejora al estar de pie o acostado, disfunción sexual y dificultades para orinar o defecar. La respuesta correcta, por tanto, es la 2: el ganglio impar o ganglio de Walter. Es un ganglio simpático solitario localizado en la cara anterior de la unión sacrococcígea, donde convergen las dos cadenas simpáticas sacras. Este ganglio es la terminación de la cadena simpática paravertebral y proporciona inervación simpática y nociceptiva a varias estructuras pélvicas y perineales, incluyendo el perineo, el recto distal, la región perianal, la uretra distal, la vulva/escroto y el tercio distal de la vagina. Su bloqueo se suele indicar en casos de dolor perineal crónico, tenesmo rectal refractario y dolor asociado a cáncer (sobre todo rectal, anal, vulvar o prostático que produzcan dolor pélvico y perineal).

186. En una guardia de centro de salud avisan para atender a un hombre de 63 años, que ha sido sometido a bajas temperaturas, sin precisar cuánto tiempo ha estado en exposición. A su llegada, tiene una temperatura corporal de 28°C. ¿Cuál de los siguientes hallazgos NO cabría esperar en este cuadro?

1. Taquipnea.
2. Fibrilación ventricular.
3. Alucinaciones.
4. Pupilas mióticas.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada. Esta pregunta fue totalmente inesperada y sorpresiva ya que nunca antes en la historia del MIR se ha preguntado con nada relacionado con la hipotermia. Los síntomas y signos de una hipotermia dependen de su gravedad: • Hipotermia leve (de 32 a 35 grados): confusión, taquicardia y aumento del gasto cardíaco, taquipnea, diuresis conservada, atonía vesical, aumento del metabolismo, hiperglucemia, temblor. • Hipotermia moderada (de 28 a 32 grados): obnubilación, alucinaciones, miosis pupilar arreactiva, bradicardia y disminución del gasto cardíaco, bradipnea, diuresis conservada, temblores más reducidos que empiezan a sustituirse por rigidez muscular. • Hipotermia grave (<28 grados): coma, miosis pupilar arreactiva, fibrilación ventricular/asistolia, apnea/edema pulmonar, anuria, disminución del metabolismo, pseudo-rigor mortis a nivel muscular (simula la rigidez típica del paciente que acaba de fallecer). Inicialmente la respuesta que se dio como válida fue la 4 (pupilas mióticas). Sin embargo, fue un error ya que esta opción es verdadera. Además, al haber puesto como temperatura los 28 grados, que es justo el límite entre la hipotermia

moderada y la hipotermia severa, da lugar a confusión ya que hay varias respuestas falsas y varias verdaderas: la taquipnea aparece en hipotermia leve, no en moderada-severa (por lo tanto, la opción es 1 falsa); la fibrilación ventricular aparece típicamente en hipotermias severas, por debajo de los 28 grados (por lo tanto la opción 2 puede considerarse más falsa que verdadera); las alucinaciones son típicas de la hipotermia moderada (opción 3 sí que es verdadera); y las pupilas mióticas se ven en hipotermias moderadas y severas (opción 4 verdadera).

187. En cuanto al uso de anticonceptivos en mujeres jóvenes en las consultas de Atención Primaria, es importante tener en cuenta diversos aspectos para la prescripción. ¿Cuál de las siguientes es INCORRECTA?

1. Se ha de ofrecer consejo contraceptivo estructurado según los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), e información tanto para la prevención de embarazos no planificados, como de enfermedades de transmisión sexual (ETS).
2. Como método anticonceptivo de urgencias, las opciones recomendadas son la toma de levonorgestrel, de acetato de ulipristal o la inserción de un DIU de cobre.
3. Ante la indicación de anticonceptivos orales se recomienda el cribado rutinario de trombofilia y dislipemia y citologías de control anuales.
4. El riesgo de tromboembolia venosa con el consumo de anticonceptivos orales es bajo, siendo el riesgo menor en los de segunda generación, frente al mayor riesgo en los de tercera y cuarta generación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la consulta de Atención Primaria, la prescripción de anticonceptivos en mujeres jóvenes debe basarse en una adecuada evaluación de riesgos y beneficios, considerando las guías internacionales y los criterios de elegibilidad de la OMS asegurando una elección informada y segura. Además, la anticoncepción debe abordarse junto con la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), promoviendo el uso del preservativo cuando sea necesario (opción 1 verdadera). Debemos recordar las 3 opciones de anticoncepción de urgencia: Levonorgestrel (LNG) 1,5 mg, eficaz hasta 72 horas postcoitales. Acetato de ulipristal (UPA) 30 mg, con mayor eficacia, hasta 120 horas postcoitales, y en último lugar el DIU de cobre, que es la opción más efectiva y además proporciona anticoncepción a largo plazo (opción 2 verdadera). No está indicado el cribado rutinario de trombofilia, dislipemia ni citologías anuales antes de prescribir anticonceptivos orales en mujeres jóvenes sin factores de riesgo. El cribado de trombofilia solo se recomienda en mujeres con antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica venosa. La citología cervical se recomienda según los protocolos de cribado poblacional habitual, no

anualmente por el uso de anticonceptivos. La dislipemia solo se evalúa si existen factores de riesgo cardiovascular. Merece la pena recordar que la única exploración esencial y obligatoria en todas las circunstancias para el uso seguro y eficaz de método anticonceptivo, en concreto con el uso de anticonceptivos hormonales combinados, es la toma de tensión arterial y la realización de una exploración pélvica en caso de plantear un DIU (opción 3 falsa). Los anticonceptivos de segunda generación (etinilestradiol, levonorgestrel) presentan un menor riesgo trombótico. Los de tercera (desogestrel, gestodeno y norgestimato) y cuarta generación (drospirenona, dienogest, acetato de ciproterona) tienen un mayor riesgo de TEV. Es clave evaluar antecedentes personales y familiares de trombosis antes de su prescripción (opción 4 verdadera).

188. ¿Cuál de los siguientes fármacos debería evitarse en un paciente que presenta diabetes y obesidad por ser un fármaco que puede inducir aumento de peso?

1. Metformina.
2. Sitagliptina.
3. Semaglutida.
4. Pioglitazona.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. La pioglitazona es un fármaco que provoca aumento ponderal, por lo que tiene su utilidad en pacientes con bajo peso o caquexia diabética. La metformina y sitagliptina son aproximadamente neutros (pueden provocar una leve pérdida de peso, inferior a medio kilo), mientras que la semaglutida es uno de los fármacos indicados como primera línea en manejo de obesidad por su importante efecto adelgazante.

189. Hombre de 69 años con adenocarcinoma de páncreas avanzado que presenta como principal sintomatología dolor de características mixtas tratado desde hace 3 meses con opioides con buen control (morfinina 60 mg cada 12 horas) + adyuvantes (duloxetina 60 mg/día). Asocia astenia e hiporexia graves tratadas con corticoides desde hace 2 semanas (dexametasona 8 mg/día). Acude a consulta refiriendo somnolencia intensa y alucinaciones táctiles. En la analítica presenta como datos más destacables anemia de trastornos crónicos (Hb 10,6 g/dL) y empeoramiento de la función renal (CKD-EPI 26 mL/min). ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la actitud a seguir?

1. Clínica neurológica por metástasis cerebrales. Realizar TC cerebral y aumentar dosis de corticoides.
2. Psicosis inducida por corticoides. Retirar corticoides.
3. Síndrome confusional agudo hipoactivo. Iniciar tratamiento con neurolépticos.

4. Neurotoxicidad por opioides. Reducir la dosis de morfina a la mitad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta compleja en forma de caso clínico. La respuesta correcta es la 4. Se trata de un caso de NIO (neurointoxicación por opioides), cuadro no infrecuente, probablemente desencadenado por la caída de filtrado glomerular. La toxicidad por opioides produce a nivel neurológico aumento importante de somnolencia. Además, son muy típicas las mioclonías, puede desencadenar delirium y en ocasiones aparecen alucinaciones. La toxicidad se facilita si hay deshidratación, edad avanzada, polifarmacia, comorbilidad, dosis altas de opioides y/o subidas rápidas de la dosis, y uso de opioides con metabolitos activos (p. ej.: morfina). El factor más importante, no obstante, para su aparición es el fracaso renal. La respuesta 1 podría ser correcta pero no es lo más probable, ya que las metástasis SINTOMÁTICAS suelen producir focalidad neurológica. La respuesta 2 es poco probable; la psicosis inducida por corticoides es poco frecuente y suele aparecer con dosis altas en tiempo más prolongado. La 3 es incorrecta pues el delirium suele aparecer de forma aguda y tiende a ser fluctuante en el día. A pesar de ello, todas las posibilidades planteadas entrarían en el diagnóstico diferencial. Aun así, la causa más probable por la clínica, el tratamiento de base y el fracaso renal como desencadenante es la neurotoxicidad.

190. Hombre de 36 años sin antecedentes de interés que ingresa en observación de urgencias en espera de intervención quirúrgica por fractura de fémur a nivel diafisario por accidente de tráfico. El paciente llega algo taquicárdico 102 lpm, con gafas nasales para mantener saturación de oxígeno en torno al 96%, 20 respiraciones por minuto y presión arterial 100/60 mmHg. Se procede a ajuste de analgesia y a las 20 horas de estancia en observación indican que el paciente puede ir a quirófano pero presenta un aumento de disnea con saturación del 89% con mascarilla tipo Venturi, 28 respiraciones por minuto, taquicardia a 110 lpm, fiebre de 38°C y se encuentra algo obnubilado. En la analítica destaca anemia y trombocitopenia. No presenta aumento de volumen en ninguna de las dos piernas. ¿Qué prueba complementaria tiene mayor sensibilidad y especificidad para la sospecha diagnóstica de este paciente?

1. AngioTC helicoidal con contraste.
2. Gammagrafía pulmonar de perfusión.
3. Radiografía de tórax.
4. Ecocardiografía.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta interesante pregunta presenta el caso de un paciente que sufre, 20 horas después de un accidente de tráfico

con fractura diafisaria de fémur, fracaso respiratorio agudo junto con fiebre, obnubilación, anemia y trombopenia. Este cuadro es altamente sugestivo de embolia grasa, un cuadro raro provocado por la migración y embolismo de glóbulos de grasa a la circulación pulmonar y sistémica. Se asocia a fracturas de huesos largos (especialmente de fémur) y pelvis, aunque también se han descrito algunos casos no relacionados con traumatismos. Suele presentarse 24-72 horas después de la fractura. La tríada clásica incluye hipoxemia, alteraciones neurológicas (como confusión o convulsiones) y erupción petequeal. El diagnóstico es eminentemente clínico, pudiendo asumirse cuando se presenta la tríada clásica de hipoxemia, anomalías neurológicas y erupción petequeal en un contexto clínico apropiado, habiendo descartado razonablemente otras causas de deterioro respiratorio más habituales. La angioTC torácica no es un requisito imprescindible para el diagnóstico, pero suele requerirse para excluir otras complicaciones con síntomas similares como el tromboembolismo pulmonar, siendo la prueba más sensible y específica para evidenciar el embolismo graso (opción 1 correcta). Cuando hay síntomas neurológicos, se recomienda además solicitar neuroimagen (TC o RM cerebral). El tratamiento es en gran medida de soporte. Los esteroides sistémicos se han empleado en casos graves o refractarios, aunque su eficacia es controvertida.

191. Hombre de 72 años sin alergias medicamentosas, no fumador y con antecedentes de hipertensión, dislipemia y diabetes. En tratamiento con ácido acetilsalicílico, atorvastatina, enalapril y metformina. Acude a urgencias por agudización de lumbalgia crónica de meses de evolución. Refiere que el dolor no es irradiado, y no mejora mucho en reposo. Ha tomado varios analgésicos sin ninguna mejoría. A la exploración no presenta dolor en espinas dorsolumbares, el signo de Lasegue es negativo, no presenta limitación a la movilidad, reflejos normales y no hay alteración de sensibilidad o fuerza. Pulsos pedios ausentes y tibiales débiles. No edemas de miembros inferiores. Ante la sospecha diagnóstica, ¿qué prueba nos daría el diagnóstico más rápidamente con mayor sensibilidad y especificidad?

1. Ecografía abdominal.
2. TC toraco-abdominal.
3. Resonancia magnética.
4. Radiografía de columna lumbosacra.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos piden realizar el diagnóstico diferencial de la lumbalgia de origen neurológico o de causa vascular. La lumbalgia, así como la claudicación, puede tener causa neurológica o vascular. De hecho, la ruptura de un aneurisma abdominal en muchas ocasiones puede simular una lumbociática o cursar como una lumbalgia, dado que la tríada clásica de dolor, hipotensión y masa pulsátil solo se presenta en un número bajo de pacientes. En esta pregunta nos presentan un pa-

ciente vasculópata con una lumbalgia sin datos de alarma y que en la exploración física presenta pulsos pedios ausentes. Ante esta clínica, y con este signo a la exploración, lo primero a sospechar debe ser la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal, y por tanto la siguiente prueba a solicitar será una TC tóraco-abdomino-pélvica. Pedir una resonancia estaría indicado en una lumbalgia con datos de alarma, pero en este caso, con el hallazgo de pulsos pedios ausentes, debemos priorizar otras pruebas que nos permitan descartar patología valvular aórtica.

192. Acude a urgencias un hombre de 34 años, sin diagnósticos previos, con antecedente de consumo de drogas por vía parenteral, con fiebre, tos no productiva y disnea progresiva de varias semanas de evolución. Se realiza radiografía de tórax que muestra infiltrado intersticial bilateral. En analítica sanguínea destaca linfopenia y lactato deshidrogenasa elevada. La saturación de oxígeno es del 88% respirando aire ambiente en reposo. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones le parece INCORRECTA?

1. Iniciaría tratamiento de soporte, oxigenoterapia y ceftriaxona.
2. Iniciaría tratamiento con Trimetoprim/sulfametoxazol, corticoides y oxigenoterapia.
3. Solicitaría serología del virus de la inmunodeficiencia humana.
4. Solicitaría estudio microbiológico de esputo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso típico de neumonía por *Pneumocystis*: paciente con antecedentes de uso de drogas por vía intravenosa con clínica de neumonía atípica subaguda, que presenta en la analítica linfopenia y elevación de LDH. Todo esto nos hace pensar en que se trate con mayor probabilidad de un paciente VIH no diagnosticado con neumonía por *Pneumocystis* (opción 3 y 4 cierta). El tratamiento se realiza con cotrimoxazol, y en caso de insuficiencia respiratoria se deben administrar corticoides (opción 2 cierta). Por lo tanto, la opción falsa es la opción 1.

193. Hombre de 46 años sufre accidente de tráfico a alta velocidad con varios vuelcos del vehículo y necesidad de extricación por parte del equipo de bomberos. El paciente es trasladado en una UVI móvil al servicio de urgencias más próximo, con inmovilización en colchón de vacío. A su llegada al hospital se encuentra inestable a pesar de sueroterapia intensiva. A la exploración presenta los siguientes signos vitales: frecuencia respiratoria 35 rpm. Saturación de oxígeno 100% con mascarilla reservorio. Frecuencia cardíaca 140 lpm. Presión arterial 60/30 mm Hg. Temperatura 35.5°C y glucemia 110 mg/dL. De las siguientes, indique la exploración o prueba complementaria clave del árbol de decisión en este paciente:

1. Hemograma y bioquímica.
2. TC abdominal.
3. e-FAST (Extended Focused Abdominal Sonography for Trauma).
4. Punción lavado peritoneal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta con concepto preguntado de forma similar en MI-Res anteriores. Se trata de un paciente joven inestable con shock hipovolémico: hipotensión (60/30 mmHg), taquicardia (140 lpm), taquipnea (35 rpm), e hipotermia leve (35,5°C). La prueba e-FAST permite detectar en minutos líquido libre abdominal, siendo ideal para pacientes inestables por su rapidez y realización a pie de cama. La TC abdominal aporta mucha información pero requiere que el paciente esté razonablemente estable para su realización (no es la primera prueba en el paciente inestable), dado que debe trasladarse al paciente fuera de la sala de emergencias para llevarla a cabo.

194. En un paciente diagnosticado de una lesión tumoral sea maligna que ha recibido tratamiento neoadyuvante, se realiza resección de la pieza y posterior biopsia para su análisis anatomopatológico. Indique, de las siguientes, cuál es la información más relevante para el pronóstico del paciente?

1. Tasa de necrosis en la pieza por efecto de terapia neoadyuvante.
2. Número de células tumorales en fase G0 de no división o interfase.
3. Porcentaje de células gigantes que se encuentran en la lesión.
4. Cantidad de células no estromales que componen el tumor.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La tasa de necrosis tumoral en la pieza de resección quirúrgica (opción 1) es el factor pronóstico más importante tras la quimioterapia neoadyuvante, especialmente en osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Se considera buena respuesta cuando la necrosis tumoral es MUY alta ("ha hecho mucho efecto la quimioterapia"), más del 90% en osteosarcoma y cercano al 100% en sarcoma de Ewing, lo que se asocia con menor riesgo de recidiva local, metástasis, y mayor supervivencia global. Los pacientes con necrosis inferior a esos valores tienen peor pronóstico, independientemente de que la cirugía haya sido correcta.

195. Mujer de 60 años que acude al hospital por hematuria, mal estado general y fiebre. Se orienta clínicamente de insuficiencia renal progresiva y se decide realizarle una biopsia renal donde se observa una glomerulonefritis necrotizante con reacción extracapilar (semilunas) que afecta a más del 50% de los glomérulos. La inmunofluorescencia directa es negativa. Hay un dato del laboratorio de inmunología que nos

ayudará a confirmar el diagnóstico, pero ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Glomerulonefritis pauciinmunitaria.
2. Nefritis tubulointersticial.
3. Síndrome de Goodpasture.
4. Nefropatía IgA.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Mujer con cuadro de insuficiencia renal progresiva de probable origen glomerular (hematuria) acompañante, con semilunas en la biopsia (GN rápidamente progresiva) pero con inmunofluorescencia negativa. Estamos, por lo tanto, ante una GNRP tipo III o "pauciinmune" (respuesta 1 CORRECTA). Recuerda que la determinación de inmunología que nos ayudará a confirmar el diagnóstico es la positividad en sangre de ANCA (habitualmente p-ANCA/Anti-MPO).

196. Niño de 3 años de edad con antecedentes de dermatitis atópica leve, sin alergias conocidas. Acude a la consulta con su madre quien comenta que en la última semana le han aparecido unas lesiones en la piel de la cara y la región glútea. Estas lesiones comenzaron como pequeñas máculas eritematosas que en pocos días pasaron a vesículas y erosiones superficiales cubiertas por costras amarillentas y que han ido aumentando en número y tamaño, extendiéndose rápidamente a la piel de alrededor. Ha estado rascándose las lesiones, lo que parece haberlas empeorado. También comenta que en la guardería hay otros niños que han presentado lesiones similares en la piel. El niño tiene buen estado general y no tiene fiebre, solo se queja de picor en las lesiones. Ante este cuadro clínico, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Impétigo contagioso.
2. Molluscum contagioso.
3. Infección por herpes virus.
4. Candidiasis mucocutánea.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de respuesta directa en la que nos presentan un caso típico de impétigo contagioso. La presencia de costras melicéricas de distribución periorificial y el contexto epidemiológico son muy sugestivos de la enfermedad.

197. Hombre de 50 años que acude a la consulta por una lesión pigmentada en su pierna derecha que ha cambiado de tamaño y color en los últimos 4 meses. La lesión es de 8 mm de diámetro, asimétrica, con bordes irregulares y con varias tonalidades de marrón y negro. Además, refiere prurito ocasional en la zona. No tiene antecedentes personales de cáncer, ni otros de interés, pero su madre fue diagnosticada de melanoma a los 60 años. Se realiza una

dermatoscopia que revela un patrón de red irregular, puntos negros, áreas de regresión y vasos sanguíneos irregulares. ¿Cuál es el manejo más apropiado?

1. Biopsia mediante punción de la parte más pigmentada de la lesión para confirmar el diagnóstico.
2. Biopsia mediante escisión completa con márgenes quirúrgicos de 2 mm y estudio histopatológico.
3. Monitorización de la lesión con dermatoscopia digital y seguimiento en 3 meses.
4. Terapia fotodinámica para reducir el tamaño de la lesión antes de realizar una biopsia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico en el que nos presentan un paciente con antecedentes familiares de melanoma y una lesión pigmentada que cumple todos los criterios clínicos de la regla ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color no homogéneo, diámetro >6 mm y cambios evolutivos recientes. Además, nos dan criterios dermatoscópicos que refuerzan la sospecha de malignidad: retículo pigmentado atípico, estructuras de regresión y vascularización irregular. Ante cualquier lesión cutánea sospechosa de melanoma debe realizarse una biopsia excisional con un margen estrecho (entre 1 y 3 mm) con el objetivo de llegar a un diagnóstico histológico. El único caso en el que estaría justificado realizar una biopsia incisional previa es ante lesiones grandes de localización cráneo-facial, acral o genital. El control clínico estrecho podría plantearse ante una lesión dudosa, pero no en una lesión tan sugestiva de malignidad como la que nos describen. La terapia fotodinámica no está indicada en el tratamiento del melanoma.

198. Una lactante prematura de 32 semanas, consulta al mes de nacimiento por 3 hemangiomas infantiles superficiales que han crecido en las 2 últimas semanas en el antebrazo derecho, en el tórax y en la espalda. Respecto a los hemangiomas infantiles que presenta la paciente, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Tienen 3 fases evolutivas: una fase proliferativa en la que la lesión crece aceleradamente, un periodo de estabilidad y una fase involutiva.
2. Suponen la única lesión positiva para el marcador GLUT-1 (proteína transportadora de glucosa).
3. Es necesario realizar estudios de imagen (la ecografía sería la técnica de elección) por el riesgo aumentado de hemangiomas a nivel visceral.
4. La mayoría de los hemangiomas infantiles tiene un curso clínico predecible por lo que, si no hay compromiso funcional ni estético, una opción válida es no tratar a estos pacientes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuestión sobre la presencia de hemangiomas en recién nacidos, quedando definidas bien sus características salvo con la opción 3, ya que nuestro paciente por número de lesiones no cumple criterios de hemangiomatosis neonatal. Por dicho motivo, en ella no aplica realizar pruebas de imagen; opción incorrecta a marcar la 3.

199. Hombre de 45 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia, hígado graso y esclerosis múltiple y en tratamiento con fingolimod, enalapril y simvastatina, presenta una psoriasis con afectación de más del 10% de la superficie corporal y un índice de la severidad del área de psoriasis (PASI) de 14. Había realizado previamente tratamiento con acitretina durante 15 meses con escasa mejoría. El paciente pregunta por otra alternativa terapéutica que consiga mejorar su psoriasis. ¿Cuál considera que es la mejor opción de tratamiento?

1. Fototerapia.
2. Biológico con mecanismo de acción anti-TNF (factor de necrosis tumoral).
3. Ciclosporina.
4. Biológico con mecanismo de acción anti-Interleucina 23.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil que requiere conocer bien los efectos adversos y contraindicaciones de los distintos tratamientos del paciente. El fingolimod aumenta el riesgo de cáncer cutáneo, por lo que estos pacientes deben recibir fotoprotección y el tratamiento con fototerapia, tanto UVB como PUVA, está contraindicado por ficha técnica. Los anti-TNF se desaconsejan en pacientes con esclerosis múltiple, pues se ha descrito el agravamiento de la enfermedad desmielinizante. Por último, entre los efectos adversos de ciclosporina se encuentra el aumento de la presión arterial, por lo que no sería la mejor opción de tratamiento en un paciente con hipertensión arterial. Por todo ello, la opción correcta es la 4.

200. Indique, de los siguientes, ¿cuál es un criterio de malignidad radiológica de los tumores óseos?

1. Esclerosis perilesional reactiva.
2. Presencia de calcificaciones puntiformes en el interior de la estructura ósea.
3. Rotura de la cortical ósea.
4. Localización epifisaria del tumor por la posibilidad de afectación de la articulación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla pero difícil por lo específico del tema. La rotura de la cortical ósea (opción 3) es un signo radiológico altamente sugestivo de malignidad, ya que indica comportamiento agresivo y capacidad del tumor para invadir tejidos

circundantes. Es típica de lesiones malignas primarias como osteosarcomas o sarcomas de Ewing, así como de metástasis. Las opciones incorrectas representan características habitualmente benignas. La esclerosis perilesional reactiva (opción 1) define un patrón geográfico bien definido; las calcificaciones puntiformes (opción 2) son típicas de encondromas y condroblastomas (aunque también podría observarse en tumores malignos); y la localización epifisaria (opción 4) suele ser localización de tumores benignos localmente agresivos (pero benignos), como el condroblastoma o el tumor de células gigantes.

201. En la enfermedad por arañazo de gato, señale la INCORRECTA:

1. En los casos sin manifestaciones sistémicas de la enfermedad es suficiente con tratamiento tópico.
2. Para el diagnóstico es necesaria la práctica de una serología.
3. Si se precisa tratamiento antibiótico, se recomienda azitromicina 500 mg en una dosis inicial y 250 mg cada 24 horas durante 4 días más.
4. La mayoría de los casos curan de forma espontánea en semanas o meses sin tratamiento de ningún tipo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre Bartonella en la enfermedad por arañazo de gato. En el 80% de los casos se produce involución espontánea en menos de 6 meses (opción 4 cierta). Por lo tanto, en muchas ocasiones (sin afectación sistémica) no es necesario la administración sistémica de antibióticos, siendo suficiente tratamiento sintomático local (opción 1 cierta). En caso de precisar antibiótico sistémico, se recomiendan la azitromicina, la doxiciclina o la rifampicina (opción 3 cierta). Con respecto a la opción 2, aunque puede hacerse diagnóstico serológico, existen otros tantos métodos microbiológicos válidos para ello: la visualización en tejidos afectos de microorganismos con la tinción argéntica de Warthin-Starry o la realización de PCR (opción 2 falsa). La dificultad de esta pregunta está en la redacción e interpretación de las opciones 1 y 2. La opción 2 es demasiado "cerrada" para ser cierta (aunque la serología es un método válido). La opción 1 podría interpretarse como falsa al no ser precisa la administración de antibiótico tópico porque en la mayoría de los casos sin afectación sistémica se resuelven de forma espontánea.

202. Hombre de 45 años que refiere desde hace 3 meses dolor en codo derecho irradiado a antebrazo, no asociado a parestesias ni sensación subjetiva de pérdida de fuerza. La intensidad del dolor va empeorando a lo largo del día, principalmente con trabajo de ordenador y con actividades deportivas. A la exploración física no se observan signos inflamatorios externos,

presenta dolor a la palpación de epitroclea humeral y se reproduce su dolor al distender y resistir la musculatura flexora de antebrazo y mano. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Epicondilopatía medial.
2. Epicondilopatía lateral.
3. Síndrome compartimental crónico.
4. Neuropatía cubital por atrapamiento en canal epitrocleo-olecraniano.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El paciente presenta dolor en la región medial del codo que empeora con actividades que sobrecargan la musculatura flexora. La epitrocleitis o epicondilopatía medial (opción 1) es el diagnóstico más probable dada la clínica (dolor a la palpación de la epitroclea y con la distensión y resistencia de la musculatura flexora). La epicondilopatía lateral o epicondilitis (opción 2) afecta la cara lateral del codo y empeora con la extensión de muñeca resistida, no con la flexión como en este caso. El síndrome compartimental crónico (opción 3) cursa con dolor, tras el ejercicio o sobreuso, localizado en compartimento o vientre muscular, no en zonas tendinosas, y es mucho menos frecuente. La neuropatía cubital (opción 4) incluiría parestesias en el territorio del nervio cubital (4º y 5º dedos), que no están presentes en este caso.

203. Hombre de 57 años con buen estado general, tiene un PSA de 13 ng/mL y tacto rectal pétreo. El estudio diagnósticos revela cáncer de próstata de alto riesgo, Gleason 9, metastásico, con afectación ósea (más de 8 lesiones en el esqueleto axial) y metástasis hepáticas. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento inicial indicado en la actualidad?

1. Prostatectomía radical con linfadenectomía extendida y resección de las metástasis.
2. Radioterapia externa pélvica y radioterapia estereotáctica de las metástasis.
3. Braquiterapia pélvica de alta tasa.
4. Antiandrógenos inicialmente más análogos de la LHRH + enzalutamida + docetaxel.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan a un paciente ya diagnosticado de cáncer de próstata metastásico de alto volumen, con varias metástasis a nivel óseo y hepático. En estos casos el tratamiento indicado es castración o bloqueo hormonal con antiandrógeno inicial (para evitar el fenómeno de flare-up), combinado con análogo LHRH, docetaxel y enzalutamida: el llamado “triple”, indicado para pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible de alto volumen.

204. Gestante de 36 años primigesta sin factores de riesgo excepto índice de masa corporal de 32 pregestacional, que acude a urgencias a las 28 semanas y presenta una rotura prematura de membranas. En el momento del ingreso la analítica es normal, no presenta dinámica uterina y la longitud cervical es de 38 mm. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

1. Iniciaremos maduración pulmonar fetal con corticoides.
2. Se realizará profilaxis de corioamnionitis mediante antibioterapia endovenosa.
3. Se iniciará neuroprotección fetal.
4. Se iniciará profilaxis tromboembólica con heparina de bajo peso molecular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

“En una gestante de 36 años, primigesta, con un IMC de 32 y rotura prematura de membranas (RPM) a las 28 semanas, sin dinámica uterina y con analítica normal, se deben seguir las recomendaciones basadas en la evidencia para optimizar los resultados materno-fetales. Analicemos cada opción: - OPCIÓN 1 (verdadera): se inicia maduración pulmonar fetal con corticoides (betametasona o dexametasona) en gestaciones entre 24 - 34+6 semanas con riesgo de parto prematuro. - OPCIÓN 2 (verdadera): está indicado administrar antibioterapia profiláctica para prevenir la corioamnionitis y prolongar la gestación en caso de RPM pretérmino hasta semana 34+0. Se recomienda ampicilina iv + ceftriaxona iv + claritromicina vía oral con el fin de cubrir los gérmenes más frecuentes, en este caso Ureaplasma, SGB y bacilos gram negativos. Esta estrategia ha demostrado reducir la incidencia de infección materno-fetal y el riesgo de parto prematuro según las últimas recomendaciones de la SEGO. - OPCIÓN 3 (INCORRECTA): la neuroprotección fetal con sulfato de magnesio solo está indicada cuando el parto es INMINENTE antes de las 32 semanas. En este caso, la paciente no tiene dinámica uterina y la longitud cervical es de 38 mm, lo que indica que no parece que de momento se vaya a desencadenar el inicio del trabajo de parto. - OPCIÓN 4 (verdadera): la profilaxis tromboembólica con heparina de bajo peso molecular (HBPM) sí estaría indicada en esta paciente, ya que el embarazo y el IMC de 32 la sitúan en un grupo de mayor riesgo tromboembólico. La tromboprofilaxis en gestantes hospitalizadas es una práctica habitual, especialmente si hay inmovilización o factores de riesgo adicionales. Aunque no se menciona que esté inmovilizada, su hospitalización por RPM y el IMC elevado justifican el uso de HBPM.”

205. ¿Qué autoanticuerpos en las miopatías inflamatorias deberían alertarnos de un curso agresivo de una neumonía intersticial asociada?

1. Anti-TIF-1.
2. Anti MDA-5.
3. Anti-Mi2.
4. Anti-PM/SCL.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de dificultad media sobre la asociación entre anticuerpos y fenotipo clínico en las miopatías inflamatorias. Los anticuerpos anti MDA-5 se relacionan con un fenotipo de dermatomiositis con alto riesgo de desarrollar una afectación pulmonar intersticial grave rápidamente progresiva (opción 3 correcta); además, la afectación muscular suele ser leve o inexistente (amiopática) y es típico encontrar lesiones cutáneas tipo úlceras. Los anti-Mi2 se relacionan con el fenotipo clásico de dermatomiositis. Los anti-TIF1gamma se relacionan con una dermatomiositis con alto riesgo de neoplasia. Estos 3 son anticuerpos específicos de miositis. Por el contrario, los anti PM/SCL son anticuerpos asociados a miositis (no específicos) y se relacionan con la aparición de un síndrome de solapamiento polimiositis + esclerosis sistémica.

206. Avisan de paritorio por recién nacido pretérmino tardío (35+3 semanas de edad gestacional) sin otros factores de riesgo. Al nacimiento no presenta esfuerzo respiratorio y se decide monitorización con pulsioximetría. No inicia esfuerzo por lo que a los 30 segundos se ventila con presión positiva intermitente (VPPI) (presión inspiratoria 20 cm H₂O y PEEP 6 cm H₂O y FiO₂ 0.21) durante 1 minuto. Inicia llanto y esfuerzo respiratorio pero con signos de dificultad respiratoria en torno a los 3 minutos de vida con cianosis asociada. En la monitorización presenta frecuencia cardíaca de 170 lpm y Sat O₂ del 75%. ¿Cuál es su actuación en este momento?

1. Retirar soporte respiratorio y aumento aporte de oxígeno.
2. Mantener VPPI y fracción inspirada de oxígeno al 21%.
3. Pasar a modalidad presión positiva continua y aumento aporte de oxígeno.
4. Pasar a modalidad presión positiva continua y fracción inspirada de oxígeno al 21%.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta compleja sobre la reanimación neonatal que precisa “algo más”, ya que el recién nacido presenta un cuadro de dificultad respiratoria ante el cual se van siguiendo los pasos adecuados hasta que con el soporte convencional el paciente tampoco termina de mejorar. Ante ello, con una frecuencia cardíaca de 170 lpm y saturación de 75%, se debe iniciar terapia con CPAP (presión positiva continua) sin necesidad de aumentar la FiO₂ y dar margen a su recuperación así; opción correcta 4.

207. En relación con el estudio de la causalidad en epidemiología, solo uno de los siguientes es un criterio o consideración causal de Bradford Hill. Señálelo:

1. Gradiente biológico (relación dosis-respuesta).
2. Ausencia de sesgos.
3. Ausencia de confusión.
4. Significación estadística de la asociación.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta directa acerca de los Criterios de Bradford Hill, recordad que buscan explicar una relación de causalidad, ya que “la asociación no implica causalidad”. Son los siguientes: secuencia temporal (único imprescindible), fuerza de asociación, efecto dosis-respuesta (gradiente biológico), consistencia, coherencia, plausibilidad biológica, especificidad de asociación, analogía y demostración experimental (RC 1). Por ello, no son criterios la ausencia o presencia de sesgos, confusión o significación estadística.

208. Hombre de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, así como un accidente isquémico cerebral transitorio 2 años antes. Hospitalizado actualmente tras presentar un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST). En la coronariografía se observa enfermedad arterial coronaria multivaso no revascularizable. En la analítica la función renal es normal, sin anemia. ¿Cuál es el tratamiento antiagregante que debiera recomendarse como primera opción?

1. Ácido acetilsalicílico 100 mg/día de forma indefinida.
2. Ácido acetilsalicílico 100 mg/día de forma indefinida y clopidogrel 75 mg/día durante 1 año.
3. Ácido acetilsalicílico 100 mg/día de forma indefinida y ticagrelor 90 mg/día durante 1 año.
4. Ácido acetilsalicílico 100 mg/día de forma indefinida y prasugrel 5 mg/día durante 1 año.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta puesta para pillar y no para demostrar un adecuado conocimiento cardiológico. Tras un síndrome coronario agudo, debe pautarse ácido acetilsalicílico a dosis antiagregante de forma indefinida y un inhibidor de P2Y₁₂ durante 12 meses. El inhibidor de P2Y₁₂ de elección en el síndrome coronario agudo es prasugrel; dentro de sus contraindicaciones, la principal es la presencia de un ictus o AIT previo. En este paciente, con un AIT previo, no podemos pautar prasugrel, y el inhibidor de P2Y₁₂ de elección sería por lo tanto ticagrelor (tanto ticagrelor como prasugrel son superiores a clopidogrel). El problema en este caso con ticagrelor es que la dosis que se plantea es incorrecta (se administra 90 mg/12h, no cada 24h). Así, la única opción posible que nos queda es pautar clopidogrel, el peor inhibidor de P2Y₁₂ de todos, porque es la única respuesta que no tiene fallos.

209. Hombre de 34 años con poliposis intestinal y manifestaciones extraintestinales como hipertrofia congénita de retina y osteomas mandibulares. Para hacer el diagnóstico genético se debe analizar el gen:

1. Gen MYH.
2. Gen PTEN.
3. Gen APC.
4. Gen p53.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clásica de MIR. Se trata de una poliposis que asocia hipertrofia pigmentaria de la retina (concepto repetido en MIR 2025 y MIR 2016), es decir, una poliposis adenomatosa familiar, resultado de mutaciones en el gen APC. En algunas familias, la PAF asocia osteomas, fibromas y tumores desmoides; cuando esto ocurre, se le ha dado clásicamente el nombre de síndrome de Gardner.

210. Acude por primera vez a la consulta una paciente de 17 años con anorexia nerviosa de un año de evolución. En la exploración física y analítica son característicos los siguientes signos EXCEPTO:

1. Lanugo.
2. Taquicardia.
3. Hipopotasemia si existen conductas purgativas como los vómitos o el uso de laxantes.
4. Disminución de hormonas gonadotrofinas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Todos los síntomas que describen son típicos de la anorexia, salvo la taquicardia, apareciendo bradicardia en las pacientes con anorexia.

